

MMPI

Değerlendirme Kitabı

Doç. Dr. Birsen CEYHUN

Uz. Psk. Nursen ORAL

Ankara 1998

BİLİMSEL TIP YAYINEVİ

MMPI Değerlendirme Kitabı
ANKARA, 1998

- © Bu kitabın tüm yayın hakları yazarlarına aittir.
Kitabın hiçbir bölümü izinsiz olarak çoğaltılamaz.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

BİLİMSEL TIP YAYINEVİ

Adres: Bükreş Sokak No: 3/20
Kavaklıdere-ANKARA
Tel : (0 312) 426 47 47
Faks : (0 312) 426 93 93

ÖNSÖZ

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterine ilişkin bu kitabın farklı amaçlara hizmet etmesi düşünülmüştür. Bunlardan bir tanesi MMPI'ı ilk kez kullanacak olan kişilere testin yapısını anlatmak ve uygulamasında yardımcı olmaktır. Diğer bir amacı ise klinik alanda çalışan psikologların MMPI testini değerlendirmelerinde ve rapor yazımlarında yardımcı bir araç olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda MMPI testi değerlendirme amacıyla bireye verildikten sonra testi değerlendirecek olan psikolog elindeki ders notlarından, fotokopilerden ya da İngilizce kitaplardan yararlanmaktaydı. Bu değerlendirmede başvurulmuş kaynakların alana hizmet etmede yetersiz kaldığını klinik yaşantılarımızda sıklıkla yaşadık. Dört yıllık bir çalışmanın emeği olan kitabın klinik alanda yaşanan bu karmaşayı ve boşluğu biraz da olsa azaltacağını düşünüyoruz.

MMPI kitabı yazılırken değerlendirme ve rapor yazılmasının yanı sıra MMPI'nin değişik formlarının araştırmalarda nasıl kullanıldığı verilmiştir. Ayrıca Türkiye'de yapılan çalışmalardan ulaşılabilenler liste halinde sunulmuştur. MMPI kullanarak araştırma yapabilecek olan kişiler için bu bölümlerin yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Bu kitabı yazarken temel kaynağımız olan MMPI testini Türk toplumuna uyarlayan Sayın hocamız **Prof.Dr. Işık Savaşır**'a ve geçerlik çalışmasını yapan **Doç.Dr. Neşe Erol**'a teşekkür ederiz.

Ayrıca kitabın geçerlik ve klinik değerlendirmelerini okuyarak bize değerli önerilerde bulunan **Doç.Dr. Refia Palabıyıkoglu**'na yardımları için teşekkür ediyoruz.

MMPI vererek değerlendirdiğimiz bütün hastalarımıza.....

Doç.Dr. Birsen CEYHUN
Uzm.Psk. Nursen ORAL

3. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Geçerlik Testlerinin Değerlendirilmesi

Geçerlik testleri sorulara verilen cevapların yeterli ve geçerli oluşunu göstermektedir. Testin ne derece geçerli olduğunu anlamak amacıyla geliştirilmiştir.

(?) Bir şey diyemem alt testi

Cevaplanmayan ya da hem doğru, hem yanlış olarak işaretlenen maddeler bu alt testi oluşturur. Bu yüzden bu alt test diğer geçerlik ve klinik alt testlerinde olduğu gibi belirli test yüksekliğini düşürür. 30 ya da daha fazla maddenin çıkması profili bozar.

Çıkarılan madde sayısını en aza indirmek tercih edilen yoldur. Bireye maddelere yanıt vermesinin öneminin açıklanması faydalı olur. Eğer birey 11 ya da daha fazla soruyu boş bırakmışsa yeniden soruları gözden geçirerek bunları cevaplaması istenir. Yine cevapsız bıraktıkları olursa nedeni sorulur. Bireyin cevaplayamadığı için mi boş bıraktığını yoksa cevaplamak istemediği için mi boş bıraktığını anlamak faydalı olur. (?) Alt testinde güvenilirlik verisi yoktur. Genellikle birçok hasta ancak birkaç maddeyi boş bırakır ve bu sorun yaratmaz. Bu nedenle MMPI'da bu konu, bugüne kadar fazla işlenmemiştir. Bu alt testteki yükselmeler şöyle yorumlanabilir:

Tablo 2: Bir şey diyemem alt testi yorumu

1. Düşük: Ham puan: 0:	Birey tüm soruları cevaplamıştır. Bu puan, çoğunlukla araştırma yapılan gruplarda gözlenir.
2. Normal: Ham puan: 1-5	Birkaç madde cevaplanmamıştır. Dikkat edilecek nokta bu maddelerin tümünün bir alt ölçeğe ait olup olmadığını incelemektir. Eğer durum böyleyse profil saptırılmıştır.
3. Orta: Ham puan: 6-30	Birey pek çok kişiden daha çok maddeyi cevaplamamıştır. Profil bozulabilir. 30 maddeye yakın bir sayıya ulaşınca geçerlik tehlikeye girer.
4. Geçersiz: Ham puan: 31	Kendisi hakkında bilgi vermek

ve üstü

istemeyebilir. Karar verememiştir ya da iletişim kuramaz. Hastadan yeniden cevap kağıdına dönmesi ve ölçeği doldurması istenebilir. MMPI'ı tamamlamayan herkes otomatik olarak bu kategoriye girmez.

Bireye MMPI verilirken isim yazması istenmezse, daha çok anlaşılması güç olanların boş bırakıldığı görülmektedir. Birey seçkisiz olarak 50 cümleyi boş bırakırsa bu, geçerliği, bozmaz. Ancak çeşitli insanlar sadece belli alt testlere ilişkin soruları boş bırakabilir. Ör. Boş bırakılan maddeler şizofreni alt testine denk geliyorsa, değişik bir profil elde edilebilir.

Boş bırakma nedenleri:

1. Bireyin o maddeyi anlayamaması. Örneğin, ergenler evlilik ve cinsellik ile ilgili soruları anlayamadıkları için boş bırakırlar.
2. Testi uygulamadan önce, testi alanla tam bir işbirliği sağlayamama.
3. Testi alan bireyin savunucu davranması.
4. Bireyin alingan ve şüpheli olması.

Bireyin depresyonu varsa test çok uzun ve zor geldiği için boş bırakabilir. Konfüzyonda olan ya da ajitasyonu olan hastalar boş bırakabilirler. Psikopat hastalar isyan halinde boş bırakırlar. Boş bırakmanın yorumu çok zordur, çünkü farklı hasta gruplarında boş bırakma nedenleri farklıdır.

Ne yapılabilir?

1. Testi alan birey ile konuşmak. Soruları genellikle doğru-yanlış diye yanıtlaması gerektiği tekrarlanabilir.
2. Bireye, onu suçlamadan boş bırakma nedenlerini sormak.
3. Tekrar o maddelerin üzerinden geçmek. Bunu savunuculuğu artırmadan yapmak gereklidir.

L (Lie) Alt Testi (Yalan)

L alt testinde 15 madde vardır. Tablo 3'te bu alt testi oluşturan maddelerin numaraları ve puanlandırma yönü gösterilmiştir.

Tablo 3: L alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 15)

Yanlış	15	30	45	60	75	90	105	120	135
	150	165	195	225	255	285			

Erkeklerde ortalama: 6.45, kadınlarda ortalama: 6.00 (Savaşır 1981)

L alt testinde yüksek puan alan bir birey : (Graham 1987)

1. Maddelere dürüst yanıt vermeyerek kendini olduğundan daha iyi göstermeye çalışır.
2. Geleneksel, boyun eğicidir.
3. Basma kalıp düşünür, sorun çözmede de esnekliği yoktur.
4. Stres ve baskıya toleransı azdır.
5. Katı moral değerleri vardır.
6. Kendine aşırı önem verir.
7. Bastırma ve yadsımayı sık kullanır.
8. Kendi motivasyonlarına ilişkin içgörüsü ya çok azdır, ya da hiç yoktur.
9. Kendi davranışının diğer insanlar üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi değildir.
10. Konfüzyonda olabilir.

L alt testinde düşük puan alan bir birey:

1. Maddelere içten yanıt vermiştir.
2. Kendisinde olan küçük kusurlarla ve eksikliklerle yüzleşmede samimidir.
3. Anlayışlıdır, sosyal açıdan kendine güvenir.
4. Güvenlidir, bağımsızdır.
5. Lider rolünde başarılıdır.
6. Güçlü, doğal ve rahattır.
7. Fikirlerini etkili bir biçimde dile getirir.
8. Diğerleri tarafından müstehzi ve alaycı olarak tanımlanır.

L-alt testi, bireyin dürüstlüğü ve samimiyetini gösterir. Bu testi oluşturan maddeler; saldırganlığın, kötü düşüncelerin ve karakterdeki

zayıflıkların inkarıyla ilgilidir. Tüm bu özellikler, bir kültürde en dürüst kişilerde bile görülen özelliklerdir.

Bu alt teste ait 15 madde değerlendirildiğinde, hepsine doğru yanıtı veren bir kişinin, saf ya da oldukça açık, genel olarak erdemli, kültürel olarak tutucu ya da kendini tümüyle haklı gören biri olduğu ortaya çıkar. Genel olarak, kendisinin farkında olan kişiler 4 ya da daha yüksek ham puan alırlar. Bunun dışında kalan kişiler, din adamları gibi vicdanî değerleri ve kültürel kabul edilebilirliği olan ya da iş görüşmelerine katılan ve kendini iyi göstermeye çalışan kişilerdir.

L alt testi değerlendirilirken eğitim ve yaş da dikkate alınmalıdır. Zekâ düzeyi düşük ya da lise ve altı eğitimi olan bireylerde L alt testi 5 T puanı daha yüksektir. Aynı şekilde 50 yaşın üstündekilerde de L maddelerine daha fazla yanıt verme eğilimi olmaktadır. Bu, yaş ile tutuculuk arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Psikolojik olarak sofistیک düşünceye sahip bireyler, özellikle de lise eğitilmiş bireyler kendilerini testin diğer bölümlerinde de erdemli gösterme eğilimi içindedir. Eğitimi yüksek olan bireylerdeki yüksek L değerleri, yargılama eksikliğinin ve başarısızlığın bir göstergesidir.

Minnesota'nın norm grubunda çoğunluğun sapkın cevapları 15., 135. ve 165. maddelerde görülmüştür. Gravit'ın (1970) çalışmasında meslek sahiplerinin, bu üç maddenin yanında 45. ve 255. maddelere sapkın cevap verdikleri belirlenmiştir. L alt testinde 7 ham puan, sapkın davranış şüphesi doğurur. L alt testinin gelişmiş (eğitilmiş, kültürlü) insanları değerlendiremediği anlaşılmıştır. L alt testi psikolojik yönden gelişmişliğin bir testi olarak düşünülebilir. Gelişme düzeyi yükseldikçe L puanı da düşer. Yüksek sosyo-ekonomik sınıftan olanlar çoğunlukla 4'ten fazla L puanı almaz. Bu nedenle L puanı değerlendirilirken eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik düzey göz önünde tutulmalıdır.

69 T puanı ve üstü: Puanlamada hata yapılmış olabilir. "Yanlış" yerine doğru cevaplar sayılmıştır. İki farklı değerlendirme vardır:

1. Bu kişiler sosyal açıdan kabul gören yanıtlar vererek kendini kontrol eden, etkili biri olduğu izlenimi bırakmaya çalışan kişilerdir.
2. Güvenilmez, pasif, uzak duran, kaygılı, içe kapanık kişilerdir. Diğerleriyle ilişki kurmaları zordur. Duruma özgü tepkileri yavaştır. L alt testindeki bu yükselmeye sıklıkla MMPI'nin nevrotik testlerindeki yükselme eşlik eder.

3. Az sayıda kişide "patolojik yalan söylemeyi" gösterir. Bu klinik görünüm psikopat ya da manik hastalara özgüdür. (4 ve 9 alt testlerindeki yükselmeye bakınız.)

64-69 T puanı: Maddeleri gelişigüzel doldurma sonucu ortaya çıkabilir. Diğer geçerlik testleri incelenmelidir. Kişinin kendindeki zayıflıkları inkâr ettiğini gösterir. Böyle kişiler patolojik olarak kendilerini iyi göstermeye çalışırlar; katı, represif ve savunucudurlar. Bu puanlar dinî ve ahlâki inanç ve eğilimleri nedeniyle kendine aşırı kontrol koyan bireylerde görülebilir. Ufak hatalarını bile inkâr etmeye eğilimli olanlar, eğitimsiz olup kendini çok iyi göstermeye çalışanlar, inkâr mekanizmasını sıklıkla kullanan histerik ve hipokondriyaklar, azınlık grupları bu kategoriye girebilir.

59-63 T puanı: Bireyin iyi görünme çabası içinde olduğu düşünülmelidir. Bunlarda sosyal açıdan kabul gören yanıtlar verme eğilimi vardır. Bu bireyler aşırı geleneksel ve sosyal açıdan uyumludurlar.

36-55 T puanı: Bu aralığa ilişkin özgün bir durum tanımlanmamıştır.

35 ve altı T puanı: Tüm maddeler doğrudur denebilir. Bağımsız, kendine güvenen, ufak sosyal hatalarını kabul etmeye hazır kimselerdir. Diğer geçerlik alt testlerinin incelenmesi gerekir. İki farklı değerlendirme olabilir;

Birey ya kendini oldukça patolojik göstermeğe çalışıyordur ya da bağımsız, kendine güvenen, eksikliklerden açıkça bahseden, sosyal kurallara önem vermeyen normal bir insan olabilir.

L alt testi ile klinik alt testlerin ilişkisi:

L alt testi yüksek ve Pa en yüksek alt test ise, bu bireylerin bazı şeyleri inkâr ettiği düşünülmelidir. Yüksek L ile 4 ve 9'da yükselme gözlenmektedir. L puanı yükseldikçe psikotik profil elde etme şansı azalmaktadır. Düşük SED'de L yüksek, yüksek SED'de K yüksek olmaktadır. L alt testi yükseldikçe klinik testler düşmektedir. Bireyin sorunlarını inkâr etmesi L'yi yükseltmektedir. Inkâr, psikopatolojiyi ortaya koymayı engeller. Böylece klinik alt testler düşer. L yükselince, hipokondriazis ve histeri alt testleri de birlikte yükselir. Bazen de hipomaninin yükseldiği görülür. Manik birey, büyüklük ve üstünlük duyguları içinde psikopatolojisini inkâr eder. Sonuç olarak L geçerlik alt testi "inkâr" savunma mekanizmasıyla anlamlı ve yüksek bir ilişki göstermektedir. Genellikle L ile Hs, D, Hy, Pd yükselir. Pa, Pt, Sc, Ma ise düşer. Mf alt testi L'den etkilenmez.

F > 88 => test geçerli

F Alt Testi

F alt testinde 64 madde vardır. F alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 4'de gösterilmiştir.

Tablo 4: F alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 64)

Doğru	Yanlış
14 23 27 31 34 35 40 42 48 49 50 53	56 66 85 121 123 139 146 151 156 168 184 197
200 202 205 206 209 210 211 215 218 227 245 246	247 252 256 269 275 286 291 293
17 20 54 65 75 83 112 113 115 164 169 177	185 196 199 220 257 258 272 276

Erkeklerde ortalama: 8.30, kadınlarda ortalama: 10.11 (Savaşır, 1981)

F alt testinde yüksek puan alan bir birey (Ham puan: 26 ve üstü) (Graham 1987)

1. MMPI maddelerine gelişigüzel bir biçimde yanıt vermiştir.
2. Bütün MMPI maddelerini doğru olarak işaretlemiş olabilir.
3. Eğer hastanede yatan psikiyatrik hastaysa:
 - a. Referans delüzyonları vardır.
 - b. Görsel ve/ya da işitsel hallüsinasyonları olabilir.
 - c. Konuşması yavaşlamıştır.
 - d. İç çekilmiştir.
 - e. Yargılaması bozuktur.
 - f. Tek heceli konuşması vardır.
 - g. Dikkatini toplama süresi kısadır.
 - h. Hastaneye yatırılma nedenleri hakkında bilgi sahibi değildir.
 - i. Klinik açıdan tanısı psikotiktir.
 - j. Ek olarak organik etyoloji belirtileri vardır.

F alt testinde ham puanı 16-25 arasında olan bir birey:

1. Bütün MMPI maddelerine yanlış diye yanıt vermiştir.
2. Simulasyon yapıyor olabilir.
3. Yardım alabilmek için semptomlarını abartıyor olabilir.
4. Test almaya oldukça dirençli olabilir.
5. Kullanılan ölçütlere göre açık psikotik olabilir.

F alt testinde ham puanı 10-15 arasında olan bir birey:

1. Sosyal, politik ya da dini konularda yaşadığı toplumdan oldukça farklı inançlara sahiptir.
2. Klinik açıdan ciddi nevrotik ya da psikotik durumdadır.
3. Ciddi psikopatolojisi yoksa,
 - a. Karamsar
 - b. Sabırsız
 - c. Hassas
 - d. Huzursuz.
 - e. Doyumsuz
 - f. Tutarsız
 - g. İnatçı
 - h. Fırsatçı olabilir.

F alt testinde ham puanı 3-9 arasında olan bir birey:

1. Belli sorun alanlarında yer alan maddelere yanıt vermiştir.
2. Özel sorunlarına karşın yaşamın pek çok alanında etkili bir biçimde işlev görmektedir.

F alt testinde ham puan 0-2 arasında olan bir birey:

1. Çoğu normal insan gibi yanıt vermiştir.
2. Sosyal açıdan uyumludur.
3. Yetersizliğine neden olan bir ruhsal bozukluğu yoktur.
4. İyi bir profil vermek için çaba göstermiştir.

Hathaway ve McKinley'e (1967) göre F alt testi ham puanı 20'yi aşarsa profil geçersizdir. Ancak T değeri 70'i aşan tüm alt testlerin geçersiz olmadığı görülmüştür. Bu, ciddi kişilik bozukluğu ifadesi de olabilir. 25 ham puanı aşarsa testin geçersiz olması gerektiği belirtilmiştir. Önceki araştırmalar davranış bozukluğu olanların T puanlarının 80'i aştığını göstermiştir (Gynther 1961). Ayrıca ciddi psikopatolojinin bu sonuçla ilişkisi olabilir.

80 ve üstü T puanı: F alt testi 90 T puanını aşarsa bu profil dikkatli değerlendirilmelidir. F alt testi yükselme nedenleri şunlar olabilir:

1. İlişki kurmak istememe. Hepsi doğru ya da hepsi yanlış yanıt biçimi
2. Görme ya da okuma güçlüğü nedeniyle anlamada sorun ya da psikotik konfüzyon.
3. Sahte kötülük. Eğer hastanın kendisini kötü göstermede kazançları varsa bu durum ortaya çıkmaktadır. Mahkumiyet, malulen emeklilik...gibi. Simülasyon yapma.

4. Yardım çağırısı profili. 2 ve 7 testleri 6, 8 ve 9 testlerinden yüksektir.
5. Eğer 1 ve 4 alt testleri dışlanırsa açık psikoz ya da ciddi psikopatoloji vardır. 6 ve 8 testleri yükselmiştir. Düşünce bozukluğuna ya da ilişkili klinik semptomlara bakın.

Gynther ve Shimkunas (1965), Blumberg (1967), Gavron, Severson ve Engelhart (1962) T değeri 80'i aşan bireyleri araştırmış ve bunlarda davranış bozukluğu olduğunu saptamışlardır. Ancak seçtikleri örneklem psikiyatriktir. Böylece F testindeki herhangi bir ham puanın, profili geçersiz yapamayacağı belirtilmektedir. F alt testinde T değerleri 80'i aşan bireylerde bu yükselme ile ciddi psikopatoloji arasında anlamlı bir ilişki varmış gibi görülüyorsa da bu MMPI'nin verildiği ortama göre değişik yorumları da içerebilir (Örneğin, cezai örneklemeleri).

Gynther, Altman ve Warbin (1973) F alt testi 98 T puanını aşanları incelemişlerdir. Bunların maddeleri anlamadıkları, referans delüzyonları, işitsel hallüsinasyonları olduğu, dikkatlerini toplayamadıkları, hastanede yatış nedenini bilmedikleri ve psikotik olgular oldukları anlaşılmıştır. Diğer çalışmalar, hastanın tek olarak F alt testi maddelerini incelemiştir. Gynther ve Petzel 1967'de psikotik ve davranış bozukluğu olanların, F alt testindeki ham puanları arasında bir fark olmadığını belirlemişlerdir. Ancak daha sonra incelediklerinde sadece bir maddenin bu iki grubu ayırdığını bulmuşlardır. McKinley, 1965'te suçlu ergenlerde F alt testinin yükseldiğini saptamıştır. Bunun nedenini de bazı F alt test maddelerinin onlar için kesin tepkiler taşımasına bağlayarak açıklamıştır. McKinley, bu tip hastaların sadece belirli maddelere karşı tepki verdiğini söylemiştir. Çünkü bu maddelerin onlar için bir anlamı vardır. Üç profesyonel ve üç amatör kişi suçlu ergenlerde F alt testi maddelerinden 21'ini ayırdederek, bu sorulara doğru cevabın verildiğini gözlemişlerdir. McKinley, aynı zamanda bu 21 maddeyi suçlu ergenlerin normal ergenlere kıyasla daha fazla cevaplandıklarını görmüştür. Bu maddeler özellikle hırsızlık, okulda davranış bozukluğu ve başkalarına zarar vermeyle ilgili maddelerdir. Özetle F alt testinin, suçlu ergenlerin davranış özelliğini ölçtüğü belirtilebilir.

70-80 T puanı: Bireyin ego işlevselliğinde bozulma olduğunun, ilişki kurmak istemediğinin ya da yanlış anlaşıldığını düşünmesinin göstergesidir.

1. Bu aralık psikozdaki hastaları ya da ciddi nevrotik bozukluğu olan kişileri göstermektedir.

2. Bireyin alışılmadık ve geleneksel olmayan düşünce biçimi vardır.
3. Antisosyal ve asi kişilerdir.
4. F alt testinin bu ranjdaki yükselmesine nevrotik ve psikotik testlerdeki yükselme de eşlik ediyorsa birey borderline bir durumdadır.

55-69 T puanı: Birey eğer bu ranjin üst sınırlarında ise negativist, değişken, huysuz ve huzursuzdur. Çeşitli tanı grupları bu ranja girebilir:

Akut nevrozlar ve kişilik bozuklukları

Durumsal stresi olan bireyler

Savunucu psikotikler (K alt testinin yükselmesine bakılmalıdır.)

44-54 T puanı: Birey sadece belirgin maddelere yanıt vermiştir.

1. İlgi alanları daralmıştır.

2. Bireyin psikopatolojiyi, duygusal gerginliği gizlemek istediğini ve direncini gösterir. (Sahte iyilik) Bu hipotezi L ve K alt testlerindeki yükselme desteklemektedir.

Düşük puanlar (T<45): Bireyin savunucu olduğunun göstergesidir. Birey herhangi bir psikopatoloji, gerginlik ya da stresi olmadığı görünümünü vermek istemektedir. ("Sahte iyilik")

K Alt Testi (Düzeltilme)

Bu alt test diğer geçerlik alt testlerine oranla daha az belirgin olan, test almadaki savunucu tutumu ölçmeyi amaçlayan 30 maddeden oluşmuştur. K alt testini oluşturan maddeler ve puanlandırma yönü Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5: K alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 30)

Doğru

96

Yanlış

30	39	71	89	124	129	134	138	142	148	160
170	171	180	183	217	234	267	272	296	316	322
374	383	397	398	406	461	502				

Erkeklerde ortalama: 13.90, kadınlarda ortalama: 13.54
(Savaşır 1981)

K alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)

1. İyi bir profil vermek için gayret sarf etmiştir.
2. MMPI maddelerinin çoğuna yanlış diye yanıt vermiştir.
3. Yeterli, kontrollü ve etkili bir kişi görünümü vermek istemektedir.
4. Utangaç ve çekingendir.
5. Diğer insanlarla duygusal ilişki kurmaktan çekinir.
6. Diğer insanlarda kabul etmediği tutum ve davranışları benimsemez.
7. Kendini anlamaya yönelik içgörüsü azdır.
8. Açık suça yönelik davranışı yoktur.
9. Klinik testlerde yükselmişse psikolojik açıdan ciddi sorunu vardır, kendisi bunun farkında değildir.
10. Eğer psikolojik açıdan ciddi bir sorunu yoksa ego gücü ortalamadan üstündedir ve başka olumlu özellikleri vardır.

K alt testinde ortalama puan alan bir birey:

1. MMPI maddelerine yanıt verirken kendi olumlu ve olumsuz yönleri arasında sağlıklı bir denge kurmuştur.
2. Psikolojik uyumu iyidir.
3. Duygusal bozukluğu olduğuna ilişkin çok az belirti gösterir.
4. Bağımsızdır, kendinden emindir.
5. Günlük yaşamdaki sorunlarla başa çıkabilir.

6. Entellektüel yeterliliği iyidir.
7. İlgi alanları genişlemiştir.
8. İçten, girişimci, çok yönlü ve beceriklidir.
9. Açık fikirlidir, sorunlara mantıklı ve sistematik bir biçimde yaklaşır.
10. Sokulgandır, insanlarla kolay kaynaşır.
11. Çoşkuludur, güzel konuşur.
12. Grup içinde üstün roller alabilir.

K alt testinde düşük puan alan bir birey:

1. MMPI maddelerinin çoğuna "doğru" diye yanıt vermiştir.
2. Kötü bir profil vermek ister.
3. Sorunlarını yardım almak için abartıyor olabilir.
4. Ya açık psikotiktir, ya da organik konfüzyon halindedir.
5. Diğerlerini ve kendini eleştirir, kendinden memnun değildir.
6. Günlük yaşamındaki sorunlarla başa çıkmada yetersizdir.
7. Kendi motifleri ve davranışlarına ilişkin içgörüsü çok azdır.
8. Sosyal açıdan uyumludur.
9. Otoriteye aşırı derecede boyun eğmektedir.
10. Çekingen, içe çekilmiş, yüzeyeldir.
11. Kişisel temposu yavaştır.
12. Sosyal ortamlarda beceriksizdir.
13. Patavatsız ve terstir.
14. Alaycıdır, inandırıcı değildir, kuşkucudur.

Diğer klinik alt testlere K alt testinin eklenmesi üzerinde pek çok araştırmacının çapraz-geçerlik çalışmaları önermesine karşın, bu konu ile ilgili araştırmaların pek az olduğu görülmektedir. K alt testinin düzeltmeleri üzerinde duran araştırmaların cesaret kırıcı sonuçlar verdiği görülmüştür. (Hathaway, Meehl 1951). MMPI çok uzun süredir kullanılmasına karşın, K eklemeli profillerin uygunluğu konusu yeterince araştırılmamıştır.

Ries (1966) tarafından yapılan çalışmada K alt testi puanı 15 ve üstü olan psikiyatrik hastalarla, 15'in altında olan hastalar karşılaştırılmıştır. Bulgular iyileşme oranının 15 ve altı olan grupta anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Klinisyenlerin dikkat etmeleri gereken diğer bir nokta, deneklerin K eklemeli ve eklemesiz durumlarda diğer klinik alt testlerdeki yüksek puan alma durumlarını incelemeye gereğidir.

K alt testinde düşüklük ya da yükseklik, deneklerin sorunlarının farkına varmaları ve sorunların şiddetinin boyutlarıyla ilgilidir. Klinik profillerde K düşük değeri özellikle psikotik alt testlerde (6, 7, 8 ve 9) yükseklikle sonuçlanır. K alt testi yüksekse, klinik alt testlerde düşme

görüldüğü ve nevrotik üçlüde yükselme (1, 2, 3) ya da normal sınırlar içinde profil olasılığı artar. Bu hem yetişkinler, hem de ergenler için geçerlidir.

K alt testi, profili geçersiz yapacak belirgin değerlerin olmadığı tek alt testtir. Klinisyenler K değeri için duyarlı olmalıdır. Örneğin, işe alınma sırasındaki kişilik değerlendirmesinde K değerinin çok düşük olması, psikiyatrik grupta ise çok yüksek olması atipiktir. Deneyin birinde bilinen ve belirgin psikopataloji varsa ve K değeri çok yüksek bulunmuşsa, deneyin psikolojik stres yaratan bir durum karşısında aşırı savunucu olduğu söylenebilir. Psikolojik stresin ne olduğu profilden anlaşılamaz. Bu örneklerde klinik alt testler normal sınırlar içinde ise, denekte altta yatan psikotik bir süreç olup olmadığı araştırılmalıdır.

K alt testinin yorumu bireylerin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyine ve MMPI'yi doldurduğu ortama göre değişir.

72 T puanı ve üstü: Savunucu bireylerdir. Kendilerinde psikolojik sorunlar olduğunu kabul etmezler. Katıdırlar, esnek değildirler. Kendilerindeki sorunları kabul etmek istemezler. Tedaviye yanıt kötüdür.

61-72 T puanı: Bu kişiler kendilerinde ve çevrelerinde olan bozuklukları en aza indirmeye ve görmezden gelme eğilimindedir. Savunmalar artmıştır, içgörü azdır.

Histerik savunmaları olan nevrotikler için bu uygundur. Genelde hipokondriyaklar ve histerikler dışında kalan nevrotikler değerlendirmede savunmalarını göstermezler. Savunmalar abartıldığında bu düzeyde bir yükselme elde edilir.

46-60 T puanı: Bu düzeydeki puanlar dengeli bireyleri göstermektedir. Bu yükselme bireyin ego gücünün iyi olduğuna, olumlu kendilik değerine ve uyuma işaret etmektedir. Bunların psikolojik müdahaleyi istemek için yeterli kişisel kaynakları vardır. Yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen hastalara psikolojik tedavi yarar sağlayabilir. Klinik testler yüksek olsa bile, böyle bir K alt testi puanı, bireyde uygun bir başa çıkma becerisi olduğunu gösterir.

27-45 T puanı: Düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen bireylerde gözlenebilir. Bu hastalar sınırlı kişisel kaynakları ile açıkça ortaya koydukları ciddi sıkıntıları yaşamaktadırlar. Hastaların zayıf kendilik değerleri vardır ve kendilerinden hiç memnun değildirler. Ancak durumlarını değiştirecek gerekli kişilerarası beceri ve niteliklerden yoksundurlar. Alt sosyo-ekonomik düzeyden hastalarda bu yükselme orta

düzeyde bir hastalığı yansıtırken, yüksek sosyo-ekonomik düzeyden sahip hastalarda düşük ego gücü ve daha ciddi sıkıntıyı yansıtır.

1. Ergenlerdeki düşük K puanı sıklıkla onların kimliklerini araştırmasından dolayı olabilir. Benzer bir durum içgörü yönelimi psikoterapiye devam eden bireylerde kendilik değerlerini sorgulamalarında da görülür.

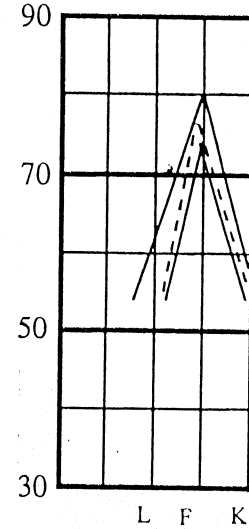
Orta ve üst düzeydeki hastalarda rahatsızlık akuttur. Ego gücü düşmüştür. Savunmalar uygunsuzdur.

2. Genellikle kendine teşhir etme eğilimi içinde olan bireyler. Yardım almak isteğiyle sorunlarını abartan kişilerdir.
3. Hastaneye yatmayı gerektiren akut psikotik sıkıntı yaşayan bireyler olabilirler.

4. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Geçerlik Testleri Konfigürasyonları

Geçerlik konfigürasyonları L, F ve K alt testleri içindir, ? alt testi standart profil kağıdına işaret edilmez.

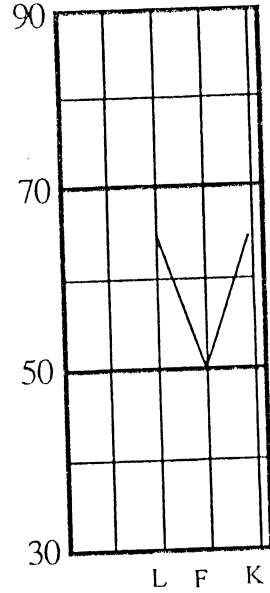
Konfigürasyon 1: L ve K alt testlerinin T değerinin 50-60 ve F alt testinin T değerinin 70'in üzerinde olduğu durumlar.



Birey kişisel ve duygusal zorluklarını kabullenmekte ve yardım istemektedir. Sorunlarıyla kendisinin başa çıkabileceğinden emin değildir. F alt testi yükseldikçe, bireyin sorunlarını abartarak kısa süre içinde yardım almak istediği ya da simülasyon yaptığı söylenebilir. Testi veren kişi bu durumlardan hangisinin bireye uygun olduğuna karar vermelidir. Birey, kronik bir uyumsuzluk örüntüsü gösterse bile psikiyatrik açıdan yardım edilmesi güçtür ve zaman içinde de konfigürasyonda belirgin bir değişiklik olmaz.

Şekil 1 Tersine V

Konfigürasyon 2: L ve K alt testlerinin en az 60 T düzeyinde (70 T puanına bile yaklaşabilir) F alt testinin 50 T puanına yakın olduğu durumlar:



Bu birey kabul edilmez duygularından, impulslarından, dürtülerinden ve sorunlarından kaçmakta ya da bunları inkâr etmektedir. Birey kendini en iyi biçimde sunar. Dünyayı uçlarda, iyi ve kötü olarak görür. Eğer değerlendirilen bireyden elde edilen veriler yeterli ise savunuculuk ve psikopatolojinin inkârından şüphelenilmelidir.

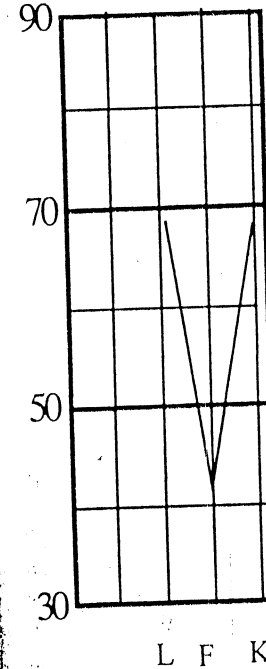
Şekil 2

Bireyin yeterli sosyal uyumu olabilir, en kötüsü davranış bozukluğu tanısı konulur.

Eğer psikotik profiller de yükselmişse, bu konfigürasyon psikotik bir bireyi gösterir.

Yukarıda tanımlanan durum yoksa bu konfigürasyon savunucu normallerden, histeriklerden ve hipokondriyak bireylerden elde edilir. Bu duruma Hs ve Hy yükselmesi eşlik eder. Profildeki diğer testler ortalama puandır.

Konfigürasyon 3: Geçerlik Alt Testi "V" (Çok Kapalı): Bu örüntüde, F alt testi 50 T puanının altında, L ve K alt testi 60 T puanının üzerindedir.



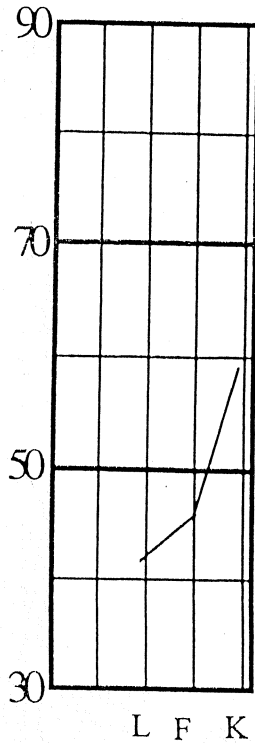
Bu "Çok Kapalı Geçerlik Konfigürasyonu"dur. L ve K alt testleri ne kadar çok yükselirse, bu kişi kendisini olduğundan daha iyi gösterme çabası içindedir. Kişi böyle yaparak sorunlarını, kabul edilmeyen dürtülerini ya da duyguları azaltma ya da inkâr etme yoluna gitmiştir. Bu geçerlik konfigürasyonu özellikle kendini iyi göstermek isteyen, iş arayan ve di er durumlardaki (gözetimdekiler gibi) kişilerin çok sık verdiği bir konfigürasyon biçimidir. Psikiyatri kliniklerinde yatanlarda bu geçerlik örüntüsü, inkârı kullanan ya da savunma mekanizmaları ile kontrolü sağlamaya çalışan psikotik hastalarda görülmektedir. Bu tür örüntünün ortaya çıktığı diğer tanı grupları histerikler, hipokondriyaklar, alkolikler ya da madde bağımlılarıdır. Inkâr mekanizmasını kullanan ve içgörüsü az bireylerde görülür.

Şekil 3: Çok Kapalı Geçerlik Konfigürasyonu

Bu inkâr tutumu klinik testler üzerinde azaltıcı etkiye sahiptir ve böyle bir faktör ancak bu testlerin araştırılması ile ortaya çıkartılabilir. (Klinikte "V geçerlik" konfigürasyonunun etkisini karşılamak için klinik testleri pratik olarak 5-10 puan yükseltmek yardımcı olmaktadır.) Yani 50

T puanının üstündeki her klinik alt teste 5-10 T puanı eklenebilir (Greene 1980). Bazı profillerde, K alt testi F alt testinden 20 ya da daha çok T puanındadır. Böyle bireyler sıklıkla kendi psikolojik yaşantılarını açığa vurmada isteksiz ve savunucudurlar. Onların bu güçlü savunmaları, teste uygun bir görünüm sunma eğilimini ve terapötik bir birlikteliğin gelişmesine engel olmayı gösterir. Böyle bir imaj sunmanın nedenleri şunlar olabilir: Bilinçli aldatma eğilimi, negativistik bir tutum ve iletişimi reddetme, aşırı katılık ve saflık ya da herhangi bir kişilik yetersizliğine yönelik açıklamayı tolere etmede güçsüzlük.

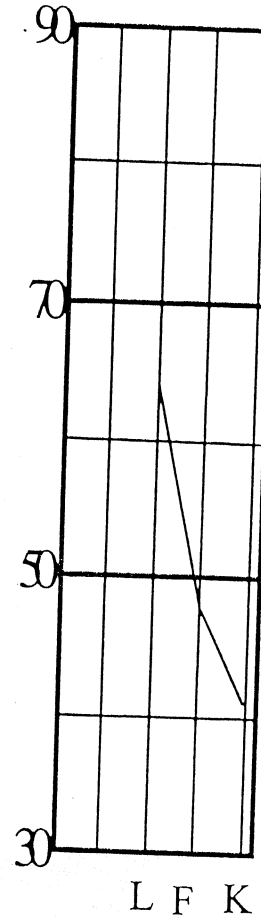
Konfigürasyon 4: L alt testi F'den, F alt testi de K'dan düşüktür. L alt testi 40 T puanında, F alt testi 45-55 T, K alt testi 60 T puanındadır.



Şekil 4: Yükselen Eğilim

Bu konfigürasyon sorunlarıyla baş edebilecek uygun kaynaklara sahip ve testi aldığı dönemde stres ya da gerilim yaşamayan normal kişilerin tipik konfigürasyonudur. Bu bireylerin K alt testindeki yükseltisi öğrenim durumlarına ve sosyo-ekonomik düzeylerine göre iniş çıkış gösterecektir. Bu yükselmenin kendiliğinden psikiyatriye başvuran kişilerde görülme olasılığı düşüktür. İşe girmek için başvuran ya da hapis hanesindeki bir kişi, kendini iyi göstermek için bu tür bir geçerlik konfigürasyonu verecektir. Genellikle bu durum, a) evlilik çatışması yaşayan "normal" bireylerde, b) sofistike savunmaları olan üst sosyo-ekonomik ya da lise düzeyinde eğitim görmüşlerde görülebilir.

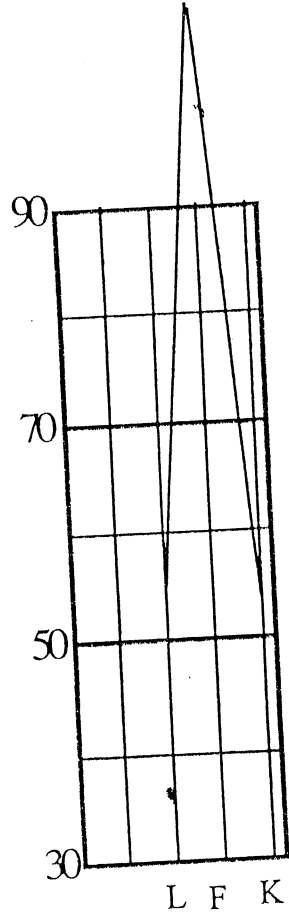
Konfigürasyon 5: L alt testi F'den, F alt testi de K'dan büyüktür. L 60 T puanına, F yaklaşık 50 T puanına yükselmiş, K alt testi 40-45 T puanı arasındadır.



Bu kişiler, kendilerini iyi göstermeye çalışırlar, sorunlarını kabul etmekten ya da kendileri ile uğraşılmasını istemekten hoşlanmazlar. Ancak bu kişilerin iyi görünme çabaları etkisizdir ve nevrotik üçlü genellikle yükselir. Erkeklerde Mf düşük olabilir. Eğitimi ve sosyo-ekonomik düzeyleri düşük bireylerde daha çok görülür.

Şekil 5: Azalan Eğilim

Konfigürasyon 6: L ve K alt testleri 55 T , F alt testi 105 T puanının üstündedir.



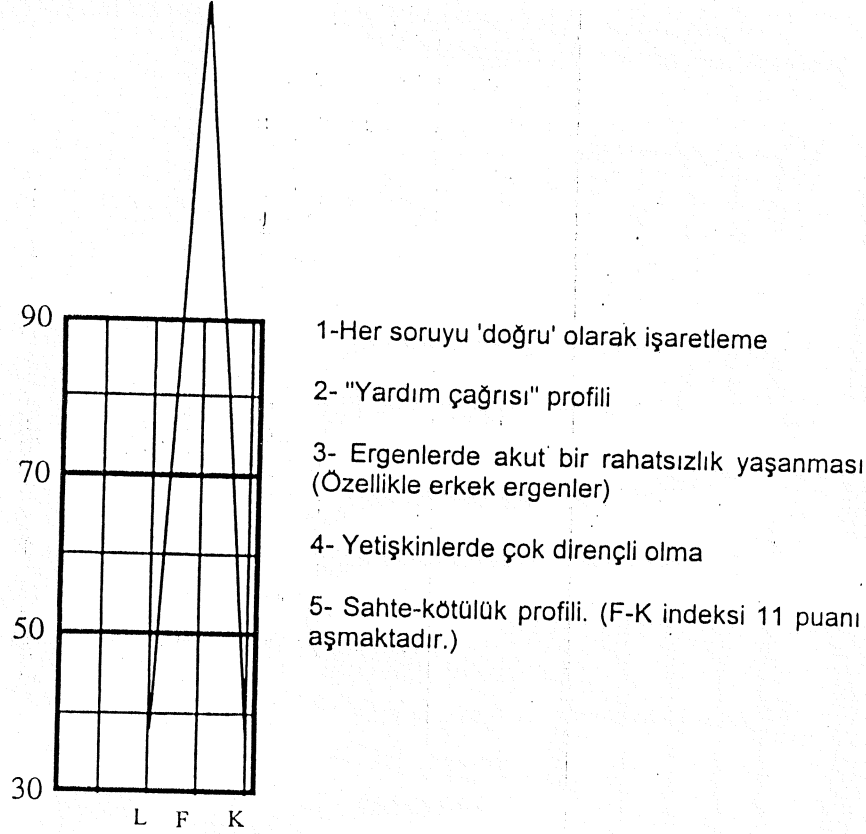
Şekil 6: Rastgele cevaplama

Profil, hastanın maddeleri rastgele cevaplamasından dolayı geçersizdir. Bu durum hastanın konfüzyonundan, öfkesinden, test durumuna karşı

direncinden ya da zekâ faktöründen kaynaklanıyor olabilir. Klinisyen cevap verme örüntüsünün nedenlerini araştırdıktan sonra, testi hastaya tekrar vermelidir.

Ek olarak son 6 klinik test, 70 T üstünde olmakta ya da toplu yükselme göstermektedir. Klinik testlerdeki yükselme ve F'deki yükselme "V" şeklinde örüntüye benzese de, burada önemli olan rastgele doldurmada L ve K' nin yüksekliğidir.

Konfigürasyon 7: Tümünü doğru olarak işaretleme. L ve K alt testinin 35 T puanını aşmasını, F alt testinin 120'nin üzerinde yer almasını gerektirir. Ek olarak, klinik testlerden Pd, Pa, Pt, Sc ve Ma 90 T puanının üzerinde yer alır.



Şekil 7: Tümüne "doğru" yanıt verme

Eğer profil geçerli ise, böyle bir kişi, düşünce ve davranışındaki majör bozukluklar ve günlük yaşantısında yetersizliklerin hakim olduğu ajite psikotik bir tabloyu göstermektedir.

Konfigürasyon 8: Bireyin bütün soruları "Yanlış" olarak işaretlemesidir. Şekil 8'de gösterildiği gibi L, F ve K testlerinin tümü 80 T

puanının üzerindedir. Ek olarak Hy, D, Hs ve Pd alt testleri 80 T ve üstüne yükselmiştir.

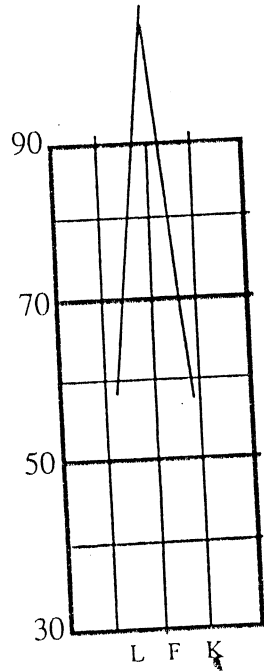


Profil geçersizdir. Hasta tüm maddelere yanlış olarak cevap verme eğilimindedir. Kişi konfüzyondadır, öfkeli ya da test almak istememektedir. Klinisyen hastanın bu tutumunun nedenlerini araştırdıktan sonra, hastaya testi tekrar verebilir.

Şekil 8: Tümüne "yanlış" yanıt verme

Bu örüntü çok ajite ya da yıkımı olan psikotik hastalardan elde edilir.

Konfigürasyon 9: L ve K alt testleri 66 T puanının altında, F alt testi ise 100 T puanına yakın ya da altındadır.



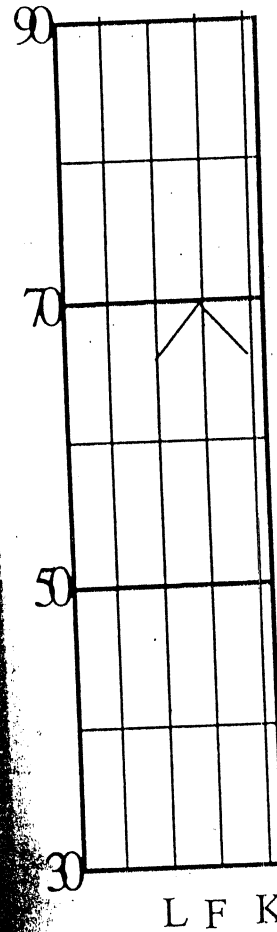
Bu profil geçerlidir. Geçerlik konfigürasyonu hastanın dile getirmek istediği psikolojik sorunları olduğunu göstermektedir. Bu tür konfigürasyon veren hastalar karamsar, dik kafalı, huzursuz ve asi kişilerdir. Kendilerini aşırı eleştirirler, psikolojik sorunlarını kabul etmeye hazırdırlar. Kullandıkları savunma mekanizmaları, içinde bulundukları durumla başa çıkmada yetersiz kalmaktadır. Bu hastalar kolay incinebilirler.

Şekil 9:

Bununla beraber, F alt testi 80 T puanının üstüne çıktıkça ya da 40 T puanının altına düştükçe kişi, çok akut ve yaygın bir stres yaşar ve bu nedenle yeteneklerini kullanamaz. Bu durumda bir kişi krize müdahale ile sıkıntısı hafifleyinceye kadar, psikoterapötik yardıma cevap veremez. Bununla beraber, böyle yüksek bir F, kişinin çok kısa sürede yardım

almak için "yardım için ağlama"yı test aracılığı ile göstererek, stres ve kişilik sorunlarını abartabileceğini ya da simülasyon yapabileceğini gösterir.

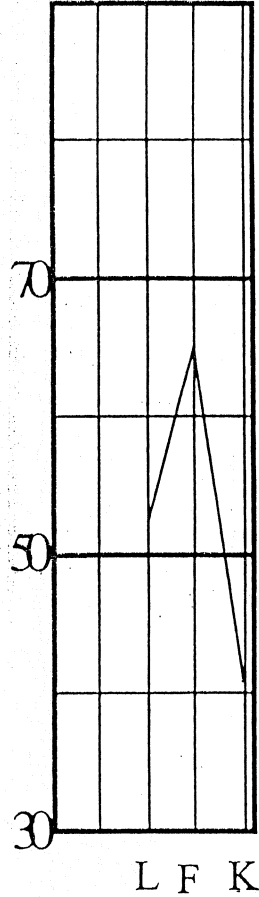
Konfigürasyon 10: L alt testi 66 T puanının altında, F alt testi 69 T puanının ve K alt testi 65 T puanının üstündedir.



Profil geçerli gibi görünse de geçerlik konfigürasyonu geleneksel olmayan bir cevap örüntüsünün varlığını göstermektedir. Birey psikolojik sorunlarını kabul etmektedir. Bireyin akut bir bozukluğu vardır, ancak başa çıkmada kullandığı savunma mekanizmaları henüz bozulmamıştır. Ancak birey bunları kullanmada güçlük çekmektedir. Patolojinin açık gösterimi ve savunucu kontrol arasındaki denge bu kişilerde duragan değildir ve yordanamaz.

Şekil 10

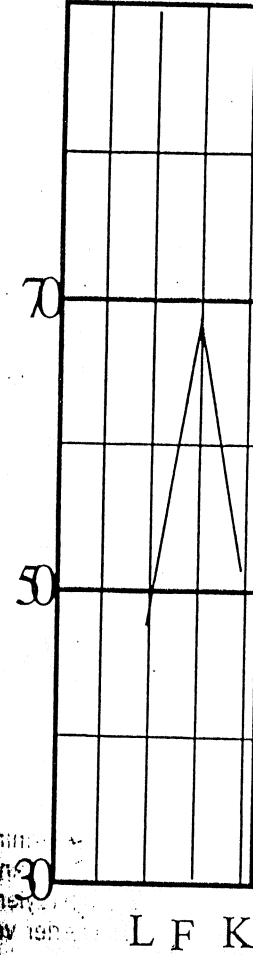
Konfigürasyon 11: L alt testi 55 T puanının altında, F alt testi 64 T puanına yakın, K alt testi 45 T puanının altında.



Bu profil geçerlidir. Benzer profil veren bireyler konuşma ve tavırlarında açıktırlar ve laflarını sakınmazlar. Ergen grubu dışında kalan bireylerde ego gücünde düşüklük ve yetersiz savunma mekanizmaları vardır. Bu bireyler bir biçimde farklıdırlar. Eğer açık bir psikolojik bozukluk yoksa hastada nevrotik bir uyum olduğu görülmektedir.

Şekil 11

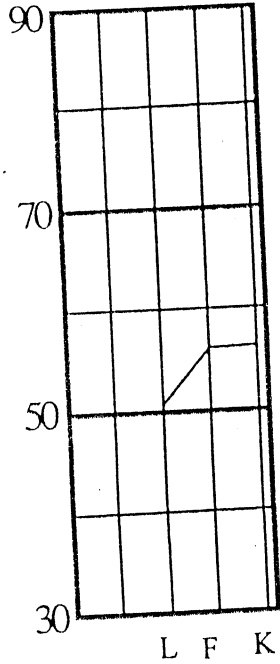
Konfigürasyon 12: L alt testi 50 T puanına yakın, F alt testi 70 T puanının altında, K alt testi 50 T puanının üstündedir.



Bu geçerli bir profildir. Birey yönergeleri dikkatli bir biçimde okuyarak, anlamış ve yapmıştır. Yanıtlar olduğu gibi doğrudur ve hastanın durumunu yansıtmaktadır.

Şekil 12

Konfigürasyon 13: Bu konfigürasyonda, L alt testi 50 T puanının üstünde F ve K alt testleri hemen hemen eşittir ve 55 T puanının üstündedir.



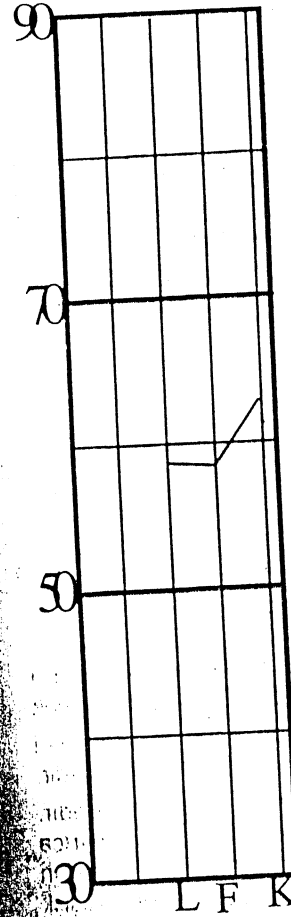
1. Akut bozukluk
2. Ciddi bozukluğu olmasına karşın oldukça savunucu olan ancak yine de hasta görünen kişiler

Şekil 13:

Bu örüntüdeki kişilerin başa çıkma yetenekleri iyidir. Sorunlarının uzun zamandır devam etmesine karşın, bununla yaşamlarını sürdürebilirler. F alt testi 70 T puanının üzerinde olsa bile bu bireyler sadece şimdiki semptom ya da problemleri için yardım almak isterler ve tipik olarak durumsal stres azaldığında rahatlarlar.

Eğer F ve K alt testleri 70 T puanının üstündeyse, bireyde hastalığına ilişkin içgörü yoktur ve prognoz kötüdür. Açık patoloji ile savunuculuk arasındaki denge yordanamaz ve kalıcı değildir.

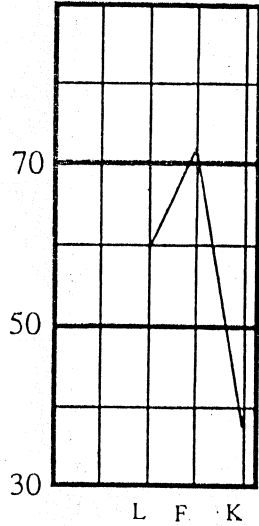
Konfigürasyon 14: L alt testi 55 T puanının üstünde, F alt testi 60 T puanının altında, K alt testi 59-64 T puanı arasındadır.



Bu profil geçerlidir. Geçerlik konfigürasyonu bireyin kendisini çok erdemli biri olarak gösterme isteğini ve kendisini de böyle görmek istediğini göstermektedir. Bu bireyler kendilerini olduğundan çok daha iyi olarak gösterme eğilimindedirler.

Şekil 14

Konfigürasyon 15: L alt testi 60 T puanında, F alt testi 70 T puanının üstünde ve K alt testi 40 T puanının altındadır.

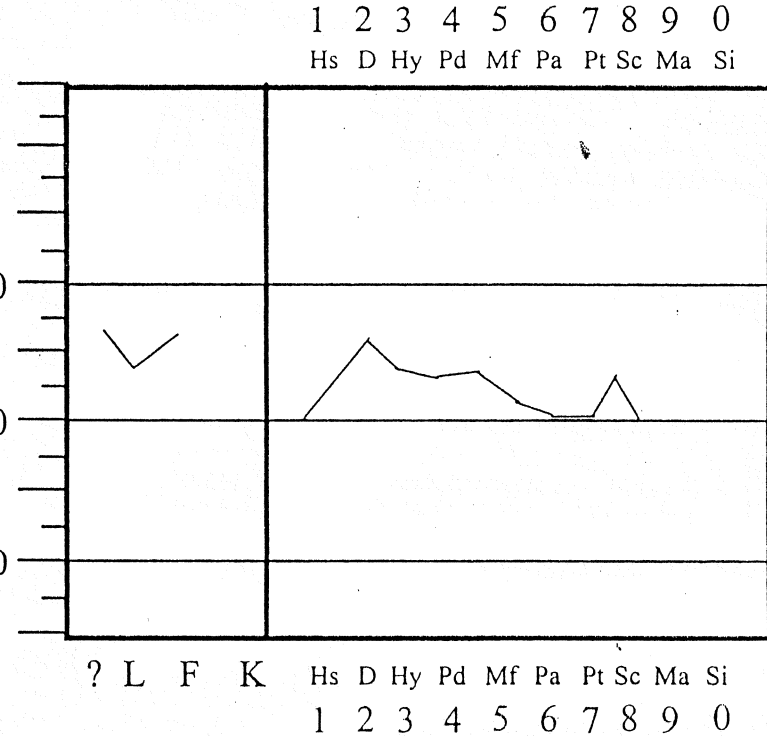


F'nin yüksekliği, bu kişinin karmaşıklık yaşadığını gösterir. L'deki ortalama yüksek puan, bireyin dünyayı basit, siyah ve beyaz olarak gördüğünün göstergesidir. Düşük K, bireyin benlik değerinin düşüklüğüne, başa çıkma kaynaklarının azlığına ve duygusal alanda katı olduğuna işaret etmektedir. Ancak L'nin yüksekliği, bireyin katı bir şekilde geleneksel değerlere tutunduğunu gösterir.

Şekil 15

K⁺ profilleri

Bazen bir profilde tek anlamlı yükselme K alt testinde gözlenir. Bu profilde hiçbir klinik test 70 T puanının üstünde değildir. (6 ya da daha çok klinik test 60 T puanı ya da altındadır.) K⁺ profilinde K ve L alt testleri F'den yüksektir ve K alt testi, F alt testinin en az 5 T puanı üstündedir. Mark ve Seeman (1963) bu tür profilleri K⁺ profili olarak adlandırmaktadır. Özellikleri şunlardır: Bu kişiler utangaç, kaygılı ve ketlenmişlerdir. Ayrıca sorunlarının psikolojik olabileceği konusunda dirençlidirler. Yakın kişilerarası ilişkilerden kaçınırlar ve pasif direniş gösterirler. Kişilik özellikleri şizoid yapıdadır. Paranoid özellikler de gösterirler; şüpheli, korkak ve kendileriyle ilgili herhangi bir duruma duyarlıdır. Bu hastaların yarısı psikotik olarak tanı alır, 1/4'üne organik beyin sendromu tanısı konulur. Grup olarak zekâ düzeyleri normalin alt sınırındadır.

Şekil 16: K⁺ Profili

F-K Endeksi

F-K Endeksi diğer bir geçerlik belirleyicisidir. K puanının F puanından çıkarılması ile elde edilmektedir. İlk yapılan çalışmalarda kesim puanı olarak 11 alınmış, bu kesim puanı normallerin % 1'inde, psikiyatrik grubun % 2.5'unda görülmüştür (Gough 1947,1951). Daha sonra kesim puanı 9'a düşürülmüştür. F-K puanı 0-9 arasında ise profil geçerlidir, 9'dan büyükse sahte-kötülük, 0 ise sahte-iyiliktir. Klinik gruplarda F-K endeksinin 9'dan büyük olduğu durumlarda birey psikopatolojisini inkâr etmektedir (Wetzel, Marlowe 1990).

F-K endeksi için diğer bir durum kişinin sorunlarını ele alma ve sahip çıkma biçimidir. K ham puan yüksek (yani sorunlarımla başa çıkabiliyim ve iyi uyumum var) mesajıyla düşük F puanı (yani stres ve çatışmalarım şu anda yok) mesajının bileşimi genellikle F-K endeksi tarafından sahte-iyilik olarak değerlendirilir. Böylece MMPI'ı alan normal bireyler yanlış bir biçimde sahte-iyilik grubuna girebilirler.

Psikiyatrik grupta sahte-kötülük profilleri, sahte-iyilikten daha iyi ayırt edicidir. Bu konuda daha ayrıntılı araştırmalara gereksinim vardır. Ayrıca sahte-iyilik profili vermiş hastaların iyi prognoz gösterdikleri konusundaki verilerin de araştırılması yararlı olabilir. Özetle F-K endeksinin yararlılığı konusunda henüz kesinleşmiş bir bulgu yoktur.

Eğer F-K endeksi 8-11 arasında ise konfigürasyon, bireyin sorunları olduğunu gösterse de bu kişiler sorunlarını abartmaktadırlar. Bu durum hastanın psikolojik müdahaleye ve yardım almaya açık olduğunu göstermektedir.

F-K endeksi 16'nın üstünde ise:

Geçerlik konfigürasyonu bu hastanın test bulgularının değerlendirilmesinde dikkatli olmanın gerekliliğini göstermektedir. Yapılan standard değerlendirme hastanın durumunu yansıtmayabilir. Bu veri için olası açıklamalar şunlardır:

- Hasta akut bir psikotik bozukluk göstermektedir ve testi içinde bulunduğu duruma bağlı olarak tamamlayamaz. Klinik düzelme olduktan sonra test yinelenmelidir.

- Birey bilinçli olarak durumunu abartmakta ya da bir yarar sağlamak için simülasyon yapmaktadır.

Test tekrar test endeksi

MMPI'in grup kitapçığında yer alır. Toplam sayısı 16 olan ve 6,7,8 ve 0 alt testlerinde yer alan tekrarlanmış maddeler test tekrar test (TR) endeksinin oluşturmaktadır. TR endeksi üzerinde 3 puan ya da daha fazla bir puanın, geçersiz profil olasılığını arttırdığı ileri sürülmüştür (Dahlstorm 1972). Greene (1979) yaptığı bir araştırmada psikiyatrik hastalar, gözaltındaki genç suçlular ve üniversite psikoloji öğrencilerine MMPI vermiş ve gözaltındaki gençlerin yanıtlarının, yüksek okul öğrencilerinden daha tutarsız olduğunu saptamıştır. Bu da bu gözaltındaki gençlerin genellikle işbirliği içinde olmadıklarının ve test almaya

dirençlerinin göstergesidir. Gözaltındaki gençler dışında diğer grupların değerlendirilmesinde TR endeksinin psikopatolojisi olan gruplarla, diğer gruplar arasında bir ayırım yapamadığı saptanmıştır.

Gravitz ve Gerton (1976), sırasıyla normal erkeklerin ve kadınların tekrarlanan maddelerin sadece üç, dördüne değişik yanıtlar verdiklerini belirlemişlerdir. TR endeksi F alt testindeki gibi bir geçerlik alt testiyle karşılaştırıldığında çelişkili bulgular elde edilmiştir. F alt testinin yükselmesi, MMPI'nin geçersiz olduğunu göstermektedir; ancak F açısından geçerli olan bazı profiller TR endeksinin göre geçersiz olabilmektedir. TR endeksi bazı geçersiz profilleri belirlemede kullanışlı olmasına karşın, hastaların 3 puan ya da daha az puanlık TR endeksinin sadece dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıktığını akılda tutmak gerekir. Üstelik TR endeksi, sadece hastaların cevaplarının tutarlılığını tayin etse de, "bütün doğru" ya da "bütün yanlış" cevap kurgularını göstermemektedir. Tutarsız yanıtların verildiği bazı MMPI profilleri TR endeksinin ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, F alt testindeki yüksek puanlara karşın hastaların maddeleri tutarlı olarak doldurmuş olduklarını TR endeksi gösterebilir. Bu bulgular, TR endeksinin ve geleneksel geçerlik testlerinin test alma tutumu açısından benzer süreçleri ölçmediklerini işaret etmektedir. Bu nedenle TR endeksinin daha fazla araştırılması gereklidir. Ayrıca değişik düzeydeki madde tutarsızlıklarının bağımsız ya da test dışı geçerlik ölçütleriyle olan bağlantısı araştırılarak, bu tür tutarsızlıkların MMPI profillerini nasıl etkilediğini incelemek gerekir.

Tablo 6 : MMPI kitap formunda aynı olan maddeler

No	Madde sayısı	Cümleler
1	8	Günlük hayatım beni ilgilendirecek şeylerle doludur.
1	318	Günlük hayatım beni ilgilendiren şeylerle dolu.
2	13	Büyük bir sinir gerginliği içinde çalışırım.
2	290	Çok gergin bir hava içinde çalışıyorum.
3	15	Ara sıra söylenmeyecek kadar ayıp şeyler düşünürüm.
3	314	Ara sıra söylenmeyecek kadar kötü şeyler düşünürüm.
4	16	Hayatta hep kötülük buldum.
4	315	Hayatın hep kötü tarafları bana nasip olmuştur.
5	20	Cinsi hayatımdan memnunum.
5	310	Cinsel hayatım doyurucudur.

- 6 21 Zaman zaman evi bırakıp gitmek istemişimdir.
308 Zaman zaman evi bırakıp gitmeyi çok istemişimdir.
- 7 22 Sık sık kontrol edemediğim gülme ve ağlama nöbetlerim vardır.
326 Bazen kontrol edemediğim gülme ve ağlama nöbetlerine tutulurum.
- 8 23 Mide bulantısı ve kusmadan sıkıntı çekerim.
288 Mide bulantısı ve kusma nöbetlerine tutulurum.
- 9 24 Kimse beni anlamıyor.
333 Beni hiç kimse anlamıyor.
- 10 32 Zihnimi bir iş üzerinde toplamakta güçlük çekerim.
328 Zihnimi bir konu ya da iş üzerinde toplamakta güçlük çekerim.
- 11 33 Başımдан çok garip şeyler geçti.
323 Başımдан çok tuhaf ve acaip olaylar geçmiştir.
- 12 35 Başkaları engel olmasa idi çok daha başarılı olurdum.
331 Eğer insanlar sırf düşmanlık olsun diye beni engellemeselerdi daha başarılı olurdum.
- 13 37 Cinsi hayatım yüzünden hiç başım derde girmedim.
302 Cinsel davranışlarımdan dolayı hiçbir zaman başım derde girmedim.
- 14 38 Gençliğimde bir devre ufak tefek şeyler çaldım.
311 Gençlik yıllarımda bir devre ufak tefek şeyler çaldım.
- 15 305 Başkalarıyla beraber olduğum zaman bile kendimi yalnız hissedirim.
366 İnsanlar arasında olsam bile çok defa kendimi yalnız hissedirim.
- 16 317 Birçok kimseden daha hassasım.
362 Birçok kimseden çok daha hassasım.

Dikkatsizlik alt testi

Bu alt test (Greene, 1978) MMPI üzerinde diğer bir geçerlik göstergesi olarak geliştirilmiştir. Hastaların testi tamamlamaya karşı isteksizliği ya da beceri eksikliğini göstermede, zıt maddelerin daha etkili oldukları savı, bu alt testin temelinde yer alır. Dikkatsizlik alt testi psikolojik olarak zıt içerikli olduğuna karar verilen, 12 çift görgül yolla seçilmiş maddeden oluşmaktadır.

Test tekrar test göstergesinden daha duyarlı bir ayırım yapan bu alt test, saptırılmış test davranışının ortaya çıkarılmasını mümkün kılar. MMPI'yi düzgün bir şekilde cevaplandırmak istemeyen hastaları olduğu kadar, konfüzyondaki hastaları da ayırt etmektedir. Bu durumda hastayla yapılan karşılıklı bir görüşme ile uzman, hastanın zihinsel karışıklığını anlayabilir. Hastanın dikkatsizlik alt testinden alacağı en yüksek puan 12'dir. Greene (1980) geçersiz profilleri belirlemede 4'ün kesim puanı olarak alınabileceğini belirtmiştir.

Tablo 7 : Dikkatsizlik alt testi madde sayıları ve puanlama yönü

No	Madde Sayısı	Dikkatsizlik Yanıtı
1	10/405	Aynı
2	17/65	Farklı
3	18/63	Farklı
4	49/113	Aynı
5	76/107	Aynı
6	88/526	Aynı
7	137/216	Aynı
8	177/220	Farklı
9	178/342	Aynı
10	286/312	Farklı
11	329/425	Aynı
12	388/480	Farklı

5. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Klinik Testlerin Değerlendirilmesi

Bu bölümde verilecek olan kod tipleri ve profil yorumlamaları klinik bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgileri elde etmede farklı kaynaklardan yararlanılmış ve olası MMPI kodlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Burada yapılan kod yorumlamaları MMPI'da kullanılan ikili kodların hepsini, üçlü ve dördü kodların çoğunluğunu içermektedir.

Bu kodların özel yorumlanması alt testlerin sayısal sıralamasına göre yapılmıştır. Verilen yorumlarda kullanılan temel kaynaklar Archer 1987, Butcher 1969, 1984, 1987, Butcher Graham 1990, Ceyhun 1986, Dahlstrom ve ark. 1972, Erol 1982, Friedman, Graham 1987, Greene 1979, Lachar 1974, Levitt 1989, Savaşır 1978, 1981, Webb 1978'dir. Bu kaynaklar MMPI hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ya da araştırma yapmak isteyen kişilere önerilmektedir.

MMPI yorumları, ilkökul mezunu ortaokul düzeyinde eğitimi olan, zeka düzeyi normale yakın ve genellikle yetişkinler için yapılmıştır. Ancak Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için ergenlik dönemine ilişkin kod özelliklerinin araştırılması ve bu döneme özgü değerlendirme kitaplarının hazırlanması yararlı olacaktır.

Bundan sonraki bölümde verilen kodlar aşağıdaki özellikler gözönünde tutularak değerlendirilmiştir. Bunlar; psikiyatrik grupta ortalama ve yüksek puanların yorumlanması ve cinsiyet, yaş, eğitim, sosyo-ekonomik düzey gibi değişkenlerin puanlara etkisidir.

MMPI değerlendirmesinde düşük puanlar psikopatolojiyi değil, uyumu göstermektedir. Bu nedenle düşük puanlar üzerinde araştırma sayısı çok azdır. Ancak bazı alt testlerde düşük puanlar önemlidir. (Örneğin Hs, Pd, Mf, Pa ve Ma alt testlerinde olduğu gibi.) Bu testlerde düşük puanlar üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.

1. Hipokondriasis (Hs) Alt Testi

Bu alt test hipokondriyak bireylerin kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bilindiği gibi hipokondriasis kişinin vücut semptomlarını yanlış yorumlamasına bağlı olarak ciddi bir hastalığı olacağı korkusunu ya da ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesini taşıyıp durmasıdır. Bunlar bedensel hiçbir hastalıkları olmadığı halde birçok hastalık belirtisini kendilerinde bulur ve endişelenirler. Tablo 8'de bu alt testteki maddeler ve puanlama yönü gösterilmiştir.

Tablo 8: Hipokondriasis alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 33)

Doğru	23	29	43	62	72	108	114	125	161	189	273
Yanlış	2	3	7	9	18	51	55	63	68	103	130
K Eklemeli	153	155	163	175	188	190	192	230	243	274	281

Erkeklerde ortalama: 13.19, kadınlarda: 15.89
(Savaşır, 1981)

Hs alt testinde yüksek puan alan bir bireyin: (Graham 1987)

1. Aşırı bedensel uğraşları vardır.
2. Somatik delüzyonlar (eğer T>80) görülebilir.
3. Somatik semptomlar genellikle belirsizdir, eğer belirginse temelde mide ve karın bölgesine ilişkindir.
4. Kronik yorgunluk, ağrı ve güçsüzlükten yakınır
5. Somatoform, depresyon ya da anksiyete bozukluğu tanısı konulabilir.
6. Açık anksiyete belirtisi göstermez.
7. Kendine odaklanmış, bencil, narsisistiktir.
8. Karamsar, yıkıcı, alaycı bir yapısı vardır.
9. Doyumsuz ve mutsuzdur.
10. Diğerlerini biktırır.
11. Yakınır.
12. Sızlanır.
13. Diğerlerine bağımlı ve eleştiricidir.
14. Düşmanlığını dolaylı yollardan ifade eder.
15. Psikopatik davranışları azdır.
16. Donuk ve ilgisizdir.
17. Sözeleştirmede başarısızdır.

18. Uzun süreden beri devam eden sorunları vardır.
19. Uyumunda herhangi bir bozukluk olmamasına karşın, etkinliği azalmış gibi davranır.
20. Semptomları için tıbbî açıklamalar ve tedaviler ister.
21. Psikoterapi ya da danışmanlığa içgörü eksikliği ve alaycı tavrıyla çok iyi yanıt vermez.
22. Terapisti eleştirir.
23. Terapistin kendine yeterli ilgi ve desteği vermediğini düşündüğünde terapiyi sonlandırma eğilimindedir.

Hs alt testinde düşük puan alan bir bireyin:

1. Somatik uğraşları yoktur.
2. İyimserdir.
3. Duyarlıdır.
4. İçgörüsü vardır.
5. Günlük yaşamda oldukça etkindir.

Ciddi bedensel hastalığı olan bireylerde de bu alt testte yükselme vardır, ancak bu psikiyatrik hastalar kadar yüksek değildir. Hipokondriyak tanısı konulan hastaların semptomları uzun sürelidir, değişmeye dirençlidirler ve bu, artık strese tepkiden farklı bir şeydir. Bu bireyler önerilen tedaviyi uygulamaz ve sık sık doktor doktor gezerler.

Hs alt testinin 40 yaşın üzerindekielerde daha çok yükseldiği ancak genç grupta daha düşük olduğu belirtilmektedir.

84'ün üzerinde T Puanı: Yakınmaları bütün organ sistemlerine yayılmış olan kişilerde görülür. Ağrı, yorgunluk ve güçsüzlük sıklıkla vardır. Somatik ilgiler somatik delüzyonlara dönmüş demektir. Bu belki de şizofrenik bir epizodun başlangıcıdır.

75-84 T puanı: Bedensel yakınmalar ile çok fazla uğraşan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak iş yapma istekleri azalmıştır, yakınmalarının bedensel kaynağını sürekli bir biçimde araştırırlar. Sıklıkla benmerkezcil ve narsisistiklerdir, sürekli şikayet eder ve sızlanırlar. Yakınmalarını diğerlerine kabul ettirme eğilimleri çok fazladır, bu nedenle aşırı talep edici bir tutum içindedirler. Çevrelerindeki rahatsız ederek öfkelerini ortaya çıkarırlar. Tipik olarak inatçı, kötümser, genel olarak yaşamda mutsuz, tutkusuzdurlar ve güdülenmemişlerdir.

60-74 T puanı: Bu puanlar sıklıkla bu kişilerin hem şimdiki, hem de geçmişte yaşadıkları fiziksel bozukluk gösterdiğine işaret etmektedir ve bu yükselmeye sıklıkla D alt testindeki yükselme eşlik eder. Sağlık konularına bu ilgi, basit olarak yapıcı bir ilgi olabilir ya da sağlığa aşırı

duyarlılığı temsil eder. Böyle kişiler kötümser olmaya ve yaşamlarını sıkıcı hale getirmeye eğilimlidirler. Bedensel hastalığı olan bireylerde 65 T puanının üstünde bir yükselme bu bireylerin yaşadıkları güçlükleri aşırı tepki verdiklerini ve kabul edilmez dürtülerini somatizasyon ile ifade ettiklerini göstermektedir.

50-59 T puanı: Bu kişilerin beden konuları ile aşırı ilgilenmediği ve 2,6,7,8 ya da 0 alt testi 70'in üzerine yükselmediği zaman günlük yaşam aktivitelerini yerine getirdiği söylenebilir. Bu kişiler sıklıkla yetenekli, sorumluluk sahibi, vicdanlı, dikkatli ve yargılamaları iyi olan kişilerdir. Spesifik tıbbi hastalığı olan bireyler bu alanda yer almaktadır.

21-49 T puanı: Bu durum şu kişilerde görülebilir: (a) Hastalığın hiç konu olmadığı ailelerde yetişen bireyler (b) Şimdiye kadar hiç ağrı, acı ya da hastalık geçirmediği ile övünen kişilerde. Ayrıca bu kişiler hipokondriyak olarak hastalıklarını manipulatif bir yolla kullanan aile üyeleriyle yakından ilişkili olabilir, ancak burada normal acı ve ağrılar da inkâr edilir. Özelliği olan bir örüntüde 2,6,7,8 ya da 0 alt testlerinin 70'in üzerinde yer aldığı bir durumdur, çünkü bu konfigürasyonda düşük Hs alt testi sıklıkla birisinin bedeni ile ilgisinin olmadığını gösterir. Bedensel yakınmaları ve genel sağlık durumları ile çok az ilgilenen kişilerdir. Genellikle uyanık, iyimser, yeterli ve yaşamda etkin olan kişilerdir.

Sadece Hs alt testinin yükselmesi: Bu hastalar belirsiz fiziksel yakınmalar getirirler ve bunları diğer kişileri kontrol ve manipüle etmek için kullanırlar. Bu hastalar herşeyi kötü gören, sızlanan, ilgi çekmek isteyen kişilerdir ve genellikle olumsuz ve kararsızdırlar. Bu hastalara müdahaleler genellikle fazla güven vermez.

Hipokondriazis alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

12/21 Kodu

Bu kodun en belirgin özelliği bedensel rahatsızlık ve ağrıdır. Bu kod tipini alan bireyler bedensel işlevleri ile çok fazla ilgilidirler. Genel olarak hipokondriyak yakınmaları, somatizasyon bozukluğu ya da psikofizyolojik reaksiyon şeklinde kendini gösterir, stres dönemlerinde daha da belirginleşir. Semptomlarının duygusal çatışmalarla ilgili olduğunu ve bunları kullanarak psikolojik sorunlarından kaçmaya çalıştıklarını anlamak istemezler. Yakınmaları belirsizdir ve medikal olarak ayrıştırılması zordur. Hipokondriyak özelliklerinden dolayı herhangi bir tıbbi müdahale olabildiğince kısıtlı olmalıdır.

12/21 Kodunu veren lise öğrencileri genel olarak utangaç, gergin, içedönük, mutsuz, endişeli, güvensiz ve özellikle karşı cins ile ilişkilerinde oldukça çekingendirler.

Üniversite öncesi ergenler, sıklıkla utangaçlıklarını obsesyonlar ya da sosyal izolasyon biçiminde gösterirler. Bağımlılık ve karamsarlık belirgindir ve arkadaşları azdır. Aile öykülerinde sıklıkla ayrılıklar ya da boşanma vardır.

12 Kodunda 1 ve 2 alt testleri arasında 5 T puanı kadar fark varsa 21'e bakılır. Bu kişiler fiziksel semptom ve yakınmalarını özellikle gösterir ve bedensel işlevlerine aşırı ilgi gösterirler. Genel olarak onlarda belirgin organik bir patoloji yoktur, ancak az da olsa var olan fiziksel sorunlarını abartma eğilimi gösterirler. Sundukları çok sayıda somatik yakınma arasında baş ağrısı, mide ağrısı ve sırt ağrısı gibi ağrılar; kardiyak yakınmalar ya da anoreksiya, bulantı, kusma ya da ülser gibi, gastrointestinal zorluklar odak noktasını oluşturur. Bunlarda sinirlilik, huzursuzluk ve depresyonun eşlik ettiği yorgunluk, zayıflık ve baş dönmesi vardır.

Bu örüntüyü veren hastalar, yakınmalarını kullanma ve yaşam biçimi haline getirmeyi öğrendikleri için bunları tedavi etmek zordur, kısa süreli tedaviye cevap verebilirler, ancak semptomları geri dönebilir. Bu kişiler sadece çok rahatsız olduklarını kabul ettikleri gibi aynı zamanda davranışlarının sorumluluğunu alma zorluğu çektikleri için geleneksel psikoterapiye yeterince cevap veremezler. Bedensel semptomlarının psikolojik sorunlardan kaynaklandığını reddederler. İlgörüleri oldukça sınırlıdır.

Duygularını ifade etmeleri güçtür ve bu nedenle özellikle öfke gibi olumsuz duyguların gösterileceği durumlarda kendilerini huzursuz hisseder ve öfkeyi somatizasyonla gösterirler.

Olası Tanı: Pasif- bağımlı kişilik bozukluğu
Somatizasyon bozukluğu

123/213 Kodları (Ayrıca 1234 ve 1237'ye bakınız. 3 alt testi, 1'den 5 T puanı yüksekse 213/231 kodlarına bakınız.)

Bu kişiler özellikle yorgunluk, güçsüzlük ve karın bölgesindeki organlarla ilgili bedensel yakınmalar gösterirler. Öykülerinde uzun süreli kronik hipokondriasis öyküsü vardır. Onların yakınmaları sıklıkla pasif bir bağımlılığın kanıtı olsa bile konfüzyon ve psikotik düşünce, intihar

düşünceleri, obsesyonlar ve kompulsiyonlar yoktur. Genel olarak ilgisiz, depresif, atılgan olmayan, risk alma konusunda tereddütlü kişilerdir.

Alt test 4 düşük olduğu zaman bu örüntü heteroseksüel ilişki azlığı ve seksüel zorlukların olduğu bir pasifliği gösterir. Düşük 9 ile birlikte olursa kişide enerji düzeyinde azalma, iş yapmama ve sürekli yatma isteği vardır.

Mf alt testinin düşmesi kadınlarda aşırı derecede sorumluluk almayı, uzun süreli sıkıntı çektiklerini gösterir. Eğer aynı zamanda L alt testi de yükselmişse bu kadınlarda evlilik sorunları, yorgunluk yakınmaları ve diğerleri tarafından anlaşılmama vardır.

Olası tanı: Belirgin somatizasyon bozukluğu ve hipokondriyak uğraşlar.

1234 Kodu (Ayrıca eğer alt test 1 ve 2 diğerlerinden 5 T puanı yüksekse 2134'e bakınız.)

Zayıf, korkak, stres ve sorumluluklar ile başa çıkmada yetersiz kişilerdir. Bağımlılık, bağımsızlık çatışması yaşarlar. Atılgan davranışlarla zayıflıklarını kapatma çabasına girerler. Rahatlamak için alkole sığınır, ancak içtikleri zaman kavgaya ederler. Bu profili veren erkekler kadınlara karşı düşmanlık duyguları gösterirler (Sıklıkla fiziksel şiddet yani dayak vardır). Özellikle güçlü bağımlılık gereksinimleri engellenmiştir.

Erkeklerde anneye bağımlılık özlemleri, anneleri tarafından reddedilme korkusu ile çatışma gösterirler. Olası tanıları; pasif agresif kişilik, anksiyete ya da psikofizyolojik reaksiyonlardır.

Kadınlarda karakter bozukluğu, pasif-agresif kişilik, kimseye güven duymama, duygularını ifade etme güçlüğü ya da nasıl ifade edeceğini bilememe görülür. Psikoterapide savunucudurlar, motivasyonları düşüktür.

Olası Tanı: Pasif-agresif kişilik
Anksiyete ya da psikofizyolojik reaksiyon

1236 Kodu

Uzun süreli gerginlik, yetersizlik ve stres altında semptom geliştirme eğilimini gösterir. Semptomlar konversif niteliktedir. Bastırma ve yadsımayı kullanırlar. Olumsuz duygularını psikosomatik semptomlarla gösterirler.

★1237 Kodu

123'teki kod tipinin özelliklerine ek olarak bu grupta yer alanlarda anksiyete, gerilim, korku, atılma olamama, yetersizlik duyguları ve kişilerarası ilişkilerde bağımlılıkta artma vardır. Genel olarak buna psikofizyolojik hastalıklar eklenir. Sırt ve göğüs ağrıları ve epigastrik yakınmalar vardır. Özellikle K 50 T puanından düşükse bu kişiler, günlük stres ve sorumluluklarla başa çıkamazlar. Bu profili veren erkekler kendilerinden daha güçlü kadınlarla evlenirler ve bu ilişki ile bağımlılık rolünü sürdürmeye çalışırlar. Bu kişilerde kronik işsizlik ve alkol bağımlılığı ortaya çıkabilir.

1270 Kodu

Sinirlilik, anksiyete, depresyon, zayıflık, yorgunluk, ilgi kaybı gibi semptomlar gösterirler. Kendilik değerlerinde düşme vardır. Sosyal ilişkilerinde geri çekilme ve içe dönük tutum sergilerler. Uykusuzluk, kardiyak semptomlar ve anoreksiya görülebilir.

12378 Kodu

Nevrotik bozuklukların daha şiddetli şeklidir. 7 ve 8'deki yükselmeler, nevroitik bozukluğun daha abartılı olduğunun göstergesidir.

128/218 Kodları

Sıklıkla bu profiller bedeninin üst kısmına ilişkin bizar yakınmalar getiren kişilerde görülür ve genel olarak buna yorgunluk, zayıflık, gerilim ve düşüncelerde bozulmalar eşlik eder. Ruhsal bozukluk ve diğerlerinden yabancılaşıma gösterirler. Genel olarak bu kişiler, akut prepsikotik ya da psikotik ve somatik delüzyonlar ortaya çıkarırlar.

129/219 Kodları

Bu kişiler beden işlevleri ile aşırı ilgilenir ve hastalıklarının gerçekten acil olduğunu düşünürler. Akut klinik rahatsızlık, gerginlik, ajitasyon, huzursuzluk belirgindir. Baş ağrısı, uykusuzluk ve spastik bağırsak ağrıları yakınmaları sıktır. Onlarda nörolojik etyoloji de dikkate alınmalıdır, çünkü organik beyin sendromlarında da benzer yakınmalar görülebilir. Çok az düzeyde de olsa bu kişiler depresyonu, çatışmayı ve/ya da hipomanik tarzdaki pasif-bağımlı tavrı maskeleyebilir ya da inkâr etmeyi isterler.

120/210 Kodları

Depresyon, içe çekilme, kararsızlık, kişilerarası ilişkilerden kaçınma, yetersizlik ve suçluluk duygularına değişik somatik yakınmalar eşlik eder.

8 ve 6 birlikte yükselmişse uzak duruş, pasif ve insanlardan kaçan şizoid bir biçim gösterirler.

★13/31 Kodu

Bu alt test hem normal, hem de psikiyatrik hastalarda görülür. Bu hastalar genellikle immatur, benmerkezcil ve bağımlıdır. Histerik özellikler ve bastırma savunma mekanizmasına gösterirler. Dikkat ve ilgi çekmeyi isterler ve bunu oldukça manipülatif bir biçimde yaparlar.

Hastalar, psikolojik sorunlarını somatik yakınmalar haline dönüştürürler. Bu somatik yakınmalarında psikolojik etkenlerin de olabileceğini kabul etmezler, stres altında fiziksel semptomlar gösterirler. Yakınmalarında genellikle ikincil kazanç vardır (Histeriden çok hipokondriyak özellikler gösterirler.). Bu bireylerin bedensel yakınmaları, spesifik ve net olmamakla beraber genellikle baş ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, uyuşma, el ve ayaklarda aşırı titreme şeklindedir. Sıklıkla yorgunluk, baş dönmesi, uyuşukluk ve titreme görülür. Ayrıca bu kişilerde yemek yemekten rahatsızlık ve bulantı gibi yakınmalar olabilir, bazen anoreksiya ve bulimiya görülür.

13/31 kodu ile birlikte 2 ve 7 alt testleri normal sınırlar içinde ise bu profili veren bireylerin bastırma, inkâr, rasyonalizasyon ve projeksiyon mekanizmalarını aşırı bir biçimde kullandıkları düşünülmelidir. Nadiren olumsuz kızgınlık duyguları gösterirler ve bu duyguları ile yüzleşmekten kaçınırlar ya da pasif agresif bir biçimde davranırlar. Karşı cinsten kişilerle ilişki kurma, bu bireyler için bir gereksinim olsa da genellikle zordur ve bu konuda genelde başarısız olurlar.

13/31 kodu ile birlikte 2, 7, 8 ve 9 alt testleri yükselmiş ve K alt testi düşmüşse hastada gerginlik, anksiyete, karar vermede güçlük ve depresyon olabilir. Sorunların varlığına rağmen bu kişiler semptomlarından rahatsızlık duymazlar. Semptomlarda kısmi azalma bile günlük yaşamlarını devam ettirme imkânı verir. Kendilerini normal ve sorumluluk sahibi olarak sunabilirler, psikolojik değerlendirmede kendilerini normal olarak tanımlama eğilimleri vardır.

13/31 kodu ile birlikte L ve K alt testleri de yükselirse, kendileri ile uğraşılmasından kızgınlık duydukları anlaşılmalıdır.

13 kodunu veren kişilerde hipokondriyak özellikler belirgindir. 31 kodunu veren kişilerde ise stres durumları ile karşılaşıldığında bedensel yakınmalar ortaya çıkar, immatür ve bağımlı özellikler gösterirler.

Terapi sırasında sorunlarına hemen çözüm isterler. Semptomların temelinde yatan psikolojik nedenleri kabul etmedikleri için bu kişiler geleneksel psikoterapiye dirençlidir. Terapide kesin cevaplar ve çözümler isterler, bu gerçekleşmezse terapiyi başlangıç aşamasında sonlandırırlar. Ayrıca terapistin kendilerinin aşırı ilgi beklentilerini hemen doyuramadığını düşünürlerse de terapiyi sonlandırırlar.

İçgörülerı yoktur. Davranışlarının ve fiziksel yakınmalarının psikolojik kaynaklı olduğuna ilişkin yorumlara çok dirençlidirler.

Hastalardaki bedensel semptomlar onlara ikincil kazanç sağlar. Diğer ikincil kazançları sorumluluk ve görevden kaçmadır.

13/31 Kodu, Yüksek K

Özellikle 2, 7 ve 8 testlerinin T puanı 70'in ve F alt testi T puanı 50'nin altında ise bu bireyler kendilerini normal, sorumluluk sahibi, yardımsever ve sempatik olarak sunmaya çalışan kişilerdir. Var olan herhangi bir bedensel semptom yetersizlik, değersizlik şeklinde kendini gösterir. Geleneksel psikoterapötik müdahalelerden yarar sağlayamazlar, profesyonellere güven duydukları zaman tedaviyle iyileşebilirler.

13/31 Kodu/ Düşük 2 Kodu

Bu tür profil veren bireyler, histerik kişilik özellikleri taşıy ve klasik psikosomatik semptomlar gösterirler.

132/312 Kodları

13/31 kod tipindeki özelliklere ek olarak bu kişiler, özellikle zayıflık ve yorgunluktan yakınırırlar ve stres yaşarlar. (Eğer 9 alt testi daha düşükse). Kendilerinde depresif duygudurum olduğunu inkar etseler de davranışlarında sıklıkla depresif özellikler vardır. Bu kişiler uyumlu ve pasiftirler (Özellikle 4 alt testi düşükse). Diğerlerinin ilgisi karşısında endişe yaşarlar (Si alt testinde düşüklük varsa.).

134/314 Kodları

Bu bireylerde belirgin olan özellikler inatçılık, züppelik hatta kendini beğenmişliktir. Somatizasyon yakınmaları bu özellikleri nedeniyle ikinci planda kalmaktadır. Diğer yönleriyle 13/31 kodlarındaki özellikler bu bireylere de uygundur. Bağımlılık, bağımsızlık çatışmaları vardır; ancak böyle kişiler diğerlerinden yabancılaştıkları konusunda çok endişe yaşamazlar. Eğer profil konversiyon vadisine uygunsa, somatik yakınmalar dönemsel patlamalar ya da pasif agresif bir tarzda ifade edilir.

1342 Kodu

Bu tür profil veren bireyler bağımlı, immatür kişilerdir. Otistik dönemleri olabilir. Psikiyatrik olarak depresyon, anksiyete, sinirlilik görülebilir, anksiyeteyi azaltmak için başağrısı, uykusuzluk gibi somatik yakınmalarda bulunurlar.

136/316 Kodları

Bedensel semptomların (özellikle mide ve baş ağrısı) stres durumlarında ortaya çıkmasına karşın bu kişiler, diğerlerinden gelen istekler karşısında gergin ve aşırı duyarlıdırlar. Bu bireyler benmerkezcil ve narsisistiktirler ayrıca katı ve inatçı olma eğilimi içindedirler. Sıklıkla bu profil veren erkek hastalar rekabetçi, şüpheli, çabuk kızan ve diğerlerini kontrol etmeyi isteyen bireylerdir. Davranışlarını benmerkezcil olarak rasyonalize etme eğilimindedirler, diğer insanlarla ilişkilerinde içgörülerı azdır ve onlardan beklentileri çok fazladır.

Pa alt testi, Hy alt testinden 10 T puanından daha yüksekse şüphelilik ve kızgınlık oldukça belirgindir, olasılıkla erken paranoid şizofreniden şüphelenilir.

Hy alt testi, Pa alt testinden 10 ya da daha fazla T puanı yüksekse paranoid özellikler daha az belirgin olmak üzere fiziksel yakınmalar ön plana çıkabilir.

137 Kodu

Bu profili veren kişiler esnek değillerdir ve değişiklikler onları rahatsız eder. Genellikle iş ve para konularında değerlendirmeleri gerçekçi değildir Yaşamlarını eğer evliyseler eşleri yönetir. İş uyumları da bozuktur. Bu kişiler psikoterapiye istekli ve bağlı olabilirler, ancak

kendilerindeki saldırganlığı ve diğerlerine yönelik düşmanlık duyguları kabul etmek istemezler (özellikle alt test 4 düşükse).

Eğer Ma alt testi de yükselmişse ve/ya da K alt testi 50 T puanından düşükse bunlar daha da belirgindir. Anksiyete atakları çok sık olmamasına karşın özellikle sağlık ile ilgili konularda fobiler çok görülür.

138/318 Kodları

Bu kişilerde duygudurum ve inançlar çok hızlı değişmektedir, din ve dinle ilgili delüzyonlar ortaya çıkabilir. Bunlara ek olarak belirsiz somatik yakınmaları ve oldukça garip fikir ve inançları vardır. Zaman zaman major konversiyon reaksiyonları ve hipokondriyak uğraşlar, şizofrenik reaksiyonları önleyebilir. Bu gruptaki kişilerin çoğunluğuna borderline kişilik bozukluğu tanısı konabilir. Ayrıca bunların çocukluk yaşantılarında ruhsal hastalık öyküsü olan bir aile ve/ya da duygusal yoksunlukların olduğu bir dönem vardır. Erkeklerde homoseksüellikle ilgili korkular yaygındır, hatta buna karşı çıkmak için maskülen işler seçerler. Bu kişiler yapılandırılmış durumlarda daha iyi işlev gösterirler, yapılanmamış durumlarda ise garip semptomlar ortaya çıkmaktadır.

Olası Tanı: Borderline kişilik bozukluğu

1382 Kodu

138'deki yoruma ek olarak dikkate değer depresyon, konfüzyonel düşünce, alkol alımı ve intihar etme düşünceleri vardır. Böyle bireyler sıklıkla yalnızdır ya da evli iseler evlilik uyumları bozuktur. Sürekli olarak bir işten başka bir işe geçerler.

139 Kodu

Başağrısı, görme ve işitme yakınmaları, titreme ve koordinasyon bozuklukları ve çok sayıda somatik yakınmalar kişiyi rahatsız etmektedir. Bu kişilerde engellenme eşiği oldukça düşüktür, sinirlidirler ve öfke patlamaları vardır.

Eğer 4 alt testinde yükselme varsa ve K alt testi düşmüşse mücadeleci ve yıkıcı kişi olurlar. Kişilerarası ilişkilerinde de öfke ön plandadır ve boşanmalar oldukça sık görülür. Bu kişilerin genellikle mükemmelliği isteyen öyküleri vardır ve ailelerine ilgileri azdır. Alkol alımından sonra düşmanlık duyguları ön plana çıkar. Bu kod, çok sık olarak kişilik bozuklukları ya da travmaya eşlik eden kronik beyin

sendromu olan olgularda görülür. Seyrek olarak anksiyete bozuklukları ile birlikte.

Olası Tanı: Somatoform bozukluk
Organik beyin sendromu

14/41Kodu

Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Benmerkezcil, alıcı, karamsar ve sızlanan kişilerdir. Bu hastaların hipokondriyak uyumları kroniktir. Hipokondriyak yakınmaları, özgün olmayan baş ağrıları biçimindedir. Sosyal açıdan dışadönük olarak görülmelerine karşın karşı cinsle ilişkilerinde oldukça rahatsızlık yaşarlar. Aile içi ilişkilerde isyankardırlar, ancak bu duygularını ifade edemezler. Genel olarak aşırı alkol alımı tabloda görülür. Karşı cinsle ilişki sorunları tanımlarlar. Okul ve iş başarıları düşüktür. Kısa süreli semptomatik tedaviye iyi yanıt vermekle birlikte uzun süreli tedavide kalamazlar.

Çok genel olarak görülen üçlü kodlar 143/413 ve 142/412 dir.

Alt test 3 de birlikte yükselmişse, aile ve evlilik sorunları, kızgınlık ve sosyal yetersizlik duyguları ile birlikte bağımlılık ve bağımsızlık çatışmaları ön plana çıkmıştır.

Sorunlarının psikolojik kökenli olabileceğini inkâr ettikleri için tedaviye dirençlidirler.

Olası tanı: Alkolizm.

Daha seyrek olarak kadınlarda maskeli depresyon.

Yüksek 1/ Düşük 4 Kodu

Bu örüntü karşılaşılan sorunlarla başa çıkamama ve ev yaşantısındaki güçlüklerle bağlantılıdır. Öfkelerini kolaylıkla dile getirmelerine karşın yine de psikofizyolojik tepkiler verirler. Genel özellikleri sürekli yakınma ve karamsarlıktır.

146 Kodu

Antisosyal ya da impuls kontrolünde güçlüğü olan kişilerdir. Kötümser, katı, kolay ilişki kurulamayan, başkalarından gelen eleştirilere aşırı duyarlık gösteren bireylerdir. Çevrelerini şaşırtacak derecede düşmanlık gösterirler.

1469 Kodu

Kızgın, tepkisel insanlardır. Aşırı biçimde karşısındaki kişiyi suçlarlar. Hostil, huzursuz, alıcı, şüpheli, narsistik, benmerkezcil kişilerdir. Duygusal labilite, anksiyete, gerginlik, manipülatif, impulsif özellikler, eyleme vuruk davranışlar görülmektedir. İş başarısızlığı ve aile içi ilişki güçlükleri belirgindir.

15/51Kodu

Yetişkin erkekler yakınan, telâşlı ve eleştiren ve temel olarak pasif bir yaşam biçimine sahiptir. Somatik alanda sorunlar getirirler. Genel olarak açık eyleme vuruk davranış yoktur. Nadiren açık çatışma ve kararsızlık gösterirler.

Bu kodda kadın hasta daha az görülmektedir. Orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen ve eğitilmiş kadınlarda karamsarlık yakınmaları oldukça fazladır. Bağımlı gibi görünseler de kişilerarası ilişkilerinde yarışmacı ve saldırgan olma eğilimleri vardır. Bunları kontrol edebilmek için somatizasyon yakınmaları getirirler Eğitim düzeyi düşük kadınlarda saldırganlık daha azdır.

Aslında hem kadınlarda, hem de erkeklerde nadir olarak rastlanan bir koddur. Çok genel olarak erkeklerde 2, 3, 4 alt testlerinin de birlikte yükseldiği görülür.

Ergenlerde ise çatışmalarını ya da sorunlarını ifade etme güçlükleri vardır. Sıklıkla kendilerinde bedensel hastalık olduğunu kabul ederler ve diğerleri ile bunu kullanarak ilişki kurarlar. Aslında çocukluk döneminde geçirdikleri bedensel hastalıkları vardır. Genç erkekler, genellikle kadınsı ve pasif olarak tanımlanır.

15/51 kodunu yorumlarken 5 alt testini bırakarak yükselen üçüncü alt teste bakmak gereklidir.

16/61 Kodu

Bu bireyler katı, inatçı, eleştiriye aşırı duyarlı ve diğerlerini suçlama eğiliminde olan kişilerdir. Bu bireyler herşeyi baştan savarlar, savunucudurlar. Ve duygusal ilişkiden endişe duyarlar. Genel olarak öfkelerini, rasyonalizasyonu ve yansıtmayı kullanarak gösterirler. Kontrollerinin çok fazla olmasına karşın bu gruptaki bireylerde (özellikle ergenlerde) şiddetli öfke patlamaları görülmektedir.

Alt test 8 de yükselmisse alışılmamış somatik uğraşların varlığı dikkate alınmalı, belki de somatik delüzyonların olabileceği düşünülmelidir. Bazı bireyler bedensel uğraşlarıyla "psikotik bir dönemden" kurtulmaya gayret ederler.

16/61 profilleri her iki cins için de oldukça nadirdir. Eğer bu tip bir profil elde edilmişse erkeklerde 2 ve 4'ün, kadınlarda ise 3 ve 8'in olduğu üçlü bir yükselme vardır.

17/71 Kodu

Bu hastaların bedensel yakınmaları onların yaşadığı gerilim ve kaygıyı yansıtmaktadır. Yüksek enerji düzeyi ve ajitasyonla birlikte çoklu somatik semptomlar görülebilir.

Böyle kişiler gerilimle ilgili birçok yakınma ile birlikte kronik olarak gergin ve kaygılıdır. Genel olarak entellektüalizasyonun yanı sıra bedensel işlevlerdeki bozuklukları ile obsesif bir biçimde uğraşırlar. Bu kişiler sağlıklarına dikkat etme konusunda dirençlidir. Bu kod erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Her iki cins için de 172/712 ve 173/713 kodları sık görülür.

18/81 Kodu

Bu hastaların düşmanlık ve saldırganlık duyguları vardır, ancak bu duygularını uygun bir biçimde ifade edemezler. Beden işlevleri ve bedensel hastalıklara ilişkin delüzyonel düşüncelerini açıkça gösterirler. Genellikle bizar tabiatlı somatik yakınmaları bulunan kişilerdir. Somatik hezeyanları olabilir. Ayrıca somatik yakınmaları, gerçek psikotik yaşantının ortaya çıkmasına karşı savunmaları yansıtır olabilir. Bu kişilerde karşı cinsin üyelerine ilişkin hostilite vardır. Diğerlerine karşı güvensizlik, kendini onlardan kopmuş gibi hissetme, bu bireylerde uzaklaşma ve izolasyon ortaya çıkarabilir. Özellikle stres altında bu kişilerde şaşkınlık ve düşüncede konfüzyon olabilir. Somatik uğraşları gerçek ile bağlantılarını koparabilir. Öfke ve hostilite duyguları belirgindir, ancak bunu açıkça ifade edemezler.

Tedavi sürecinde basit müdahaleler bu hastalara yetmez. Kişilerarası ilişkilerinde de içgörü sağlamaya yönelik yaklaşımlarla da yarar sağlanamaz. Genel olarak üçlü kodlar 182/812, 183/813 ve 187/817'dir.

16. Kendini işe yaramaz ve iş görmez gibi görür.
17. İç çekilmiş, utangaç, ürkek, yalnız kalmaya eğilimli ve ketumdur.
18. Soğuktur.
19. Kişilerarası ilişkilerden kaçınır, insanlarla fazla konuşmaz.
20. Temkinli ve gelenekseldir.
21. Karar vermede güçlük çeker.
22. Saldırgan değildir.
23. Aşırı kontrollüdür, dürtülerini inkâr eder.
24. Hoş olmayan durumlardan kaçınır.
25. Yüzleştirmeden kaçınmak için ödün verir.
26. Huzursuzluğu nedeniyle psikoterapiye gütölüdür.
27. Var olan stresi yatıştıgında terapiyi sonlandırma eğilimindedir.

D alt testinde düşük puan alan bir birey :

1. Gerginlik, anksiyete, suçluluk ve depresyondan arınmıştır.
2. Rahat ve huzurludur.
3. Kendine güvenlidir.
4. Duygusal açıdan dengeli ve tutarlıdır.
5. Pek çok durumda etkili davranır.
6. Neşeli ve iyimserdir.
7. Sözeleştirirmede güçlüğü çok azdır.
8. Aktif, enerjik, uyanıktır.
9. Yarışmacıdır.
10. Sorumluluk alabilir.
11. Sosyal ortamlarda rahattır.
12. Liderlik rolünü üstlenir.
13. Zeki, espirili ve renklidir.
14. İlk bakışta olumlu bir izlenim yaratır.
15. Impulsif değildir, kontrollüdür.
16. Ketlenmemiştir, kendini kolaylıkla ortaya koyabilir.
17. Diğer insanlarda kızgınlık ve düşmanlık uyandırır.
18. Otorite rolünde olan kişilerle çatışması vardır.

Alt test 2'nin yorumlanması, birlikte yükselen diğer alt testlere göre değişmektedir. Depresyon çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve bunlar ancak diğer alt testlerdeki yükselmelere bakılarak yorumlanabilir. Alt test 2 tek başına T-70 değeri üzerinde bir yükselme gösteriyorsa ve depresyona ilişkin açık davranışsal belirtiler yoksa, intihar riskine karşı dikkatli olmak gerekir.

85 ve üstü T puanı: Birşeye odaklaşamayacak ya da açık bir biçimde düşünemeyecek kadar kederli olan bireyleri gösterir.

70-79 T puanı: Ciddi ve kendine güveni olmayan bireyleri gösterir. Eğer o an durumsal baskılar yoksa ve özellikle 2'de yükselmiş ise bu bireyler, tipik olarak iyi ve kötü ya da doğru ve yanlış biçiminde düşünürler. Klinik olarak belirgin depresyonu olan bireyi gösterir. Bu bireyler en küçük bir şey karşısında bile endişe duyma eğilimi içindedirler. Psikiyatrik hastalar bu ranjda yer alırlar. Bu alanda bireyin yaşadığı huzursuzluk onun iyileşme için motive olduğunun göstergesidir. Hastada depresyonun göstergeleri yoksa ve diğer alt testler yükselmemişse hastanın intihar eğilimi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

60-69 T puanı: Bu bireylerde orta düzeyde depresyon, endişe ve karamsarlık göstergesi vardır. Bu duygudurum hali, durumsal bir krize bağlı olabileceği gibi kalıcı ve geri dönüşü olmayan bir durum da olabilir.

45-59 T puanı: Bu, bireyin yaşamında iyimserlik ve karamsarlık dengesini kurduğunun göstergesidir.

28-44 T puanı: Olasılıkla neşeli, meraklı, iyimser, aktif ve dışa dönüktürler. (Bakınız Si alt testinin düşüklüğü) Bu durum bazen bu bireylerin kayıtsız gibi algılanmalarına neden olur, bu da diğerlerinde hostilité ortaya çıkarır.

Sadece D alt testinin yükselmesi: Sadece D alt testi 70 T puanının üstüne çıktığında birey reaktif bir depresyon yaşamaktadır. Yetersiz, güvensizdir, kendini cezalandırarak suçluluk duygularından kurtulma çabası içindedir ve çok fazla kaygılıdır, kendini eleştirir, sanki yaşadığı durum ya da bunu kontrol edememe için bir kefarete (ceza) ödeyecekmiş gibi. Birey depresif olduğunu (bu duygudurum başkaları için çok açık olabileceği halde) inkâr edecektir. Psikoterapi prognozu genellikle

kısa bir süre içinde iyidir ve bu tür hastalar yöneltici, yüzleştirici bir yaklaşıma iyi yanıt verirler.

Lise öğrencilerinde 2'nin tek başına 70 T puanının üstünde olması genellikle klinik olarak daha az anlamlıdır ve sıklıkla durumsal sorunlar genellikle karşı cinsle ilişkiler, ders çalışmada ya da mesleki seçenekler üzerindeki kaygıyı yansıtır. Depresyonun tek başına yüksek olduğu yüksekokul öğrencileri tipik olarak sorunlarının kökenine inme çabalarını reddederler ve bunun yerine ebeveyn yerine geçen birinden öğüt almaya çalışırlar.

Depresyon alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

21/12 Kodu (Eğer alt test 3, alt test 1'in 5 T puanı alanı içindeyse 123/213 kodlarına da bakınız.)

Yorum; depresyon ve gerginlik-kaygının daha ön planda olması dışında 12 koduna benzerdir. Depresyon genellikle apatiktir. 12 kodlarında olduğu gibi, dışa-vurma görülmez (1234/2134 kodları hariç). Bu bireylerin psikoterapiden yarar sağlamaları güçtür. Bu kod, yaş arttıkça daha sıklıkla görülür ve erkeklerde kadınlardan daha fazladır. Sıklıkla test 3 ve 7, üçüncü en yüksek testlerdir.

23 Kodu (Eğer uygunsa 213/231 kodlarına bakınız. Eğer alt test 3, alt test 2'nin 5 T puanı alanı içinde ise 32 kodlarına bakınız).

Bireyler kendilerini sıklıkla (özellikle düşük 9) zayıf, yorgun ya da tükenmiş hissederler ve bunların depresyonu genellikle uzun sürelidir. Mutsuzluğa tolere ederler ve görevlere başlayamadıkları ya da başladıklarında tamamlayamadıkları için düşük bir etkinlik düzeyinde fonksiyon göstermeyi kabul ederler. Kod, histeroid savunmaların yetersiz kullanılışı sonucu ortaya çıkar. Hastalar azalmış aktivite düzeyi, apati ve çaresizlik içeren depresyon gösterirler. Bu depresif semptomatoloji, histeroid mekanizma ve savunmaların yetersiz kullanımı sonucu ortaya çıkmış olabilir. Hastalar kişilik özellikleri olarak immatür, yetersiz ve bağımlı olarak tanımlanırlar. Kronik sorunlarına alışmışlardır ve yıllar boyunca bu azalmış etkinlik düzeyinde işlevlerini sürdürürler. Bedensel yakınmalar, sıklıkla histerik niteliktedir ve değişkendir.

Bu hastalar psikoterapiye dirençlidir, çünkü kronik sorunlarına nasıl uyum yapacaklarını öğrenmişlerdir ve en düşük etkinlik düzeyinde yaşamlarını devam ettirirler. Değişime ilişkin motivasyonları düşüktür.

En sık üçlü kodlar 231/321, 234/324 ve 237/327 dir.

Paradoksik olarak, 23 kodlu erkekler görünüşte çok fazla başarı yönelimlidir, ancak sıklıkla işlerinde fark edilmediklerinden yakınırırlar. Daha fazla sorumluluk isteyebilirler, ancak gerçekte istedikleri fark edilmek olduğundan bu sorumluluklardan da yakınırırlar. Bu koddaki bazı erkekler (özellikle 237 ya da 239 kodları), özellikle ciddi, gayretli, çalışkan ya da rekabetçi görünürler, ancak aynı zamanda da fark edilme istekleri açısından hem bağımlı, hem de immatürdürler.

23 kodlu kadınlar (özellikle düşük Mf ya da düşük Ma) zayıflık, apati ve belirgin depresyon gösterirler. Evde ve işte mutsuzluk ve genel bir etkin olamama hali kronikleşmiştir, ayrıca evlilik ve aile uyumsuzluğu öyküsü vardır (Ancak boşanma sık değildir). Güvensizlik ve rahatsızlıklarına karşın yardım aramak için çok az çaba gösterirler.

Bu kod 25 yaşın üzerindeki kişilerde daha sık ise de ergenlerde de görülür ve kötü arkadaş ilişkileri ile bağlantılıdır. Bu ergenler tipik olarak okul ortamında ve okul dışında çok az arkadaşı olan ve yalnız bireylerdir. Genellikle pasif, uysal ve yumuşak başlıdırlar. Aile örüntülerinde, sıklıkla ilgisi sınırlı bir baba ve çok ilgili bir anne vardır. Cinsel eyleme vuruk davranışlar ve ilaç kötüye kullanımı, ergenlerde bu örüntü ile bağlantılı değildir.

Olası Tanı: Depresif nevroz

213/231 Kodları (Ayrıca 123 Koduna da Bakınız)

Kronik nevroz bir durum olabilir ancak

Yorumu 21-koduna benzerdir; ancak depresyon, durumun daha önemli bir parçasıdır. Bağımlı, immatür bireylerdir, mutsuzluğu tolere etmeyi öğrenmişlerdir. Bu hastalar depresyonun yanı sıra baş ağrısı, göğüs ağrısı ya da bulantı ve kusma gibi hipokondriyak yakınmalar gösterirler. Ancak, bunların depresyonu gülümseyen bir depresyon olabilir, yani bunlar ağlarken gülümserler, ancak neden olduğunu bilmezler. Kızgınlığı inkâr ederler, ketlenmişlerdir ve abartılmış bir sevgi gereksinimleri vardır. Tipik olarak yakın aile üyelerinden çok az destek gördüklerini düşünürler ve bunların önemli bir kısmının çok genç yaşta iken ebeveynlerinden birini kaybetme öyküsü vardır. Duygusal açıdan bağlanmada çatışma yaşamaktadırlar. Sempatik talebinde bulunmalarına ve semptomlarından ikincil kazançlar sağlamalarına karşın, çok fazla bağımlı olmaktan dolayı hoşnut değillerdir. Alt test 7 de yükseldiğinde endişe, klinik görünümün özel bir parçasıdır.

Olası tanı: Depresif reaksiyon ya da somatoform bozukluk

24/42 Kodu

Bu tür profil veren hastalar, immatür, bağımlı ve benmerkezcildir. Dürtülerini kontrol etmede zorluk çekmektedirler, ancak şu anda depresyon, pişmanlık ve suçluluk yaşamaktadırlar. Sosyal olarak kabul edilmeyen bir biçimde eyleme vurmadan sonra, rahatsızlık yaşarlar. Onların görünen suçluluk duyguları şiddetli olsa da (hatta olayla orantılı olmayacak kadar fazla) eyleme vuruk davranışlar, gelecekte döngüsel bir biçimde tekrarlanır. Aile ile ilişki sorunları, iş kaybı ve öyküsü bu örüntüye eşlik eder. Ağır bir şekilde içme, madde kötüye kullanımı ya da alkolizm ve yasal sorunlar sıktır. Çoğunlukla 3, 7 ya da 8 üçüncü yükselen testtir.

Bu örüntüdeki ergenler kabul edilmiş sosyal standartlara belirgin bir aldırmaçlık gösterirler, özellikle otorite figürlerine karşı küskün, tartışmacı, başkaları ile yakınlık kurmaktan korkan, suçlayıcı ve sıklıkla ilaç kullanan bireylerdir. Yasal ihlaller (tutuklanma, mahkumiyet, göz hapsinde olma) geneldir, bunun yanında evden, ya da tedavi merkezlerinden kaçma da görülür. Bu örüntüdeki çoğu ergenler kendilerini diğer aile bireylerinden uzaklaşmış hissedirler ve dayanılmaz ve çok çatışmalı ev ortamlarından kaçmayı isterler. Ebeveynleri şefkatsiz ve tutarsız olarak algılarlar. Okulda güçlükleri vardır ve genellikle belirli bir şeye odaklaşmada güçlükleri vardır ve okuldan kaçarlar.

Bu, evlilik dışı çocuk sahibi olan kadınlarda sık görülen bir profil örüntüsüdür ve rastgele cinsel davranımla bağlantılıdır. Bu bireyler davranışlarını değiştirmek için kesin bir biçimde niyetli olabilirler, ancak bu örüntü devamlıdır ve uzun sürede prognoz iyi değildir. Hızlı, geçici ilerleme gösterebilirler, ancak yüzeysel değişikliklerden daha öteye gidecek kadar tedavide kalamazlar. Görünüşte saygılıdır, ancak terapide yüzleştirildiklerinde ya da zorlandıklarında tedaviye devam etmezler, hatta sorunları ile uğraşmak yerine bulundukları şehri terk ederler ya da iş değiştirirler. Genelde başkalarının kendilerinden beklentileri olduğunda kaçma, daha çok görülmektedir. Tedavide katı sınırlamalar, stratejik terapi yordamaları, sık görüşme ve çevresel düzenlemelerin bir arada kullanımı çok yardımcı olabilir.

Olası Tanı: Psikopatik kişilik bozukluğu tanısı konulan bireylerde duruma bağlı depresyon
Dürtü kontrol bozukluğu
Stres karşısında alkol ya da madde kullanımı

Psikoterapötik müdahale kişilik sorunlarına bağlı olarak zordur, depresif özellikler kronik niteliktedir ve onların karakter yapılarının içine girmiştir.

243/432 Kodları

24/42 kodundaki yorumlarda tanımlanan özelliklere ek olarak bu bireyler kızgınlığı bastırma ve inkâr yoluyla duygusal kontrolü sağlamaya ilişkin yoğun çatışma içindedirler. Kızgınlıklarını pasif-agresif biçimlerde ya da (eğer açıksa) öfke patlamaları biçiminde ifade ederler. İmmatürite, bencillik ve başkalarının onları nasıl gördüğüne ilişkin içgörü eksikliği vardır. Bu bireyler, eyleme vuruk davranışları olan uçlardaki bireylerle ilişki kurarlar ve bu nedenle de kendi antisosyal eğilimlerini başkası aracılığıyla tatmin ederler.

247/427/472 ve 742 Kodları (Ayrıca 274 koduna da bakınız)

Aile ve evlilik sorunları bireyin öfkesinden kaynaklanmaktadır, ancak birey bunu ifade edemez ve sonuçta suçluluk duyguları ortaya çıkar. Gergin, endişeli ve sosyal açıdan yetersizdirler, depresyonları vardır. Depresyonlarını ortadan kaldırma çabası içinde aşırı alkol kullanımı ya da epizodik alkol alımları vardır. Bu bireyler genelde başarısızdır, olası başarısızlık nedeniyle herhangi bir şeyi denemekten korkuyor gibidirler. Sorunlarının açıkça görülmesine karşın bunları tartışmada samimi ve açık değildirler. Ayrıca, çok küçük problemlere aşırı tepki gösterirler ve bunlar sanki olağanüstüymüş gibi davranırlar.

Bu örüntüdeki erkekler, genellikle bağımlı ve immatür yapıda olmalarına karşın (özellikle test 5 de yüksek ise) sözel olarak saldırganlardır. Evlilik sorunları vardır ve genellikle eş güçlü ve baskındır ve/ya da kısa süreli evlilikler yaparlar. Bu erkekler annelerine daha yakındırlar.

Kadınlar (özellikle Mf alt testi düşükse) kendilerini zayıf, aşağı, suçlu ve çekingen olarak sunarlar. Bunlar gerçekte başkalarının kendilerini korumasını ve baskı altına almasını isterler. Bu tür ilişkiler sıklıkla suçluluk duygularının, genellikle ifade edilmeyen öfkenin bedelinin ödenmesi gibidir. Sıklıkla bunların öyküsünde çok çalışkan ve başarılı bir baba vardır.

Terapi prognozu sıklıkla iyi değildir, çünkü tedavideki kaygıya dayanma konusunda isteksizdirler. Katı, yönlendirici, amaç yönelimli terapi, belki de atılacak eğitimi içeren tedavi düşünülmelidir.

Olası tanı: Pasif-agresif kişilik bozukluğu
Depresif semptomlar
Anksiyete bozukluğu

248 Kodu

Depresyon, küskünlük, aile ve evlilik sorunları çok olsa da, bu tür bireyler 24/42 kod tiplerinden daha az açık kızgınlık biçiminde eyleme vurma davranışı gösterirler. Bunun yerine, kızgınlık içeren fanteziler kurarlar, başkalarına karşı kendilerini güvensiz, uzak ve bağları kopmuş gibi hissederler. Ancak dürtüleri üzerindeki kontrolü kaybetmekten korkarlar ve doğal olmayan, rahatsız edici düşünceler üzerinde çok fazla dururlar. Sıklıkla başkaları tarafından huysuz ve nasıl davranacakları belli olmayan kişiler olarak görülürler. Çeşitli cinsel sorunlar, intihar düşünceleri ve çok sayıda intihar girişimleri vardır.

248 Kodu/ Yüksek F Kodu

Temel şizofrenik konfigürasyon

25/ 52 Kodu

Bu koddaki erkekler, içe dönük, pasif, kararsız, depresif, ancak idealist bireylerdir. Kaygılı ve geri çekilmişlerdir, somatik yakınma öyküsü verirler ve açık bir biçimde düşünememekten yakınabilirler. Nadiren flört ederler ve genellikle heteroseksüel uyumları göreceli olarak kötüdür. Sıklıkla bu koddaki erkeklerde, 7, 3, 4 ya da 0 alt testleri de birlikte yükselir.

25/52 koddaki kadınlar, depresiftirler ve kendilerine yönelmişlerdir, ancak başkalarına dayanmak yerine kendi kendilerine yetmeye çalışırlar.

Bu koddaki ergenler, genellikle kardeşleri ya da arkadaşları ile ilişkilerinin kötü olması, utangaçlık, aşırı negativizm ya da aşırı duyarlık nedenleri ile başvururlar. Kişiler arası ilişkilerde utangaç, pasif ve çekingen olan bu ergenler, sıklıkla mükemmeliyetçilik ve titizlikle birlikte aşırı entellektüalizasyon gösterirler. Genellikle kaygı, suçluluk, aşırı duyarlık, kendini suçlama, depresyon ve sosyal beceriksizlik vardır.

26/62 Kodu

Alıngan, depresif ve eleştiriye aşırı duyarlı kişilerdir. Bu bireylerde altta yatan güçlü bir kızgınlık duygusu ve sıklıkla süren kişiler arası ilişki güçlükleri vardır. Genellikle paranoid eğilim gösterirler. Nötr durumları kötü niyetli olarak değerlendirir ve yetersiz veriye dayanarak sonuçlar çıkarırlar. Küskünlük, ajitasyon, yorgunluk ve saldırganlık genellikle belirgindir. Sıklıkla bu bireyler, başkaları onları reddetmeden önce onları reddetme düşüncesi ile ya da bağımlı olmaktan kaçınma aracı olarak kavgaya hazırdırlar. Pa alt testi belirgin bir biçimde yükseldiğinde ve/ya da 4 ve 8 alt testi 70 T puanının üzerinde ise, bireyin psikozun erken dönemlerinde olma olasılığı artar. Bu tür hastalar, kızgın, depresif kişilerdir. Çok şiddetli kızgınlıklarını çevrelerine ve kendilerine karşı yöneltebilirler. Kızgınlıklarını ifade edemeyen diğer deprese hastalara göre, bu hastalar açıkça hostile ve küskün olabilirler.

Olası tanı: Psikozun erken dönemi

27/72 Kodu (Ayrıca 273/723, 247/274, erkekler için 275/725, kadınlar için 271/72 ve 278/728 kodlarına bakınız.).

Bu kodlar psikiyatri polikliniklerine başvuranlar arasında çok görülür. Gerginlik, depresyon, sinirlilik, kaygı, suçluluk, kendini değersizleştirme, aşırı biçimde kendini sorgulama ve boşuna aynı şeyler üzerinde sürekli olarak durma çok görülen özelliklerdir, genellikle bunlara yetersizlik duyguları, kendine güvenin olmaması, iş etkinliğinin azalması ve uykusuzluk eşlik eder. Bu bireyler yaşamlarında birçok kişisel başarıları olmasına karşın, kişisel yetersizlikleri üzerinde odaklaşırlar. Düşüncelerindeki katılık, doğru ve yanlış konular üzerinde çok fazla durmayı yaratır. Çoğunlukla bu bireyler aşırı kontrollüdürler ve duygularını açık olarak ifade etmekte zorluk çekerler, bu nedenle cinsel alanda çatışma yaşarlar. Kişiler arası ilişkilerde sıklıkla bağımlılık ve pasiflik gösterirler.

En sık görülen üçlü kodlar 270/720, 278/728, 273/723 ve 271/721 dir.

27 kod tiplerinde bazı yükselmeler, bireyin psikoterapi için iyi aday olmasının göstergesidir; çünkü bu genellikle içsel rahatsızlık ve kendini sorgulama eğilimini değiştirmek için güdülenmiş olmanın işaretidir, ancak çok fazla yükselmeler, (örneğin, 85 T puanının üstünde) sıklıkla bireyin sözel psikoterapide yeterli derecede odaklaşamayacak kadar ajite ve endişeli olduğu anlamına gelir ve diğer müdahale formları (ilaç gibi) gerekli olabilir.

273/723 Kodları

Bu hastalar pasiftir, kişiler arası ilişkilerinde çok bağımlı oldukları zamanlar kendilerini çok rahat hissederler. Kendilerinin korunma ve bakım altında bulundurulmalarına çok kolay adapte olurlar.

Bu bireyler, çoğunlukla kendileri için çok yüksek standartlar belirleyerek stres yaşarlar. Stresleri biriktiğinde, başkalarından yardım isterler, depresyon ve endişeleri içinde belirgin bir biçimde ve yapışırmasına bağımlı hale gelirler. Bu görünen çaresizlik, uysallık ve kendini değersizleştirme düşünceleri başkalarını, onları kurtarma ve korumaya yöneltir.

Hs alt testi de yükselmisse, bu bireyler kaygıyla bağlantılı somatik yakınmaların yanı sıra, kendine acıma, kendini suçlama ve başkalarının onlara bakmasını istemelerine karşın sosyal geri çekilme gösterirler.

274/724 Kodları (Eğer test 4 ve 7 birbirlerinin 5 T puanı alanı içindeyse 247 ve 427 kod yorumlarına da bakınız.)

Yoğun yetersizlik ve suçluluk duyguları vardır. Kendilerini küçülterek, kendi zayıflık ve yetersizlikleriyle sürekli uğraşırlar. Diğer kişilere olan aşırı bağımlılıklarını kabul etmezler. Çoklu nevrotik belirtilerin gerçek bir düşünce bozukluğunu maskeleymesi ihtimali dikkatle incelenmelidir. İntihar düşünceleri, niyeti ve planı sıklıkla görülür. Bu açıdan dikkatle değerlendirilmelidir. Hastaların olası klinik tanısı depresif reaksiyon olmakla birlikte, kişilik yapıları oldukça kalıcıdır. Temel anksiyetelerini ve davranış biçimlerini değiştirmek çok zordur.

Bu koddaki erkekler çoğunlukla annelerine bağımlıdır ve bağımlı ilişkiler ararlarsa da genellikle bu tür ilişkilere eşlik eden kontrolü istemez ve ilişkiyi sonlandırırlar. Alt test 3 yükseldiğinde kronik alkolizm olasılığı fazladır, alkol kaygıyı azaltmak ve depresyonla başa çıkmak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu profildeki kadınlar sıklıkla babaları tarafından ilgi ve övünme nesnesi olmuşlardır. Genellikle, kendilerini izole ederler, zayıf ve çekingen görünmeye çalışırlar (özellikle alt test 5 düşükse). Bunların başkaları ile ilişkileri, sık sık zorluklar gösterse de evli erkeklerle uzun süreli ilişkileri

275/725 Kodları

Endişe, depresyon ve aşırı düzeyde aynı şeyler üzerinde durmaya ek olarak, bu bireyler çekingenlik görülür. Kronik bir başarısızlık duygusu ya da kendilik değeri konusunda ambivalansları var gibidir. Bunların kendilerini sunmaları yetersiz, zayıf, aşağı, suçlu ve pasif biçimindedir ve bu alt test 4 düşük olduğunda daha belirgindir. Bu bireyler sürekli olarak başkalarının onları küçümsediği ilişkiler arayarak depresyonları için bedel öderler ve bu tür ilişkilerde çok rahat ederler. Karşı cinsle ilişkilerde güçlükler vardır.

278/728 Kodları

Gergin, kaygılı, depresif, aşırı biçimde aynı şeyler üstünde duran ve kendilerine ilişkin kuşkuyla dolu olan bu bireylerde intihar düşüncesi ya da girişi olasılığı yüksektir. Obsesif düşünme, korkular ve fobiler çok görülür, bunların yanı sıra kendi başarısızlıkları üzerinde yoğunlaşırlar. Bu insanlar çoğunlukla çok titiz ve mükemmeliyetçidirler, kendileri ve başkaları için çok yüksek standartlar koyarlar ve bu standartlara ulaşamadıklarında çok fazla suçluluk yaşarlar. Bunların aşırı biçimde kendilerini sorgulamaları ve kendi kendilerine baskı yapmaları sıklıkla belirli birşeye odaklaşma güçlüklerine ve performansta azalmaya yol açar ve bu da onların depresyon ve kaygısını artırır. Karşı cinsle aşk ilişkileri gibi duygusal bağlantılar kurmada özel zorlukları vardır. Sıklıkla bu tür ilişkilerin çok ufak ayrıntıları üzerinde odaklaşır ve olması gerekenden daha fazla dikkat eder ve endişelenirler. Kontrol, eleştiri, kabul edilme ve kızgınlığın ifadesi etrafındaki konular çok geneldir.

Bu koddaki, özellikle alt testlerden K ve Hs, 50 T puanının altında olduğunda ve/ya da Ma alt testi yükseldiğinde intihar olasılığı dikkatle değerlendirilmelidir. Bu koddaki Ma alt testinin yükselmesi, depresyonun ajite yönünü gösterir. Eğer Si alt testi yükselmisse bireyin depresyonu daha çok kroniktir ve buna utangaçlık, içe çekilme ve fiziksel yetersizlik duyguları eşlik eder. Alt testlerden Pd düşük olduğunda pasiflik ve çekingenlik ön plandadır, sıklıkla cinsel ilgilerde azalma ve cinsel yetersizlik buna eşlik eder.

Kadınlarda 278/728 kodunda 5 alt testi düşmüşse bu kişiler, kendileri için bedel ödemek gerektiğini hissederler ve hatta bu şekilde başkalarının kızgınlığını arttırırlar. Bu kadınlar çoğunlukla mazohistik biçimde kendi kendilerini azarlar ve onların baş ağrıları, sırt ağrıları ve

cinsel güçlükleri içeren çok çeşitli fiziksel yakınmaları vardır. Çoklu nevrotik semptomlar gösterirler. Major semptomlardan depresyon, sinirlilik ve obsesyonlar görülür. Kararsızlık, şüphe ve kaygı karakterleridir. Obsesyonlarından dolayı düşünceye iyi kanalize olamazlar. Düşünce bozukluğunun iyi bir muayenesi gerekir. Sosyal olarak yetersiz kişilerdir. Aşırı obsesyonları için psikofarmakolojik tedavi gerekir. Psikoterapide daha çok problem çözücü ve destekleyici terapi tercih edilmelidir.

270 Kodu

Gergin, depresif, sinirli, kendini aşağılayan, suçluluk duyguları olan kişilerdir. Devamlı aynı konu üzerinde düşünürler; yetersizlik, güvensizlik duyguları vardır. Aşırı kontrollü olmaya çalışırlar, duygularını açığa vurmada zorluk çekerler, kişiler arası ilişkilerde bağımlıdır, kendilerini ortaya koymaktan kaçınırlar. İçeride tutumları kronik düzeydedir. Şizoid kişilik bozukluğu tanısı konulabilir.

28/82 Kodu (Uygunsa 281/821, 284/824 ve 287/827 kodlarına da bakınız.)

Bu kod tipindeki kişiler anksiyete ve ajitasyonla birlikte şiddetli depresyon yaşayan hastalardır. Depresyon ve ajitasyon, genellikle dikkat ve konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve konfüzyon hali ortaya çıkarabilir. Sıklıkla obsesif ruminasyonlar sergilerler. Düşünce bozukluğu, yorgunluk gibi somatik yakınmalar sık görülür. Kişiler arası ilişkilerden ve aktivitelerden kendilerini izole edip çekilme eğilimleri vardır. İntihar girişimleri olabilir. Dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle prognoz açısından hastanın değişmesi ihtimali zayıftır. Bu özelliklerin yanısıra "şizofrenik" özellikler de gösterebilirler. İşitsel ve görsel hallüsinasyonlar ve sistemli hezeyanlar olabilir. Düşünce bozukluğu değerlendirilmelidir. Garip karakterde somatik semptomlar görülebilir. Deprese, izole ve çekiniktirler. Bu kronik uyum örüntüsü genellikle hastaneye yatmayla son bulur. Bu hastalara en sık konulan tanı manik depresif psikoz, melankoli ve şizoaffektif şizofrenidir.

Özellikle ergenler başkaları ile duygusal bağlar kurmaktan korkarlar, duygusal bağımlılıkları ve cinsellik konusunda çatışmaları vardır. Sıklıkla çocukluk döneminde tekrarlanan incinme öyküsü anlatırlar. Karşı cinsle ilişkileri genellikle çok azdır, üstelik sorunlar ya da sapkın davranışları içerir. Ergenler sıklıkla duygularını uygun olmayan biçimlerde gösterirler, okuldan kaçarlar ve madde kötüye kullanım öyküleri vardır.

Bu bireylerle terapötik ilişki kurmak zordur, psikoterapi prognozu kötüdür. Psikofarmakoloji en azından başlangıçta yararlı olabilir.

281/821 Kodları

28/82 kodu ile bağlantılı genel özelliklere ek olarak, bu bireylerin çok çeşitli somatik yakınmaları vardır. Genellikle bunlar belirsiz ya da medikal yönden atipiktir ve titremeler, düşünme güçlükleri, ya da hatta somatik delüzyonlar içerebilir. Bu örüntü psikotik bir epizoddan önce gelen kendi üzerinde yoğunlaşmayı temsil ediyor olabilir ve genellikle açık bir gerginlik ve entelektüel konfüzyon ile bağlantılıdır. Diğer bireylerde, özellikle test 3 de yükselmiş ise, bu somatik yakınmalar ve bunlarla bağlantılı davranışlar, terapisi kurtarma davranışlarında bulunmaya teşvik edebilir, ancak birey bu yardımı reddeder.

284/ 824 Kodları

Yetişkinlerde bu kod sıklıkla şizoid ya da şizofrenik durumlarla bağlantılıdır ve alt test F de genellikle yükselmiştir. 28/82'nin özelliklerine ek olarak kızgınlık, isyankârlık, başkalarından uzak ve soğuk olma duyguları güçlü bileşenlerdir. Dürtü kontrolünü kaybetme korkuları çoktur (özellikle Pd alt testi 80'in üzerinde ise) ve eyleme vuruk davranışlar, garip ve tuhaf şekillerde olur. Sosyal alanda ve evlilikte uyumsuzluk olasıdır (test 4, test 2 ya da 8'in 5 T puanı alanı içinde ise 482/842 kodlarının yorumuna bakınız.).

Ergenlerde bu kod, yetişkinlerde belirtilen devamlı bir patolojiyi temsil etmiyor olabilir. Bunun yerine, bu kod daha çok birçok ergende bulunan isyankârlığı ve sosyal gruptan uzaklaşmayı yansıtır. Dürtü kontrolünde zayıflık vardır ve bunun yanı sıra doğal olmayan davranışlar ve duygularda kısıtlılık görülür, ancak altta yatan patoloji daha az şiddetlidir.

287/827 Kodları

Bu koddaki bireyler depresyon, kaygı ve tanjansiyel düşünce süreçleri gösterirler, kendilerini insanlardan uzak hissederek, eleştiriye çok fazla duyarlıdır ve genelde insanlara güvenmezler. Bunlar çoğu zaman belirli bir şeye odaklaşamama, baş dönmesi epizodları, mental konfüzyon, uykusuzluk, görev ve sorumlulukları yerine getirme yeteneğinin azalması gibi önemli mental güçlükler gösterirler. Ayrıca, değişken ya da uygunsuz duygular, hatta hallüsinasyonlar ya da açık düşünce bozuklukları vardır. Tipik olarak bu bireyler, genellikle bağımlılık

korkularına bağlı olarak yakın kişilerarası ilişkilerden kaçınırlar ve duygusal bağlanmadan korkarlar. Sıklıkla cinsellik ve kendini ifade etme konularında çatışmaları vardır. İntihar düşünceleri, zihnin sürekli birşeyle meşgul olması ve tehditler çok olasıdır ve eğer K alt testi 50 T puanının altında ise ve Ma alt testi 70 T puanının üzerinde ise bunlar dikkatle değerlendirilmelidir. İntihar çoğunlukla garip biçimlerde gerçekleştirilir.

29/92 Kodu

Bu gruptaki kişiler benmerkezcil ve narsisistik olma eğilimindedirler. Kendi değerlerini abartırlar.

29/92 profil kodlu bireyler yüksek bir enerji düzeyine sahiptirler, ancak bu depresyon ve kaygı ile bağlantılıdır. Yüksek enerji düzeyi ya başa çıkmayı ya da bir kontrol kaybını telâfi etme girişimini temsil eder. Genellikle üç tip birey bu kodu elde eder:

Ajite depresyonu olan bireyler: Bireyde ağlama, feryat etme, depresif ruminasyonlar belirgindir. Bu bireyler çocuklar gibi ilgi çekmek için çok fazla duygusal olabilirler.

Altındaki depresyonlarıyla manik savunmalar kullanarak başa çıkmaya çalışan bireyler: Bazı bireylerde büyüklük düşünceleri ve inkâr, depresyonu maskeleyebilir. Ancak, çoğunlukla bu savunmalar uzun süre etkili değildir. Sıklıkla bu bireyler, daha sonra çok fazla içki içme davranışına dönerler.

Organik beyin sendromu olan, işlevsellik ve yeteneklerindeki azalmanın farkında ama bunu inkâr etmeye ve başkalarından saklamaya çalışan bireyler: Bu bireyler daha önce kolaylıkla yaptıkları şeyleri yapamamanın eksikliğine bağlı ajitasyon göstereceklerdir.

Sıklıkla test 3 ya da 4, üçüncü en yüksek testtir.

20/02 Kodu

Bu bireylerde sinirlilik, zayıflık, yorgunluk, benlik değerinde düşme belirgin özelliklerdir. Bu kod sosyal olarak geri çekilmiş hafif, ancak kronik depresyonu olan bireyleri gösterir. Bu depresyon sıklıkla bireyin kişiler arası ve sosyal becerilerinin kötü olması ile bağlantılıdır ve aşağılık ve utangaçlık duyguları ile birliktedir. Bu profildeki hem yetişkinler, hem de ergenler özellikle sosyal ilişkilerde kendilerini sinirli ve engellenmiş hissederek ve çok az arkadaşları vardır. Çoğu (özellikle test 1 düşük ise)

fiziksel olarak çekici olmadığını da düşünür. Uykusuzluk, suçluluk duyguları ve endişe de sıklıkla vardır. Bu kod tipinde çoğunlukla test 7 ya da 4, üçüncü en yüksek testtir.

Olası tanı: Pasif-agresif kişilik

207 Kodu

Bu kod tipindeki bireyler gergin, kaygılı, ürkek kişilerdir. Kendilik değerinde düşme vardır. Şizoid içe çekilme gösterirler. Sosyal ortamlarda yetersizlik duygusu ve gerçek sosyal beceri eksikliği ile içe dönük tutum sergilerler. İnsanlarla etkileşimlerinde güvensizdirler, karşı cinsle ilişkilerinde mutsuzdurlar. Depresyonları ile yaşamayı öğrenmişlerdir. Bu bireylerin saldırganlık ve öfke patlamaları göstermesi beklenmez.

3.Histeri (Hy) Alt Testi

Histeri, fizik bir neden olmadan bir organın işlevinin kaybedilmesi biçiminde bir hastalıktır. Bu alt test nevrotik bozukluklardan konversiyon histerisine tanı koymada yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Genel bir çocuksuluk, çabuk sinirlenme, neşelenme, psikolojik semptomları red, sorumluktan kaçma gibi özellikleri vardır. Bu grup hastalarda ikincil kazançlar çok fazladır. MMPI'da çok değişik tipte soruların toplandığı bir alt testtir. Hy alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 10'da gösterilmiştir:

Tablo 10: Histeri alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 60)

Doğru											
10	23	32	43	44	47	76	114	179	186	189	
238	253										
Yanlış											
2	3	6	7	8	9	12	26	30	51	55	
71	89	93	103	107	109	124	128	129	136	137	
141	147	153	160	162	163	170	172	174	175	180	
188	190	192	201	213	230	234	243	265	267	274	
279	289	292									

Erkeklerde ortalama: 19.31, kadınlarda ortalama: 22.33
(Savaşır, 1981)

Hy alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)

1. Strese fiziksel semptomlar geliştirerek tepki verir ve sorumluluktan kaçır.
2. Baş ağrısı, göğüs ağrıları, güçsüzlük, taşikardi, anksiyete atakları vardır.
3. Semptomlar bir görünür, bir kaybolur.
4. Semptomlarının nedenlerine ilişkin içgörü azdır.
5. Kendi güdü ve duygularını anlamaz.
6. Üzüntüye eğilimlidir.
7. Gerginlik, anksiyete, depresyon belirtileri göstermez.
8. Nadiren delüzyonlar, hallüsinasyonlar, hezeyanlardan yakınıır.
9. Psikotik tanısı konulamaz.
10. Eğer psikiyatrik hastaysa sıklıkla konversiyon bozukluğu tanısı konulur.

11. Psikolojik açıdan gelişmemiş, çocuksu ve immatürdür.
 12. Kendine odaklıdır, narsistik, ben-merkezcildir.
 13. Diğerlerinden ilgi ve sevgi bekler.
 14. İlgi ve sevgiyi alabilmek için dolaylı ve baştan çıkarıcı yollar kullanır.
 15. Hostilite ve kızgınlığını açık olarak ifade etmez.
 16. Sosyal açıdan katılımcıdır.
 17. Dost canlısı, konuşkan, gayretli ve ataktır.
 18. Kişilerarası ilişkilerinde yüzeysel ve çocuksudur.
 19. İnsanlarla kendi çıkarları için ilgilenir.
 20. Zaman zaman önemsemediği ve anlamaya çalışmadığı cinsel açıdan eyleme vuruk davranışlar sergiler.
 21. Başlangıçta tedaviye isteklidir.
 22. Doğrudan verilen akıl ya da önerilere uyar.
 23. Kendi davranışının nedenlerine ilişkin içgörü kazanması yavaştır.
 24. Psikolojik yorumlara ve tedaviye dirençlidir.
 25. Okulda ya da işte başarısız olacağına ilişkin endişe taşır.
 26. Evlilikle ilgili mutsuz yaşantıları vardır.
 27. Sosyal grup tarafından kabul görmediği hissini duyar.
 28. Otorite figürleriyle sorunu vardır.
 29. Aile öyküsünde reddedici baba figürü bulunur.
- Hy alt testinde düşük puan alan bir birey:**
1. Temkinli, geleneksel ve uysaldır.
 2. Maceracı ve çalışkan değildir.
 3. İlgi alanları daralmıştır.
 4. Sosyal katılımı sınırlıdır.
 5. Lider olma rolünden kaçır.
 6. Arkadaş canlısı değildir, anlaşılması zor biridir.
 7. Kuşkucudur, diğer insanlara güvenmez.
 8. Gerçekcidir, mantıklıdır, sorunları aşama aşama çözer.
 9. Yaşama bakışı donuktur.

85 T puanı ve üstü: Aşırı immatür, benmerkezcil ve bağımlı kişilerdir. Bastırma savunma mekanizmasını kullanmaları şaşırtıcıdır. Bu içgörü eksikliği olduğunun göstergesidir. Semptomlar gerçek organik patolojiye uymamaktadır. Genellikle kroniktir ve ciddi rijidite vardır.

76-85 T Puanı: 70-75 T puanında bildirilen özelliklere ek olarak bu bireyler uzun süredir devam eden gerginliğe bağlı konversif semptomlar geliştirmişlerdir. Semptomlar baş ağrısı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, zayıflık, baş dönmesi ve baygınlıktır. Uzun süredir devam eden güven duymama, immatürite ve organize olmuş bedensel yakınmaları vardır.

70-75 T puanı: Birey bastırma ve inkârı çok fazla kullanan, çok fazla itaat eden (uyan), saf ve çocuksu biçimde benmerkezcil, anksiyete ile bağlantılı somatik yakınmaları olan ya da bunların hepsine sahip bir kişidir. Histeroid mekanizmaları kullanır ve bunlarla ikincil kazanç elde eder. Bu bireyler çok fazla sevgi, kabul ve destek isteyebilirler ve çok aktif (yüzeysel olsa da) sosyal yaşamları vardır, ancak davranışları konusunda içgörülerі oldukça azdır. Bu bireylerin bazıları, açık bir biçimde teşhirci ve seksüel ya da saldırganlık düzeyinde dışavuran davranışları olabilir, bu sırada inkâr ve bastırmayı aşırı bir biçimde kullanırlar. Sevilmeye olan güçlü gereksinime bağlı olarak, bağlanma gerektiren durumlarda verdikleri ilk tepki genellikle çöşkulu olacaktır. Ancak, hemen ya da daha sonra, kendilerinden istenenler konusunda kızgın ve kinci olurlar ve genellikle pasif biçimde dirençlidirler, sızlanıp, yakınırırlar ve kendilerini bu durumdan uzaklaştıracak somatik şikayetleri olur.

60-69 T puanı: Burada iki farklı örüntü vardır:

1. Eğer Hs'nin yükselmesi Hy ile aynı düzeyde ise ve D alt testi, 1 ve 3 alt testinden 10 T puanı düşükse histerik kişiye işaret etmektedir. Stres sırasında somatizasyona sığınma görülebilir.
2. Eğer Hy alt testi Hs alt testinde 10 T puanı yüksekse histerik özellikler belirgindir. Bu bireyler kendine odaklaşmış, kendilerini olduğundan farklı ve mükemmel kişiler olarak görmek isterler. Kişilerarası ilişkilerde içgörü azlığı vardır.

45-59 T puanı: Bu alana özgü bir tanımlama yoktur.

24-44 T puanı: Kendilerini sürekli eleştirirler. Olumlu kişilerarası ilişkileri inkâr etme eğilimi vardır. Si alt testinde yükselme, bireyin diğer insanlardan kaçma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Sadece Hy alt testinin yükselmesi: Sadece 3'ün yüksek olduğu ve diğer hiçbir alt testin 70 T puanının üstünde olmadığı durumda, bireyin kabul edilme ve sevmeye gereksinimi fazladır. Ait olduğu grup tarafından reddedilme olasılığına yönelik endişe yaşar, kızgınlık ve kendini ortaya koymayı içeren yüzleşme durumlarıyla (akademik ortamlar gibi) uğraşırken çok rahatsız olur. Tartışmalarda iyimserliklerini ve diğer insanlarla olan iyi ilişkilerini vurgularlar ve kendilerinde doğal olmayan ya da sapkın davranışları en aza indirgerler.

Hy alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

Yüksek 3/ Yüksek K Kodu

Alt testler 3 ve K ikisi birden yüksek olduğunda ve F ve Sc alt testleri düşük olduğunda, sevilme, kabul edilme ve kendisini yaşamı üzerinde kontrol sağlıyor gibi gösterme gereksinimi çok abartılıdır. Karakter olarak, bu bireyler çok katı bir optimizm gösterirler ve bazı şeyler görünür biçimde felâket ya da başarısızlıkla çevrelenmişken bile bu iyimserliği ısrarla sürdürürler. Bu insanların diğerleri ile iyi ilişkileri ve uyumları vardır ve kızgınlık, bozulma ya da zedeleyici duyguların olduğu ya da bağımsız karar vermeleri ya da güç kullanmaları gereken durumlardan kaçınırlar (ya da çok rahatsız olurlar).

31 Kodu (Bakınız 13/31 Kodu)

32 Kodu (Eğer 2 alt testi, 3 alt testinin 5 T puanı sınırları içinde ise 23 koduna da bakınız.)

23 kod tiplerinin aksine, bu bireyler sağlıkları ve bir ölçüde de belirgin olmayan depresyonları ile fazlaca ilgilenirler. Yorgunluk, gastrik yakınmalar, baş ağrıları ve baş dönmesi geneldir, ancak çeşitli fiziksel yakınmalar da olabilir. Genellikle bu semptomlar hafiftir ve anksiyete ve depresyon duyguları aşırı biçimde kontrol etme çabaları ile açık olarak ilişkilidir.

Bu profil örüntüsündeki erkekler, anksiyeteye ilgili olarak genellikle gergin ve meraklıdır, iş sorunları ile kendilerini üzerler, gerginliğin sonucu semptomlar ortaya çıkar. Bedensel sorunlarının psikolojik yorumlarını reddederler ve içgörülerі yoktur. Fiziksel durumları konusunda güven verilmesi yararlı olur, sürekli psikolojik yardım alma olasılıkları düşüktür. Erkekler için test 1,8 ve 9 sıklıkla üçüncü en yüksek testtir.

32 kodlu kadınların sıklıkla sorunlu evlilik öyküsü (boşanmalar nadiren olsa da) vardır, kocaları ile cinsel ilişkiyi istemezler ve cinsellikten hoşlanmadıklarını belirtirler. Tipik olarak, bunlar depresiftirler, kocalarının sadakatsizliğinden ve alkol almasından yakınırırlar. Eleştiriye ya da reddedilmeye karşı aşırı duyarlıdır ve bu kadınların çoğu kronik mutsuzluğu tolere edeceklerdir. Genelde, kendilerini yetersiz hissederler ve önemli ölçüde kendi kendilerine ilişkin kuşkuları vardır. Yorgunluk ve tükenmişlikten yakınabilirler, (özellikle eğer test 5 düşük ise) ancak işlerinde çalışkan olma eğilimi gösterirler. Çarpıntı, terleme, uykusuzluk

ve belirsiz korku gibi fiziksel semptomlar sıklıkla bildirilir. Bazen bu profil menapoz güçlükleri ile bağlantılıdır.

Kadınlar için çoğunlukla 1, 4 ve 8, üçüncü en yüksek testtir. Bu kod tipindeki kadınlar, daha çok evliliklerinde güçlükler yaşarlar. Boşanma azdır ve çoğunluğunda frijidite vardır.

321 Kodu

32 kodlu bireylerin özelliklerine ek olarak, bu bireyler kabızlık, ishal, anoreksiya, uykusuzluk, kas gerginliği, genital bölgede ağrı, çarpıntılar ve tükenmişlik gibi çok çeşitli hipokondriyak yakınmalar gösterirler. Bu profildeki kadınlar sıklıkla tekrarlayan jinekolojik yakınmalar getirir ve/ya da histerektomi olurlar. Erkekler sıklıkla gastrik rahatsızlık ya da ülser gösterirler. Her iki cinsten, evlilik sorunları ve cinsiyetle ilgili heyecansal çatışmalar olabilir. Bunlar depresyon ve endişeyle ilgilidir. Depresyon ve endişe, aşağılık hatta umutsuzluk duyguları ile bağlantılıdır.

Bu insanların kendileri ya da başkaları hakkında fikirleri yoktur ve bunun bir sonucu olarak sıklıkla kendilerini rahatsız edici kişilerarası durumlarda bulurlar. Engelleyici durumlar karşısında kendini cezalandırıcı biçimde depresif olma ya da kendi kendilerine zarar verecek biçimlerde tepki göstermek eğilimindedirler. Örneğin, sıklıkla başkalarının eleştirisi ya da reddetmesini teşvik edecek biçimde aşırı reaksiyon gösterirler. Karışık nevrotik bir semptomatoloji ile eşleşen kronik nevrotik bir durumu ortaya koyan bu hastaların depresif, çökkünlük, gerilim, kaygı ile birlikte özellikle baş ağrısı ve uykusuzluğun eşlik ettiği çoklu somatik yakınmaları vardır. Özellikle histerik davranışları ile ikincil kazançları gözlenebilir. Tedavi motivasyonları düşüktür. Yetersizlik duyguları, genellikle kronik nevrotik bir durum sergiler.

34/43 Kodu

34 kodu olan bireyler sıklıkla 43 kodu alanlardan açık farklılıklar gösterebilirler de, benzerlikler açıktır. Her iki kod tipi kızgın, immatür ve bencildir. Evlilik uyumsuzluğu, rastgele cinsel ve yüzeysel ilişkiler, boşanma, alkolizm temel özelliklerdir. En belirgin özellikleri kronik ve şiddetli öfkedir. Düşmanca, saldırgan dürtüleri vardır. Kızgınlıklarını yumuşatamazlar ve bu duygularını uygun zamanda ifade edebilecek uygun yolları geliştirememişlerdir. Çoğunlukla aşırı kontrollü olmalarına karşın kısa saldırganlık dönemleri vardır. Başkalarını cezalandırma ve sorunları için başkalarını suçlama eğilimi içindedirler. Sıklıkla kişilik

bozukluğu tanısı konulmaktadır. Ancak 3 ve 4'ün göreceli yükseklikleri bu tür bireylerin kızgınlıklarını ve diğer impulslarını ne ölçüde ketlediğinin (eğer 3 yüksekse), ya da öfkelerinin daha fazla ifade edildiğinin (eğer 4 yüksekse) bir göstergesidir.

Erkekler için test 2, 5 ve 6 sıklıkla üçüncü en yüksek testtir.

Bu koddaki kadınlar sıklıkla yaşamlarının yüzeysel yönleri üzerinde çok fazla dururlar, sabırsızdırlar ve sürekli isterler. Ayrıca, hafif düzeyde psikosomatik yakınmaları vardır, bunlar bireyleri güçsüz kılmaz, yakınma odağıdırlar. Kadınlar için, üçüncü en yüksek testler sıklıkla 2,6 ve 8'dir.

34/43 kodu, ebeveynler ve okul otoriteleriyle olan çatışmalarından dolayı ergenlerde çok sık görülür. Hırsızlık, ilaç kullanımı, okuldan kaçma ve evden kaçma sıklıkla vardır, ayrıca intihar düşünceleri ve uyku güçlükleri gözlenir.

Olası tanı: Pasif agresif kişilik bozukluğu, agresif tip

Yüksek 3/ Düşük 4 Kodu

Alt test 3'ün önemli ölçüde yüksek olduğu durumda, birey kızgınlık duygularını dolaylı olarak gösterir ya da dışavuran davranışları olan bireylerle birlikte kızgınlık ve isyan duygularını ifade eder.

Sıklıkla bu bireyler, bağımlılık bağımsızlık çatışması yaşarlar. Kızgın bir biçimde çok fazla istenmek ve yeterli derecede istenmemek arasında gider gelirler. Bağımlı olmak istemelerine karşın, bunda kendi rollerinin ne olduğu konusunda içgörülerini yoktur. Bastırma, inkâr ve kızgınlığın aşırı kontrol edilmesinden dolayı, öfke patlamaları olduğunda tipik olarak aşırı öfkeli olurlar, ancak hemen bunu iyi bir biçimde rasyonalize ederler.

34 kodlarında, 4'ün 3'ten önemli ölçüde yüksek olduğu durumlarda, kızgınlık baskındır, ancak uzun süre baskı altında tutulmuştur ve sonra öfke patlamaları ile ifade edilir, hatta bazen ciddi saldırı ya da cinayetlerle sonuçlanır. Bu bireylerin çoğu, uzun zaman sessiz olur, çünkü öfkeyi başlatan sıklıkla çok küçük bir olaydır. Bazen bu bireylerde şiddet patlamaları döngüsel bir örüntüde olur.

Kadınlarla yapılan bir araştırmada arkadaşları bu kadınların sabırsız olduklarını belirtirken kadınlar kendilerini konuşkan, enerji dolu, tam anlaşılmayan kişiler olarak tanımlamaktadır. 3'te bastırma, 4'te saldırganlık fazladır, 3 yüksek, 4 oldukça yüksek ise pasif-agresif kişiliktir. Sinsi tipler ufak bir hadise çıkarıp önemli bir şeyi engellerler. Bağırıp çağırmadan saldırganlığı pasif bir şekilde gösterirler.

345/435/534 Kodları

Bu profildeki erkekler, diğerleri ile olan ilişkilerinde belirgin bir biçimde immatür ve genellikle cinsel yönden yetersizdirler. Sıklıkla sıradan cinsel ilişkiden farklı bir ilişki ararlar, teşhircilik görülebilir, homoseksüel olma korkuları vardır. Alt test 3, 4'ten yüksekse ve K alt testi 50 T puanının üstündeyse, duyguların ve isteklerin eyleme dökülme olasılığı düşüktür.

346/436 Kodları (Eğer 6 alt testi, 3 alt testinin 5 T puanı sınırları içinde ise, 36/63 kodlarına da bakınız.)

Sıklıkla bu bireyler uyumlu gibi görünseler de, dönemsel aşırı eylemevuruk davranış öyküleri olabilir ve bunu uzun süre devam eden sıradan davranışlar izler. Sıklıkla bu bireyler eleştiriye aşırı duyarlıdır ve kızgınlık duygularının bir sonucu olarak gergin ve kaygılıdır. Genellikle bunların kızgınlığı aile üyelerine yöneliktir, ancak zihinlerinde bu durumu iyi bir biçimde rasyonalize eder ve kendilerini haklı çıkarırlar. Çoğu, eylemevuruk davranışları olan bireylerle uzun-sürekli (ancak sıklıkla çalkantılı) ilişkiler kurarlar, böylece kendi kızgınlık ve isyankâr impulslarına başkaları aracılığıyla doyum sağlarlar. Suçlama, onların düşünce tarzında kilit parçadır ve bu bireyler nadiren değişme ya da kendine bakma gereksinimi duyarlar ve psikolojik tedaviyi reddederler.

35/53 Kodu

Bu koddaki erkekler pasif ve hatta geri çekilme eğilimindedirler. Davranımda bulunmaktan çok beklerler, inhibe ve güvensiz görünürler, ancak çok güçlü ilgi gereksinimleri vardır. Genellikle, utangaç, kaygılı ve sosyal olarak rahatsızdırlar (özellikle eğer Si alt testi yükselmişse). Çoğunun ahlak anlayışları farklıdır. 4 ya da 6 genellikle üçüncü yüksek testtir.

Kadınlarda, bu ikili yükselme nadirdir. En sıklıkla gözlenen 4 ya da 1 alt testlerinin birlikte yükselmesidir. Yorumlama 5'teki yükselmeyi dikkate almamak ve böylece üçlü yükselmeyi (örn. 354 kodu) ikili

yükselme (örn. 34 kodu) gibi almakla daha iyi yapılabilir. Sonra, 5 alt testi yükselmesinin yorumu buna eklenebilir.



36/63 Kodu

Yüzeyde, bu bireyler eleştiriye aşırı duyarlı, kuşkulu, gergin ve hatta şüphelidirler. Sıklıkla baş ağrıları ya da gastrointestinal yakınmaları da vardır. Sorunlar ortaya çıktığında başkalarını ya da durumları suçlarlar. Yüzeydeki bu durumun altında, aile üyelerine yaygın ve uzun süredir devam eden kızgınlık duyguları vardır. Kızgınlık fark edildiğinde rasyonalize edilir. Bu hastalar eleştiriye aşırı duyarlıdır, belirgin anksiyete ve gerginlikleri vardır. Sıklıkla somatik yakınmalar getirirler. Gerçekte bu bireylerin çoğu ile birlikte olmak zordur, çünkü bunlar kendileri üzerinde odaklaşır ve vücut pozisyonları tetikte gibidir. Bu ikili kod kadınlar arasında erkeklere oranla daha fazladır ve sıklıkla üçüncü yükselen test Si ya da Sc'dir.

Alt test 6, 3'ten 5 ya da daha fazla T puanı yüksek olduğunda, bu birey güç ve prestij kazanmak için kızgın bir biçimde bencildir, hatta bu acımasız manipülasyonlar noktasına gidebilir. Tipik olarak bu bireyler davranışlarında çok katı ve savunucudurlar. Bazıları belirgin paranoid özellikler gösterebilir.

Alt test 3, 6'dan yüksekse, bu tür bireyler kızgınlıklarının farkında değildirler, ancak bu başkaları için çok açık olabilir (Başkaları bunu açık bir biçimde fark edebilir). Kendi üzerinde odaklanma ve ben-merkezcilik açıkça vardır ve genellikle incitme duyguları ile birliktedir. Bu kod tipi 34 kod tipine de benzemektedir. Kızgın, hostile kişilerdir. Bu özelliklerini ve şüphe duygularını inkâr ederler. İlişkilerini genellikle olumlu algırlar. Gerçek durumun böyle olmadığını da anlamakta güçlük çekmektedirler.



37/73 Kodu

Çok sık rastlanmayan bir koddur; gerginlik, anksiyete, uykusuzluk, kronik rahatsızlık, diğer bedensel yakınmalar ve düşük akademik başarı ile bağlantılıdır. Bu semptomların altında çözümlenmemiş bağımlılık istekleri, yetersizlik duyguları yatmaktadır. Ancak, bu bireyler bastırmayı kullanırlar ve bu içgörüye önemli ölçüde engel olur. Her iki cinsiyette de 1, 2 ve 4 alt testleri sıklıkla üçüncü en yüksek testtir. Bu bireyler hem düşünce, hem de davranışlarında tuhaf ve gariptirler ve belirli bir şeye odaklaşmada, düşünmede ve net bir biçimde hatırlamada ve hatta karar vermede güçlükleri vardır. Kendilerini yabancılaşmış hissetseler de, bu bireyler abartılmış bir sevilme

gereksinimi duyarlar, ancak bağlanmaktan korkarlar. Başkalarından sevgi almaya çalıştıklarında tipik olarak bunu çocuksu bir biçimde yaparlar ve başkaları bunu tuhaf bulur.

Bunların psikolojik karmaşaları oldukça büyüktür, öyle ki bunlar otistik aşırı düşünme ya da delüzyonlar gibi major bir düşünce bozukluğunu temsil ediyor olabilir, buna belki de davranışsal regresyon eşlik eder. Gerçek olmama duyguları ve duygusal uygunsuzluğa, bulanık görme, baş dönmesi, ateş basması ve baş ağrıları eşlik eder. Bazıları kısa, cinsellikle dolu psikotik epizodlar gösterirler ve bunu daha sonra hatırlamazlar. Gergin, kaygılı kişilerdir. Psikolojik stres ya da çatışmalar sonucunda kronik fiziksel yakınmalar geliştirirler. Dışarıdan görülen davranışsal gerginlik ve kaygıya rağmen psikolojik sorunlarının varlığını inkâr ederler. *Bu durum psikolojik nöbetlerdir.*

38/83 Kodu

Bu hastalar ruhsal karmaşa içindedirler. Düşünme ve konsantrasyon bozukluklarından yakınırılar. Psikolojik stres, fiziksel semptomlarla ifade edilir. Bunlar, baş ağrısı, uykusuzluk ya da yorgunluk ile bizar yakınmalar olabilir. İmmatür, egosantrik ve bağımlılık gibi histerik özelliklerin yanı sıra hostilite, gerginlik ve endişe sergilerler. Gerçek psikotik olabilirler. Bir düşünce bozukluğu ihtimali dikkatle değerlendirilmelidir. Psikotik reaksiyonlar görüldüğü zaman bunlar davranışsal regresyona eşlik eden infantil ve narsisistik niteliklerdir. Çağrışımlarda bozukluk görülebilir. Obsesif düşüncelere, açık delüzyon, hallüsinasyonlara, anlamsız ve enkoheran konuşmaya rastlanabilir. Destekleyici yöntemler telkin edilmelidir.

Olası Tanı: Şizofreni
Bazı durumlarda histerik nevroz

39/93 Kodu

Bu bireyler genellikle girişken, dışadönük ve açık olarak kendine güvenen kişilerdir, ancak çok yüzeysel olabilirler (özellikle eğer alt test Si 40 T puanının altında ise). Genellikle sözel olarak saldırgandırlar, (öfkeli, agresif) bağımlılık-bağımsızlık çatışmaları vardır ve özellikle baskıcı anneye karşı kızgın olarak tanımlanırlar. Klinik ortamlarda dönemsel anksiyete ve akut rahatsızlık öyküleri vardır ve sıklıkla bunlara çarpıntı, taşikardi ve gastrointestinal alanla ilgili semptomlar eşlik eder. Genelde bu semptomlar medikal yönden doğal ve olası değildir. Tipik olarak bireylerdeki bu somatik yakınmalar, güvenceyle birlikte verilen

semptomatik tedaviye iyi yanıt verirler. En sık görülen üçlü kod tipi 394/934'tür.

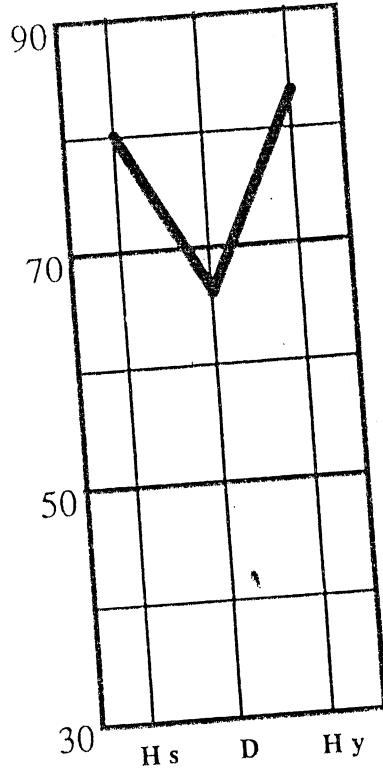
30/03 Kodu

Nadir görülen bu kod pasif, bağımlı ve geri çekilme boyutunda sosyal yönden pasif olan bireylerle bağlantılıdır. Ancak, onlar bu tür bir uyumda göreceli olarak rahat görünürler ve sosyal durumlardan kaçmayı ve rahatsız edici duygularını bastırmayı yeğlerler. Stres durumlarında dönemsel psikosomatik yakınmalar görülebilir. Üçüncü en yüksek test 1 ve 2'dir.

Nevrotik Üçlü Profilleri

Nevrotik üçlü içindeki üç alt testin ilişkileri çerçevesinde en sık karşılaşılan dört konfigürasyon vardır.

Birinci konfigürasyon konversiyon vadisi: Hs ve Hy alt testleri yükselmiş D alt testi düşmüştür.

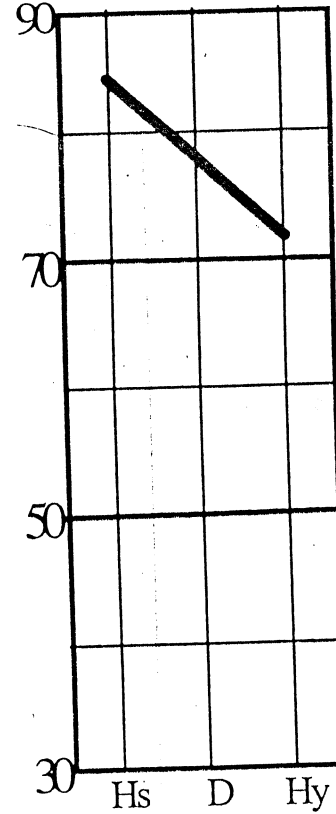


Bu konfigürasyona sahip bir hasta gerginlik yaratan sıkıntılarını rasyonel ya da sosyal olarak daha kabul edilebilir durumların altında gizlemektedir.

Konfigürasyonun yüksekliği hastanın yaşadığı gerginliğin düzeyini yansıtır.

Şekil 17: Konversiyon vadisi

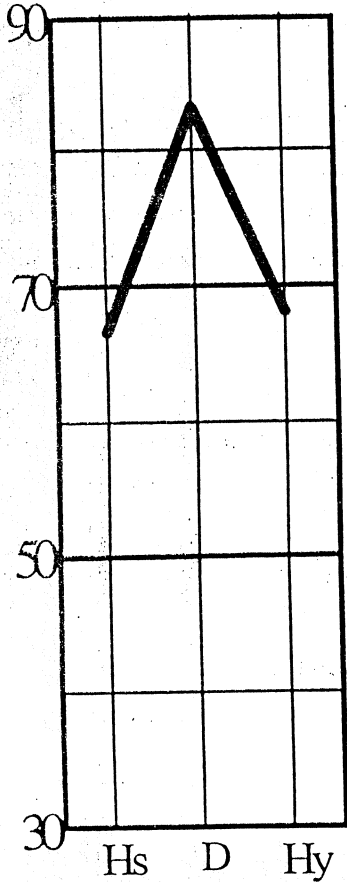
Diğer sık rastlanan bir nevrotik üçlü konfigürasyonu basamak orantısıdır. Bu konfigürasyonda temel örüntü 1 alt testi en yukarıda olmak üzere 2 ve 3 sırasıyla daha alta yer alacak şekilde üç alt test de 70 T puanının üzerindedir.



Bu bireyler en küçük işlev bozukluklarına bile aşırı duyarlık gösteren, somatik ilgileri olan kişilerdir. Fiziksel yakınmaları belirgin bir organik temele dayanmaz. Somatik belirtiler genellikle baş dönmesi, bulantı, uykusuzluk ve baş ağrısıdır. Bu tür hastaların iş yaşamlarında ve evlilik ilişkilerinde ne yaşadıklarını anlamak çok zordur. Beklenildiği gibi eğer fiziksel belirtiler ile psikolojik nedenler arasında bir bağlantı varsa bunun pek azını görürler. Kısa süreli psikolojik tedavilerde prognoz iyi değildir. Bu konfigürasyona 35 yaşın üzerinde ve kendilerini "tepeyi aşmış" olarak gören erkek hastalarda sıklıkla rastlanır.

Şekil 18: Basamak Orantısı

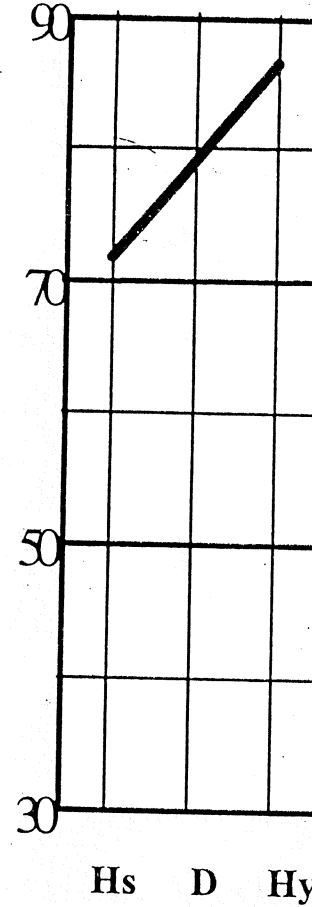
Üçüncü konfigürasyonun özelliği alt test 2'nin 1 ve 3'ten daha fazla yükselmiş olmasıdır.



Bu hastalar karışık semptomatoloji ile kronik nevrotik durum gösterirler. Pek çok somatik yakınma, depresyon, histerik özellikler tipiktir. Alt test Hs 70 T puanının altındayken alt test 2 ve 3, 70 T puanının üzerindeyse bu hastalar emosyonel olarak aşırı kontrol gösterirler ve kendilerini sıkıştırılmış gibi hissettiklerini söylerler. Genellikle yorgun, gergin, kendilerine ilişkin şüphelerle doludurlar ve bu nedenle iş yapmazlar. Bağımlı ve immatür olarak tanımlanırlar. Tedavi motivasyonları düşüktür.

Şekil 19: Şapka

Diğer sık rastlanan bir konfigürasyon, yükselen basamak örüntüsüdür. Bu konfigürasyonda her üç alt test de 70 T puanının üzerindedir ve her bir alt test bir öncekinden daha yüksektir.



Yaşam boyunca süregelen hastalık, geçmişi ile frijidite gibi cinsel problemleri de içeren evlilik sorunları olan kadınlarda görülür.

Bu konfigürasyonu gösteren erkeklerde kronik anksiyete ile uzun süren üzüntü ve gerilimin sonucunda gastrit, ülser gibi fiziksel yakınmalar vardır.

Konfigürasyon hem kadın, hem de erkeklerde depresyon ve somatizasyonun bulunduğu karışık bir nevrotik örüntüdür. Klinik tabloya, uykusuzluk ve anoreksiya ile birlikte yüksek düzeyde anksiyete durumları eşlik eder. Psikolojik yorumlara direnç ve psikolojik içgöründen yoksunluk tipik özelliklerdir.

Şekil 20: Yükselen eğilim

4. Psikopatik Sapma (Pd) Alt Testi

Psikopatik bir birey toplum kurallarını hiçe sayar, saldırgandır, engellenme eşiği düşüktür, iç çatışmaları, suçluluk duygusu azdır, deneyimden pek fazla ders almaz. Bu gibi özellikleri tanımlamak için bu alt test geliştirilmiştir. Alt test 4, psikopatik eğilimleri de yansıttığı ve psikopatik kişiliği kesin olarak teşhis etmediği için McKinley ve Hathaway (1956) alt ölçeğe "psikopatik sapma" adını vermişlerdir. Pd alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 11'de gösterilmiştir.

Tablo 11: Psikopatik sapma alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 50)

[illegible]

Erkeklerde ortalama 16.62, kadınlarda ortalama: 18.12
(Savaşır, 1981)

Pd alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)

1. Toplumun kurallarına ve değerlerine uymada güçlük çeker.
2. Asosyal ya da antisosyal davranış içine girer:
 - a. Yalan söyleme, çalma, dolandırıcılık
 - b. Cinsel eyleme vuruk davranış
 - c. Alkol ve/ya da madde kullanım öyküsü
3. Otorite figürlerine karşı isyankardır.
4. Aile ilişkileri fırtınalıdır.
5. Sorunları için ebeveynlerini suçlar.
6. Yaşam öyküsünde kötü bir iş yaşamı vardır.
7. Evlilik sorunları vardır.
8. Impulsiftir, impulsları için hemen doyum ister.
9. İyi planlama yapamaz.
10. Davranışının sonuçlarını düşünmeden hareket eder.
11. Sabırsızdır, engellenme eşiği düşüktür.
12. Yargılaması yetersizdir, düşünmeden tehlikeye atılır.
13. Deneyimlerinden yararlanamaz.
14. İmmatür ve çocuksudur.

15. Narsisistik, benmerkezcil ve bencildir.
16. Dikkati çekmek ister, gösteriştir.
17. Diğer kişilere karşı duyarsızdır.
18. Diğerlerini nasıl kullanabileceğiyle ilgilidir.
19. Beğenilir, ilk imajı iyidir.
20. Kişilerarası ilişkileri yüzeyeldir.
21. Sıcak ve yakın ilişkiler kuramaz.
22. Dışadönük ve sempattır.
23. Konuşkan, aktif, enerjik, maceracı, spontandır.
24. Zeki ve kendine güvenlidir.
25. Geniş ilgi alanları vardır.
26. Belirli amaçları yoktur.
27. Hostil ve saldırgandır.
28. Küçümseyici ve alaycıdır.
29. Gücenik ve asidir.
30. Eylemevuruk davranışları vardır.
31. Saldırgan patlamaları ve davranışları vardır.
32. Muhafız ve inatçıdır.
33. Davranışlarından dolayı çok az suçluluk yaşar.
34. Başlı belada olduğu zaman suçluluk ve vicdan azabı hisseder.
35. Anksiyete, depresyon ve psikotik semptomlar göstermez.
36. Genellikle kişilik bozukluğu tanısı konulur (antisosyal kişilik ya da pasif agresif kişilik)
37. Endişeye eğilimli ve tatminsizdir.
38. İçten duygusal tepkileri yoktur.
39. Can sıkıntısı ve boşluk duyguları vardır.
40. Psikoterapi ya da danışmanlıkla değişme prognozu kötüdür.
41. Sorunları için diğerlerini suçlama eğilimindedir.
42. Entellektüalizasyonu kullanır.
43. Hapsedilmekten ya da diğer hoş olmayan yaşantılardan kurtulmak için tedaviyi kabul eder, ancak kısa sürede sonlandırır.

Pd alt testinde düşük puan alan bir birey:

1. Geleneksel ve itaatkardır.
2. Otoriteye boyun eğer.
3. Pasif, itaatkar ve çekingendir.
4. Diğerlerinin nasıl tepki vereceğini düşünür.
5. Samimi ve güvenilirdir.
6. Enerji düzeyi düşüktür, yarışmacı değildir.
7. Mevki ve güvencede olmaya dikkat eder.
8. İlgili alanları daralmıştır.
9. Yaratıcı ve spontan değildir.

10. İnatçıdır.
11. Kuralcı ve katıdır.
12. Erkekse cinsellikle çok ilgili değildir, kadınlardan korkar.
13. Kendini eleştirir, kendinden memnun değildir.
14. Önerileri ve fikirleri kabul eder.
15. Tedaviye çok bağımlı olmaya eğilimlidir.
16. Kendi davranışının sorumluluğunu kabul etmekten korkar.

80 T puanı ve üstü: 70-79 T puanında verilen özelliklere ek olarak bu yükselme klinik tanı olarak psikopatik bir bireyi göstermektedir. Antisosyal davranışlar, otorite figürleri ile çatışma vardır. Diğerleriyle kendi gereksinimlerini nasıl karşılayabileceklerine bakarak ilişki kurarlar.

70-79 T puanı: Bu alt testte yüksek puan alan bireyler, öfkeli, impulsif, emosyonel açıdan yüzeysel, yordanamaz davranışları olan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür kişiler, sosyal uyumsuzluk, otoriteye ve diğerlerine karşı olma davranışları gösterirler. Alt test 4'teki yükselme, antisosyal tutum ve davranış eğilimlerine işaret eder, ancak bu her zaman açık davranış biçiminde ifade edileceği anlamına gelmez. Antisosyal davranışlar, açıkça gösteriliyorsa özellikle alt test 9'la birlikte yükselme görülür. Yüksek puan verenlerin kendilerine ilişkin mükemmeliyetçi ve narsistik kavramları vardır ve bu kişisel standartları, sosyal kuralları reddetmeyi rasyonalizasyon olarak kullanmaktadırlar. Bunların kızgınlığı ailelerine ya da genelde otorite ve topluma karşı ya da her ikisine karşı olabilir. Bazen bunların kızgınlığı durumşal bir tepki (boşanma vb) ya da ergenlik isyanı olabilir ya da bir kültürel azınlık grubunda olmayla bağlantılı kızgınlığı yansıtabilir. Böyle olmadığında örüntü uzun süreli ve değişme olasılığı düşüktür. Ancak bireylerin küskünlük ve sosyal olmayan impulsları ele alma biçimleri büyük ölçüde farklılık gösterebilir ve bu, profilin diğer yönlerindeki yükselmelere bağlıdır. Genelde, kızgınlığın, davranışsal olarak dışa vurup vurmayacağı test 9 ve/ya da 0'ın yükselmesi ve K'nın düşük olup olmamasına dayanır. Impulsif olma, kötü kişilerarası yargılama, davranışların önceden kestirilememesi, sosyal yabancılaşma ve azalmış sorumluluk ve ahlâk duygusu ve buna eşlik eden kötü iş yaşamı ve evlilik uyumsuzluğu vardır. Uzun vadeli hedeflerini kısa süreli arzuları uğruna feda ederler ve sonuçları tahmin etme kapasiteleri sınırlıdır.

Patolojinin var olup olmadığının belirlenmesi için, bireyin hem yaşam durumu, hem de yaşı dikkate alınmalıdır. Yüksek 4 profilleri (yetişkin normları kullanılarak) ergenler için normaldir, bunlar karakteristik olarak evden uzaklaşmak ve kendi kimlik duygularını oluşturmak için isyan ederler. Ancak 25 yaşın üzerinde yüksek 4 profili doğal değildir. 40 yaşın üstünde yüksek 4 profili uzun süren kişilerarası ilişki kuramama ve

antisosyal davranışları yansıtırken, 60 yaşın üzerinde, bu tür puanlar apatik bir biçimde katılmama düzeyine varan bir yabancılaşmayı düşündürür. Bu tür bir kızgınlığı başlatan açık bir yaşam olayı olmadığında, test 4 özellikleri kalıcı ve değişime dirençlidir.

60-69 T puanı: Risk alabilen, enerjik, sosyal, maceraperest ve atılgan olan bir bireyle bağlantılıdır. Ancak, bu bireyler engellendiklerinde bu özellikler huzursuzluk, saldırganlık ve sosyal olarak uyumlu olmayan davranış biçimine dönüşebilir.

45-59 T puanı: Aşırı kontrol koyma ve kısıtlanma genellikle azdır. Sosyal kurallara kısmen uyum vardır.

20-44 T puanı: Duragan, pasif ve atılgan olmayan bireylerdir. Maceraperest değildirler ve sıklıkla sosyal geleneklere uyma konusunda bağımlı ve hatta katıdır. Danışma durumunda başkalarının onlara karşı olan düşünceleri konusunda güvence ararlar. Çok sevgi dolu olsalar da, sıklıkla cinsel ilişkiye girme konusunda girişken değildirler.

Sadece Pd alt testinin yükselmesi: Pd alt testinin diğer testlerden en az 10 ya da daha fazla T puanı yukarıda olmasıdır. Bunlar, impulsif, küskün, isyankâr ve genelde kurallar, düzenlemeler ve otoriteyi kabullenmekte güçlükleri olan bireylerdir. Sıklıkla yasal sorunları olabilir. Bunlar sokulgan (insan canlısı) olabilirler (eğer test 0 düşükse), ancak diğerleriyle ilişkileri, yüzeysel yapay ve kısıdır. Uzun süren, yakın ilişkiler kuramazlar, çünkü bunlar birliktelikle ilgili empati, sorumluluklar ve talepler konusunda güçlükleri olan bireylerdir. Uzun süreli hedeflere doğru organize davranışları sürdüremezler ve bunun yerine doyum veren kısa süreli istekler üzerinde odaklaşma eğiliminde olurlar. Alt test Si 30 T puanına yaklaşırsa, bu sorunlar daha kalıcı ve şiddetlidir, ancak birey hoş ve rahat görüntüsü verebilir.

Pd alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

- 41/14 Kodu (Bakınız 14/41 Kodu)
- 42/24 Kodu (Bakınız 24/42 Kodu)
- 43/34 Kodu (Bakınız 34/43 Kodu)

Yüksek 4/Düşük 5 Kodu (Ayrıca Mf alt testinin düşüklüğüne de bakınız)

Erkeklerde düşük 5, bireyin kendini erkeksi, hatta aşırı erkeksi gösterme çabasını yansıtır. Kaba ve geleneksel maskülen ilgileri olanlar da, bu grubun geleneksel değerlerini yansıtabilir. Orta ya da üst sınıftan

ve yükseköğül eğitimi olan erkeklerde bu örüntü, yetersizlik duygularını, özellikle kadınlara karşı, güçlü bir biçimde kapatma çabasını düşündürür. Sıklıkla kendi egolarını desteklemek ve kendi kendilerine güç ve kontrolü kanıtlamak için kadınları aşağılarlar.

Ergenlerde bu örüntü, açık suçluluk ile bağlantılıdır.

Bu örüntüdeki kadınlar kızgındırlar, ancak bu duygularını doğrudan ifade edemezler. Bunların kızgınlığı özel olarak erkeklerle yöneliktir ve heteroseksüel sorunlar beklenir. İlginç olarak, bu kadınlar ilişkilerinde yüzeyseldir ve sıklıkla çekingen, yumuşak başlı ve çekici biçimindeki kültürel kadın stereotipleri ile özdeşleşmişlerdir ve bu tür rolleri aşırı sevgi ve ilgi gereksinimlerine doyum sağlamak için oynamaya çalışırlar. Genellikle aşırı talepkar ve bağımlıdır. Erkeklerle karşı olan kızgınlıklarını pasif-agresif biçimde cinsel yolları kullanarak ifade ederler. Kadınlar sıklıkla bu tür davranışlarla (özellikle eğer test 6 da yüksekse) başkalarını da kızdırmak için kışkırtırlar, ancak sonra yanlış anlaşıldıkları için kendilerine acırlar. Hatta bir melodram krizi başlatmış oldukları için hoşlanmış görünürler. Alt test 3 de yükselmişse, bu kadınlar kendilerinin başkaları üzerindeki etkisinin farkında değildirler ve düşmanlık duygularını inkâr ederler. Evlilik ve aile sorunları ve cinsel fonksiyon bozuklukları ve cinsel hoşlanma eksikliğinin olması şaşırtıcı değildir. Baş ve sırt ağrıları da sık görülür.

45/54 Kodu

Bu kod tipi hastanın yaşı, eğitimi ve cinsiyeti dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ergenler için, bu kod öfke patlamalarının olduğunu gösterir. Kuralları ve otoriteyi sevmeyen ve sıklıkla okuldan kaçma, okula ara verme ve sınıfta kalma öyküleri vardır. Bu, özellikle 4 alt testi, 5 alt testinden yüksek olduğunda daha belirgindir. Bireyler öfkelerini kontrol etmede büyük zorluk çekerler. İlaç kullanımı, hırsızlık ya da anti-sosyal davranışlar da olabilir. Ancak bu ergenler girişken (insan canlısı), dışa dönük ve genellikle akranları tarafından sevilen kişilerdir. Sorunlarına karşın terapide iyi ilişki kurarlar, terapistleri tarafından sevilen kişilerdir ve prognoz iyidir.

Bu koddaki yetişkinler, liseden daha az eğitimi olan kişilerdir ve sıklıkla olgunlaşmamış ve narsisistiktirler. Görünüşleri ve davranışları ile sosyal kurallara meydan okumaktan zevk duyarlar. Meydan okumalarının

açıklığı ve hatta çirkin doğası 4 ve 9'un yüksek olma olasılığını arttıracaktır. Bu tür uyumsuzluklarından zevk alıyor gibidirler.

Lise ya da daha yüksek eğitimi olan yetişkin erkeklerin narsisistik biçimde uyumsuz olma olasılığı daha azdır, bunun yerine bu bireyler kurumlara karşı sosyal protestolar ya da hareketler içine girerler. Sıklıkla bu erkekler, çok idealist ve fikirlerini açık ve etkin bir biçimde iletebilecek yetenektedirler. Baskın olma ve bağımsızlık, bu bireyler için önemli konulardır. Uyumsuz davranışları, kendi kendilerine bağımsız ve yeterli olduklarını göstermek için yaparlarsa da bağımlı olmayı arzu ederler. Alt test 3'ün sonraki en yüksek test olduğu durumda, birey aşırı kontrollüdür ve bağımlılık ve hatta pasifliği daha fazla vurguluyordur.

45 ve 54 kodlu kadınlarda sıklıkla test 8 ve 9, üçüncü en yüksek testtir. Tipik olarak bu bireyler pasifliği, kadınsı rol ve kendilikle birleştirirler. Bu kadınların bazıları için, bu erkeksi bir protesto ve/ya da lezbiyen bir ilişkide erkek rolünün kabul edilmesidir. Diğer kadınlarda, özellikle kırsal alan kadınlarında bu profil sadece geleneksel olarak kadınsı olmayan bir yaşam biçimini gösterir ve atılganlığı gerektiren kendi alt kültürlerinin pratik, mekanik işleriyle uğraşırlar.

Olası tanı: Pasif-agresif kişilik bozukluğu, pasif tip
Erkeklerde 5 yüksektir.
Kadınlarda 5 düşüktür.

456 Kodu

Talep edici, bağımlı ve duygusal kişilerdir, ancak diğer kişileri tedirgin ederek ve onlara karşı çıkarak ilişki kurarlar. Davranış örüntüleri yakın aile çevrelerine yabancılaşmalarına yol açar. Bu durum talep edici, bağımlı ve duygusal ilişki gereksinimlerini karşılamalarını zorlaştırır (Bakınız Scarlett O'Hara Vadisi).

46/64 Kodu

Temel özellikler kızgınlık, küskünlük, güvensizlik, somurtkanlık, sinirlilik, eleştiriye ve başkalarının isteklerine karşı aşırı duyarlılık ve suçun başkaları üzerine yansıtılmasıdır. Bu bireyler kendilerini çok çabuk reddedilmiş ya da eleştirilmiş hissederler, yetersiz veri ve çok az öngörü ile (ön düşünme ile) sonuçlara varırlar. Bunların düşünceleri, tipik olarak nasıl ihmal edildikleri, başkalarının nasıl hatalı olduğu ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri üzerinde odaklanır. Bunların düşünceleri nadiren zor durumlar ya da sorunları yaratmada kendi rollerinin ne olduğu üzerinedir.

Bu bireylerin öyküleri, ciddi sosyal ilişki sorunları, çok az yakın ilişkiler ve sıklıkla ilaç kullanımı ya da alkolizm gösterir.

Başkalarının kendileriyle çok fazla ilgilenmesini isterler, ancak aynı davranış kendilerinden beklenildiğinde gücenip kızarlar.

Bu kod, yetişkin normaller arasında nadirdir, ancak ergenlik dönemine özgüdür. Bu koddaki ergenlerin aileleriyle ve otorite figürleriyle sürekli çatışmaları vardır; onları kinci, düşman ve yalancı olarak görürler. İmpulsların kendine zarar verici biçimde kontrol edilmemesi karakteristiktir ve buna yeterli öngörü ya da düşünme olmaksızın davranışa dökme eşlik eder. İsyankârlık, itaatsizlik, negativizm ve tartışma geneldir. Sıklıkla bunlar diğerlerini açık bir biçimde kışkırtırlar, ancak davranışlarının sorumluluğunu taşımazlar.

Genellikle psikiyatri polikliniklerine başvuran kadın hastalar, erkek hastalara oranla üç kat daha fazladır ve kadınlarda bu profil olduğunda patolojik durumu daha azdır. Sıklıkla test 2, 3 ve 8, bu tür profillerdeki üçüncü en yüksek testtir.

Yetişkin erkeklerde, 46/64 kodu sıklıkla psikotik ya da pre-psikotik durumlar ile (bakınız 468/648 kodları) ya da borderline kişiliklerle (bakınız 462/642 ve 463/643 kodları) bağlantılıdır. Bireylerin hepsinde kuşkuculuk, güvensizlik ve aşırı genelleme gibi paronoid özellikler vardır. Alt test 4, test 6'dan yüksek olduğunda, aile ve iş güçlükleri tipiktir, bunlarla birlikte kızgınlık hakim özelliktir. Alt test 6, 4'ten yüksek olduğunda daha çarpıcı paronoid özellikler ön plandadır. Bu erkekler, kızgınlıklarını genellikle kontrol ederler, ancak etraflarındakileri şaşırtacak şekilde dönemsel patlamalar gösterebilirler.

Kadınlarda 46/64 kodu psikoz ya da prepsikozla (özellikle eğer test 8 yüksek ve K düşük ise) ilişkili olabilir, ancak sıklıkla pasif-agresif kişilik biçimleri ile, özellikle erkeklerle kızgınlıkla bağlantılıdır (Bakınız yüksek 4, düşük 5). Bu özellikle 463/643 olduğunda böyledir, içgörü yoktur, problemleri dolaylı olarak diğerlerini kışkırtma ve başkalarını suçlama şeklindedir (bakınız 463/643 kodları).

Olaşı tanı: Pasif-agresif kişilik bozukluğu
Eğer 8 alt testi yükselmişse, borderline ya da psikotik bozukluk tanısı konulabilir. Hasta çok savunucu ise projektif testler verilebilir.

462/642 Kodları

46/64 koduyla bağlantılı kızgınlık ve duyarlılığa ek olarak, bu bireyler ajitedir. Sinirlilik, kaygı ve depresyon yakınmaları vardır. Sıklıkla bu manipulatif bir ilgi, sempati ve kontrol isteğidir. İntihar tehditleri görülür.

Bu bireyler başkalarına karşı güvensiz ve kuşkucudurlar ve onlardan şüphelenirler. Özellikle küskündürler ve otorite durumundaki bireylerle sorunları vardır, sıklıkla sorunlarının suçunu bu otorite figürlerine yansıtırlar. Yaşadıkları sorunları, kendi kontrollerinin dışındaki konulara bağlayarak ya da başkalarını suçlayarak rasyonalize ederler. Cinsellikte ve evlilikte uyumsuzluk olabilir.

Genelde insanlarla olan rahatsızlıklarına ve otoriteye olan kızgınlıklarına karşın, bu bireylerin tipik olarak abartılmış bir sevgi ve bağımlılık gereksinimleri vardır (hatta test 3 de yükselmiş ise daha fazla olasıdır). Bunların rahatsızlık ve eleştirilerinin çoğu aşırı biçimde diğerlerine bağımlı olma korkularından (ve böylece başkaları tarafından kontrol edilme) kaynaklanıyor görünmektedir. Sonuç olarak, aileleri ya da çalışma arkadaşları ile azalmış bir birliktelik duygusu gösterebilirler.

463/643 Kodları

Bu bireylerin aşırı sevgi isteklerinin doyurulması, özellikle bu bireylerin gereksinimleri karşılanmadığında gösterdikleri olumsuz duygulardan dolayı zordur. Genellikle bunların bağımlılık gereksinimleri heteroseksüeldir ve benmerkezcil biçimlerde isteme (hatta düşmancıl) şeklinde ifade edilir, bazen açık manipulasyon ya da kışkırtma içerir. Bu örüntü, sıklıkla kendi-kendini bozguna uğraticıdır, ancak bunların eşleri bireyin aşırı ister durumundan bıktıklarında onlara gereken ilgiyi göstermezler. Sıklıkla bu bireyler benzer olarak terapist ya da tedaviyi veren diğer bireylerden de aşırı isteklerde bulunurlar, ancak aynı zamanda da aldıkları tedaviyi eleştirir ve karşı çıkarlar. Reddedilmeye olan duyarlılıkları ile, bu kod tipindeki bireyler sıklıkla kronik olarak acı çeken, küskün ve güvensiz kişilerdir. İçgörüsü yoktur. 5 alt testinin 40 T puanının altında olduğu kadınlarda pasiflik, bağımlılığa ve kendi kendine acımaya sarılmak, özellikle görülür (bakınız yüksek 4 ve düşük 5). Menstrasyonda düzensizlikler, cinsel fonksiyon bozukluğu (disfonksiyon), baş ağrıları ve sırt ağrıları gibi fiziksel yakınmalar da olur.

468/648 Kodları

Eğer birey psikiyatride yatan bir hasta ise şiddetli ve olasılıkla kronik, duygusal bir rahatsızlığı, büyük olasılıkla paranoid şizofreniyi düşündürür. Bu bireyler kuşkucu, kızgın, aşırı duyarlı, suçlayıcıdır. Eleştiriden kolayca yaralanırlar ve durumlara kötü niyetli anlamlar yükleme ve düşüncelerinde aşırı genelleme eğilimindedirler. Kendilerine yapılan gerçek ya da hayali haksızlıklar üzerinde kızgın bir biçimde sürekli düşünme eğilimindedirler, delüzyonlar ya da referans fikirleri olabilir, büyüklük (grandiozite) elemanları, en azından ben-merkezci formda olabilir. Bu bireyler gerçekte daima kızgınlıklarını (ve diğer psikolojik problemleri) inkâr ederler ve kızgınlığı başkalarına yüklerler, bunu sıklıkla, yansıtmayı şeffaf bir biçimde kullanarak yaparlar. Kızgınlıklarını fark ettiklerinde, bunu kafalarında iyi bir şekilde rasyonalize eder ve kendilerini haklı çıkarırlar.

Kızgınlığa sıklıkla yargılamanın kötü olması, içgörü eksikliği ve impulsivite eşlik eder. Saldırı, ilaç kötü kullanımı ya da bağımlılığı ve intihar girişimlerinin hepsi olabilir. Kişiler arası evlilik ve cinsel uyum sorunları tipiktir. K testi 50 T puanının altında, test 5,4 ve 6'nın 5 T puanı alanı içinde ve/ya da alt test 9 ve 2 de 70 T puanının üzerinde olduğu durumlarda impuls kontrolünde azalma vardır.

469 Kodu

46 koduna ek olarak test 9 da 70 T puanının üzerinde ise bu ani öfke patlamaları olan bireyleri göstermektedir.

47/74 Kodu (Ayrıca 247/427/274 kodlarına bakınız.)

Bu bireylerde (hem ergenler, hem de yetişkinler) kızgınlık açıkça göze çarpan bir özellik ise de, kendi kendini eleştirme ve suçluluk da sık görülür. Bu bireylerin davranışı tipik olarak döngüsel bir örüntü gösterir. Bir dönem için düşünmeden ya da çok az impuls kontrolü ile narsistik ve kendi isteklerini ön plana çıkartıcı biçimde eyleme vuruk davranış gösterirler. Bu sırada, sıklıkla başkalarının isteklerini, duygularını düşüncesizce ayaklar altına alır, sosyal ve yasal sınırlamaları çiğnerler. Bu eyleme vuruk dönemden sonra (Bu sıklıkla rastgele cinsel ilişkiler, fahişelik ya da aşırı alkol kullanımı içerir.), davranışlarının sonucundan dolayı çok fazla pişmanlık, utanma ve suçluluk yaşarlar. Bunların vicdan azapları çok şiddetli olursa da, davranışlarını kontrol etme (genellikle aşırı kontrol etme girişi) geçicidir ve daha sonra da eyleme vuruk davranış dönemleri beklenir.

Davranışlarının altında, bağımlılık ve bağımsızlık arasında büyük çatışma vardır. Bireylerde görülen davranışsal sosyal aldırmazlıklara karşın, güvensizdirler, güçlü ilgi ve güven gereksinimleri duyarlar. Özellikle kendilerinin aşırı düzeyde kısıtlandığını ya da değerlerinin bilinmediğini hissederler, ev çatışmalarıyla ilgili olarak sürekli bir küskünlük gösterirler. Bunların dışı vurumu, bağımsızlığın immatür bir ifadesi olabilir. Özellikle bu bireyler, başkaları tarafından konulan kurallar ve düzenlemeleri çok fazla sinir bozucu bulurlar, tipik olarak kendi duyguları ile çok fazla ilgilenirler, başkalarının duyguları ve durumlarına karşı çok duyarsızdırlar. En sık görülen 3'lü kodlar 478/748 ve 472/742'dir. Psikoterapi suçluluk yaşadıkları dönemde yapılırsa etkili olabilir. Ancak uzun süreli prognoz iyi değildir.

48/84 Kodu (Ayrıca 48/84 kodu, Yüksek F ve Düşük 2 kodları, 482/842 kodları, 486/846 kodları ve 489/849 kodlarına da bakınız.)

Bu kod tipindeki bireyler sinirlilik, hostilite, şüphelenme ve olasılıkla referans fikirlerinin yanı sıra yoğun sıkıntı yaşamaktadırlar. Yansıma ve eyleme vuruk davranışlar, asosyal yollarla ifade edilir. Sosyal açıdan izoledirler ve duygusal bağlanmadan korktukları için yakın kişiler arası ilişkiye giremezler. Bu bireylerin davranışları yordanamaz, değişkendir ve duruma uygun değildir. Cinsel kimlik sorunları vardır. Ciddi alkol kullanım öyküsü ve madde bağımlılığı olabilir. Yargılama bozuk, içgörü sınırlıdır. İntihar girişimleri sıklıkla görülebilir.

Alt testlerden 7, 6, 2 ve 9, bu kod tipinde sıklıkla üçüncü en yüksek testtir. Hem yetişkinler, hem de ergenler için bu kod tipi, marjinal sosyal uyumu olan ve kendini diğer insanlardan farklı hisseden bireylerde görülür. Ergenlerde bu kod çok geneldir ve en azından orta düzeyde ve belki de çok ciddi geçici uyum sorunlarını yansıtır. Diğerlerinde bu, prepsikotik bir süreci göstermektedir. Bu ergenler kızgın ve mutsuzdurlar, garip düşünce örüntüleri gösterirler, devam eden kişiler arası ilişki güçlükleri vardır ve uyumsuz biçimlerde impulsiftirler. Tipik olarak akademik yönden başarısızdırlar ve suç davranışları gösterirler. Sıklıkla anoreksiya, aşırı hareketlilik ve enürezis ve enkoprezis öyküleri de vardır. Aşırı alkol alma, ilaç kötü kullanımı görülmesine karşın bunları kullanma bağımlılık düzeyinde değildir. Bunlarla terapötik işbirliği kurmak zordur ve terapiden sıklıkla kaçınırlar ve/ya da sorunların varlığını inkâr ederler.

Bu koddaki yetişkinler, genellikle majör bir kişilik bozukluğu ya da psikotik bir süreç gösterirler. Duygusal olarak diğer insanlar tarafından öngörülemeyen olarak değerlendirilirler. Sosyal yargılamanın kötü olması,

uyumsuzluk ve impulsivite, dışa vurma olasılığının artmasına neden olur. Okul ve iş öykülerinde başarısızlık ve marjinal uyum vardır. Bu bireylerin bazıları sosyal olarak soyutlanmış ya da göçebe hale gelirler. Diğerleri toplumun suçlu taraflarında yer alırlar. Bu koddaki bireylerin işlediği suçlar (özellikle test 6 ve 9 da yüksekse) sıklıkla anlamsızca yapılmış, zalim ve acımasızdır, kötü planlanmıştır ve sapkın cinsel davranışlar ya da cinayet işleme dönemlerini içerir. Bu koddaki erkeklerin açık suç davranışı içine girme olasılığı fazladır. Yaşlı erkeklerin cinsel sapkınlıkları olabilir. Sıklıkla, eylemevuruk davranışlar sanki yakalanmalarını sağlayacak biçimde yapılır.

Kadınların sıklıkla yasadışı hamilelikleri ve her alanda başarısız olan erkeklerle ilişki kurma öyküleri vardır ve sıklıkla yeterlilikleri sınırlıdır. Bu kadınların benlik değerleri düşüktür ve daha az yeterli görünen kimselerle daha rahat ederler. Genellikle başkalarına cinsel olarak yaklaşmayı tercih ederler ve duygusal yakınlıktan kaçınır gibidirler.

Olası tanı: Psikiyatrik yatan hasta ise şizofreni (Paranoid tip)
Borderline kişilik bozukluğu
Antisosyal, paranoid, şizoid kişilik bozukluğu

48/84 Kodu (Yüksek F/Düşük 2 Kodu)

Bu bireyler genellikle başkalarından farklı ve yabancılaşmış olmaktan dolayı rahattırlar ve başkalarına ebeveynlik ederler. Sıklıkla saldırgan ve cezalandırıcıdırlar ve başkalarını kontrol etmeye çalışırlar. Eğer zekâ puanları ortalamanın üstünde ise diğerlerinde suçluluk ve anksiyeteye yaratarak onları manipüle edebilirler. Başka bir deyişle, bunların davranışları, katı bir disiplinden gerçek sadizme kadar geniş bir ranjda olabilir. Bu profildeki bazı bireyler (özellikle eğer K da yüksekse), bu özellikleri vurgulayan işlere girebilirler. (Yasa koyma ve yürütme, askeri uzmanlıklar vb..) Bu örüntüdekilere "sosyopat kişilik" tanısı konulabilir.

482/842/824 Kodları

Daha önce verilen 48/84 tanımlarına ek olarak, bu bireylerde depresyon, anksiyete, gerginlik, sinirlilik yaygındır. Bunların duyguları çok çeşitlidir, ancak genellikle suçluluk, aşağılık ve umutsuzluk duyguları görülür. İntihar girişimleri göreceli olarak fazladır.

Kalıcı (uzun süreli) kişilerarası ilişkileri (özellikle heteroseksüel) yoktur. Genelde bu bireyler bekârdır ya da sorunlu evlilikleri vardır, cinsel çatışmalar ya da güçlüklerle ilgili sorunlar yaşarlar. Bu insanların güçlü (hatta çoğunlukla abartılmış) ilgi ve sevgi gereksinimleri varsa da, bunlar

başkalarına karşı güvensizdir. Duygusal yaklaşımlar korku yaratır ve bu bireyler hafif duygusal istekler ya da beklentilere karşı çok fazla duyarlıdır.

489/849 Kodları

Yüksek 9 testinin yanı sıra, 48/84 kod yorumlarının eklenmesi tuhaf, hatta garip ve öngörülmez şekillerde eyleme vuruk davranışların ifade edilmesi olasılığını artırır. Davranışsal ajitasyon sıklıkla görülür; bu saldırmaya, savaşıma ve hatta şiddet gösterme biçiminde ortaya çıkar.

49/94 Kodu

Hem yetişkinler, hem de ergenler için, bu kod kendi isteklerini ön plana çıkarma ve sınırlar, kurallar ve düzenlemelere kızma ile bağlantılıdır. Benmerkezcil, narsisistik ve bencildirler, kendi hedeflerine ulaşmak için çok fazla enerji harcasalar da tipik olarak kendilerine verilen sorumlulukları kabul etmede isteksizdirler. Çoğu aktivitelerini haz alma, heyecan ve kısa vadeli hedefler üzerine yoğunlaştırırlar. Sosyal standartların ve değerlerin onlar için önemi çok azdır ve değerler konusunda bocalama yaşarlar ya da kendilerine uygun biçimde kendi değerlerini oluştururlar. Birey 20 yaşın üstünde olduğunda, örüntü daha kalıcıdır ve daha fazla uyumsuzluk vardır.

Kısa kişilerarası bağlantılar ve sosyal durumlarda, bu bireyler sıklıkla iyi izlenim bırakırlar, çünkü enerji dolu ve güvenli görünürler ve güvensizlikleri ya da kaygıları yok gibidir. Ancak, uzun süreli ilişki durumunda genellikle başkalarına bağlanmaları konusunda yüzeysel ve yapay ve hatta sorumsuz ve güvenilmez oldukları ve böylece insanlara yabancılaştıkları ortaya çıkar. Evlilik uyumları kötü olabilir ve birçoğu evlilik dışı ilişkilere girebilir.

Bu koddaki ergenlerin tahmin edileceği gibi düşük bir engellenme eşiği vardır, ebeveynleri ile sık sık çatışırlar ve okuldan kaçarlar. Genellikle impulsif, umursamaz ve kıskırtıcı davranışlar (örneğin yalan söyleme, dolandırma ve hırsızlık gibi) gösterirler. İlaç ve aşırı alkol kullanımı geneldir. Bu gençler sıklıkla tekrarlayan biçimde ailenin adına zarar verebilecek yasal ya da sosyal sorunlar içine girerler.

Eğer K testi 50 T puanının üzerinde ise ve/ya da test 2, 5, 7 ya da 0 70 T puanı üstünde üçüncü yükselen test ise hem ergenler, hem de yetişkinlerde suç işleme ya da antisosyal davranış olasılığı daha azdır. Alt test Si 50 T puanının altında olduğunda 49/94 özelliklerine sahip olsa bile bireyin sosyal ilişkileri iyidir. Sıklıkla bu bireyler dışa vuruk davranışları

göstermek yerine, diğerlerini antisosyal davranışlar yönünde manipüle ederler. Erkekler için, test 8, 5 ve 3, sıklıkla üçüncü en yüksek testtir. Kadınlar için test 8, 3 ve 6, sıklıkla üçüncü yüksek testtir.

Bu bireyler için psikoterapi prognozu genellikle çok kötüdür, yaşla gelen olgunluk yararlı olabilir. Çoğunun geçmiş yaşantılarından ders alma yeteneği eksiktir ve arzularının doyumunu geciktirme yetenekleri yoktur. Çoğu tedaviyi erken bitirir ve tedavi sırasında genellikle sinirli ve düşmanca bir tutum sergilerler.

Olası tanı: Antisosyal kişilikle birlikte bazı tip karakter bozuklukları
Pasif agresif kişilik bozukluğu agresif tip

493/943 Kodları

49/94 özelliklerine ek olarak, bu bireyler özellikle benmerkezcildir ve kendilerine yönelik içgörüler yoktur. Bunlarda eylemevuruk davranış olasılığı nadirdir ve olumsuz duygularını daha çok pasif-agresif ve dolaylı yollardan gösterirler. Alt test 3, test 4'ün 5 T puanı alanı içinde ise 34/43 kod tipinin özellikleri de bulunabilir (bakınız 34/43 kodları). Böylece, bu koddaki bazı bireyler kızgınlıklarını sadece hiddetlenme şeklinde (genellikle bir aile üyesine karşı) açığa çıkarmak için biriktirebilirler.

495/945 Kodları

Alt test 5'in ek olarak yükselmesi ya bireyin açık ve küstah bir biçimde doğal olmayan bir cinsel yönelimi (genellikle homoseksüel) kabul etmesini gösterir ya da daha sıklıkla çok iyi eğitim görmüş, ilgi alanları geniş ve böylece impulsifliği ve isyankarlığı kontrol edebilmiş, daha sosyal bir bireyle bağlantılıdır. Bazen bu bireyler kendilerini var olan geleneklere karşı çıkan sosyal hareketler içine sokarlar. (Özellikle test 4 ve 9'un orta derecede yükseldiği ve test 7'nin de 70 T puanı ya da üstü olduğu durumlarda.) Böyle olsa da, bu bireyler kuralları, düzenlemeleri ya da diğerlerinin sıkı kontrolünü sevmeyen ve kendi özgürlüklerine ve kendi ilgilerine fazla değer verirler.

496/946 Kodları

Bu kodlar saldırgan, zarar verici ve hatta homisidal davranış göstermektedir. (özellikle eğer test 8 de yükselmişse.) Bu örüntü bireylerde sıklıkla aniden garip biçimlerde ortaya çıkar ve bunlar daha sonra yanlış yaptıklarını ya da kendilerini zayıf hissettiklerini belirtirler.

Bunların yargılamaları ve olumsuz duygularını kontrolleri kötüdür (özellikle eğer K alt testi 50'nin altında ise).

498/948 Kodları (Ayrıca 489/849 ve 496/946 kodlarına bakınız.)

49/94 özelliklerine ek olarak, doğal olmayan, hatta tuhaf davranış olasılığı çok yüksektir. 20 yaşın üstündeki bireylerde, bu kod genellikle majör ve uzun süreli bir psikopatolojiyi gösterir.

Ergenlerde, bu kod sıklıkla (bu koddaki daha yaşlı bireylerde daha sıklıkla bulunan yeni başlayan ya da açık psikozdan çıkma) durumsal güçlükler ve yoğun bir ergenlik dönemi isyanı ile bağlantılıdır.

Ancak, hem yetişkinler, hem de ergenler yabancılaşma duyguları, aile çatışmaları, yüksek enerji düzeyleri, otoriteyle güçlükler ve isyankar davranışlar gösterirler.

40/04 Kodu

Nadir görülen bu kod tipinde sıklıkla üçüncü yüksek test 2, 6 ve 8'dir. Bu koddaki bireyler hem kızgındırlar, hem de kişilerarası ilişkilerde geri çekilmişlerdir. Tipik olarak kızgınlıklarını açık biçimde ifade etmezler, uygun biçimde atılma davranışlarında güçlükleri vardır ve kıskançlık duygularını içlerinde tutma eğilimindedirler. Şüpheli, küskün ve utangaçtırlar, pasif olarak direnme eğilimindedirler. Ek yorumlama üçlü kod ya da diğer 2'li kodların analizine (örn. yüksek 4, düşük 5) dayanır. Üçlü koda sıklıkla Si'nin alınmaması ve sonra kalan ikili koda ilişkin yorumların elde edilmesi ve buna yüksek Si testine ait bilginin eklenmesi yararlı olur.

Yüksek puanla görülen bir depresyon durumu varsa bu çoğunlukla gerçek, psikomotor retardasyon ya da vegetatif depresyon belirtileri yerine depresif düşünce ve duygulara ilişkindir. Depresyon, davranışlarından dolayı suçlanmaktan çok, o andaki sınırlılıklar nedeniyle hoşnutsuzluktan kaynaklanır. Kendi davranışlarına olan ilgisizlikleri nedeniyle psikoterapötik yaklaşımda fazla etkili değildirler. Kişisel olgunlaşma, diğer yaklaşımlardan daha etkili olabilmektedir. Alt test 4'te yüksek puan alanlara bazen kişilik bozuklukları tanısı konulabilir, ancak psikotik tanısı almazlar. Alt test 4'teki yükselme, suça ilişkin davranışlar ve hapse girip çıkma oranıyla pozitif korelasyon gösterir.

5. Kadınlık-Erkeklik (Mf) Alt Testi

Bu alt test, cinsel kimlikteki sapmaları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu alt testteki maddeler oldukça heterojendir. Çeşitli mesleklerle karşı ilgi, boş zaman faaliyetleri, uğraşlar, sosyal aktivitelerle ilgili maddelerden başka korkular, endişeler ve bireysel duyarlılıklarla ilgili maddeler bulunmaktadır. Doğrudan doğruya cinsel içerikli maddeler de vardır. Mf alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 12'de gösterilmiştir.

Tablo 12: Kadınlık-Erkeklik alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 60)

Doğru											
4	25	69*	70	74	77	78	87	92	126	132	
134	140	149	179*	187	203	204	217	226	231*	239	
261	278	282	295	297*	299						
Yanlış											
1	19	26	28	79	80	81	89	99	112	115	
116	117	120	133*	144	176	198	213	214	219	221	
223	229	249	254	260	262	264	280	283	300		

Not: (*) İşaretili sorular kadınlarda ters yönde puan almaktadır.
Erkeklerde ortalama: 29.21, kadınlarda ortalama: 32.98
(Savaşır 1981)

Mf alt testinde yüksek puan alan bir erkek: (Graham 1987)

1. Cinsel kimliğine ilişkin çatışması vardır, depresyon ve psikotik semptomlar göstermez, hoşnuttur, duragandır.
2. Erkek rolünde güvensizdir.
3. Estetik ve artistik ilgileri vardır.
4. Kadınsıdır.
5. Zeki ve yeteneklidir.
6. Hırslı, yarışmacı ve sabırlıdır.
7. Zeki, mantıksal ve düzenlidir.
8. İyi yargılama yeteneği vardır, sağduyuludur.
9. Meraklıdır.
10. Yaratıcıdır, hayal gücü zengindir ve sorunlara yaklaşımı bireyseldir.
11. Sosyaldır, insanlara duyarlıdır.
12. Hoşgörülüdür.
13. Diğerlerine olumlu duygular göstermede yeteneklidir.
14. Kişilerarası ilişkilerde pasif, bağımlı ve itaatkardır.

15. Barışı sever, çatışmadan kaçınmak için boyun eğmeyi tercih eder.
16. Kendini iyi kontrol eder, nadiren eyleme vuruk davranış gösterir
17. Homoerotik eğilimler ya da bastırılmış homoseksüel davranışlar gösterebilir

Mf alt testinde yüksek puan alan bir kadın:

1. Geleneksel kadınlık rolünü reddetme eğilimindedir.
2. İş, spor ve hobilerde erkeksi ilgileri vardır.
3. Aktif ve atılgandır.
4. Yarışmacı, saldırgan ve yönlendiricidir.
5. Kaba, terbiyesiz ve serttir.
6. Açık yüreklidir, serbest, kendine güvenlidir.
7. Kolay yönlendirilir, rahat ve dengelidir.
8. Mantıksal ve hesaplıdır.
9. Duygusuzdur.
10. Arkadaş canlısı değildir.
11. Eğer psikiyatrik hastaysa hallüsinasyonlar, delüzyonlar ve kuşkuculuk gösterir, ancak eyleme vuruk davranışlara rastlanmaz.
12. Eğer psikiyatrik hastaysa psikoz tanısı alma olasılığı vardır.

Mf alt testinde düşük puan alan bir erkek:

1. Kendini aşırı düzeyde erkeksi olarak sergiler.
2. Fiziksel güç ve cesarete önem verir.
3. Saldırgan, maceracı ve pervasızdır.
4. Kaba ve serttir.
5. Kendi erkek kimliğine ilişkin şüpheleri vardır.
6. Entellektüel yeterliliği sınırlıdır.
7. İlgi alanları daralmıştır.
8. Katıdır ve sorunlara yaklaşımı yaratıcı değildir.
9. Hareketi düşünceye tercih eder.
10. Pratiktir.
11. Kolay uyum sağlayan sakin ve rahattır.
12. Neşeli, esprilidir.
13. Halinden memnundur.
14. Çevresini nasıl etkilediğini fark etmez.
15. Kendi güdülerine ilişkin içgörüsü azdır.

Eğitim düzeyi düşük kadınlarda Mf alt testinde düşüklük:

1. Kendini geleneksel kadın rolünde gibi sergiler.
2. Kendi kadınlığı konusunda şüpheleri olan .
3. Pasif, uysal, itaatkardır.
4. Kendinden memnun değildir, yakınan biridir.
5. Diğerleri tarafından katı, duyarlı, idealistik olarak tanımlanır

6. Karar verirken erkeklerin düşüncelerine başvurur.
7. Sıkıcıdır.
8. Duygudur.
9. Alçakgönüllüdür.
10. Idealisttir.
11. Eğer hastanede yatan psikiyatrik hastaysa büyük olasılıkla psikotik değildir.
12. Eğer hastanede yatan psikiyatrik hastaysa diğer kadın hastalara kıyasla daha sosyaldır.

Eğitim düzeyi yüksek olan kadınlarda Mf alt testinde düşüklük:

1. Geleneksel kadın rolünü reddeden
2. Stereotipik bir biçimde kadın olmadığı halde pekçok geleneksel kadınsı ilgileri vardır.
3. Kendini yetenekli, mücadeleci olarak görür.
4. Kendini alaycı, hayalperest olmayan, ilgisiz biri olarak tanımlar.
5. Diğerleri tarafından zeki, yetenekli, zorlayıcı, içgörüsü olan biri olarak tanımlanır.

Erkeklerde Mf değerlendirmesi

80 ve üstü T puanı: Lise eğitimi olan erkeklerde ya da kültürel baskı altındakilerde kültürün verdiği erkeksi rolle özdeşim olmadığını göstermektedir. Yüksek puanlar göreceli olarak pasif erkeklere (eğer 4 alt testi de düşükse) hatta bazı durumlarda kadınsı özelliklere sahip olanlara işaret etmektedir.

70-79 T puanı: Bu erkekler hayal kurmayı seven, içedönük, eğitim.yönelimli, sporlara özel ilgi duyan kişilerdir. Genellikle bu gruptaki erkekler idealist ve hayalperest bireylerdir, sosyal açıdan duyarlıdır ve kolay ilişki kurarlar. Eğitimi iyi olan ve kültürel açıdan zengin olan kişilerde bunlar beklenen özelliklerdir.

60-69 T puanı: 65 T puanının üstündeki yükselmeler demografik ve klinik veri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Üniversite öğrencilerinin bu aralıkta puan almaları beklenen bir durumdur. Ayrıca sanatla ilgileri olanlar da (ressamlar, artistler) bu alanda puan alırlar.

41-59 T puanı Erkeklerde erkeksi ilgiler ve davranışlar olduğunu göstermektedir ve bütün ilgileri bu alanda daralmıştır. Maceracı kişilerdir, dışarda yapılan aktiviteleri, sporları ya da mekanik aktiviteleri

severler. Bu örüntüye düşük iş ilgileri eşlik eder. Ergen erkeklerde Mf düşüklüğüne, suç ve okul ile ilgili sorunlar eşlik etmektedir.

26-40 T puanı: Bu erkeklerde maskülen görünmek için kompulsif bir uğraş vardır ve bu abartılmış bir boyuttur. Bunlar, narsisistik bir biçimde kendi güçlerini abartırlar. Bireyin kendi erkekliğini yoğun bir biçimde ortaya koyması, altta yatan kendine güvensizlik ile ilgilidir.

Kadınlarda Mf değerlendirilmesi:

65 T puanının üstü: Bu kadınlar güçlü, kuvvetli, saldırgan, yönlendirici ve yarışmacıdır. Geleneksel erkek rolüne özgü aktivite ve işlere girerler. Güvenli ve spontandırlar, ancak heteroseksüel ilişkilerin olduğu alanlarda ketlenmeleri vardır. Kadınsı cinsel kimliğe uyum sağlamalarının beklendiği durumlarda anksiyöz olabilirler. Bu kadınlar iddiacı, yarışmacı, inatçıdırlar ve diğer kadınlar gibi görünmek ve davranmaktan hoşlanmayan kişilerdir. Buna karşın davranış ve düşüncelerinde bağımsız, kendine güvenli, spontan, dominant ve saldırgan olabilirler. Bu, kariyer ve iş ile aşırı uğraşma, erkeksi spor ve ilgi alanları ya da dominant, lezbiyen cinsel oryantasyonlar görülür. Bu kadınların çoğunluğu kendilerini kontrol edemeyecekleri durumlarda, özellikle karşı cinsle ilişkilerinde kontrolsüz bir durum varsa çok rahatsız hissederler.

Ergen kızlarda 5'in yükselmesi ev, okul ve yasalarla ilgili sorunlar olduğunu gösterir. 14-19 yaşları arasındaki kızlarda 5 yüksekliği normal olabilir, ancak bu yaşlardan sonra oldukça nadirdir. 5 yüksekliği sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ve farklı kültürlerden gelen kadınlarda da görülebilir.

56-65 T puanı: Kadınlarda 60 ve üstündeki T puanı onların aktif, atılgan ve yarışmacı olduklarını göstermektedir.

41-55 T puanı: Bu kadınların ilgi alanları orta sınıf kadınların ilgilendikleri konular ile sınırlıdır. Duyarlı kişilerdir, bu duyarlılık erkeklerle ilişkilerinde daha da belirginleşmektedir. Giyimleri ile kadın olduklarını açıkça gösterirler.

26-40 T puanı: Bu yükselme kadınların pasif, çekingen olduğunu göstermektedir. Mf düşüklüğü nevrotik üçlüde yükselme ile ilişkilidir. Eğer Pd yükselmesi, Mf düşüklüğüne eşlik ediyorsa seksüel impulsların olası eyleme vurukluğuna dikkat edilmelidir. Bu kadınlar

herhangi birşeyden mutlu olmamak için ellerinden gelen gayreti gösterirler.

Erkeklerde sadece Mf alt testinin yükselmesi: Sadece test 5'in yükselmesi açık ya da örtük homoseksüaliteyi gösterme açısından yeterli değildir. Kendi homoseksüalitesini göstermek isteyen bireyler bu testte yavaş bir yükselme yaparlar. Erkeklerde 5 testinde 75 T puanı ve üstü, eğitim düzeyleri orta ya da lise 1 ise ve oldukça katı kültürel baskı varsa, bu erkeklerde geleneksel erkeksi yaşam biçimi yoktur, yüksek puanlar pasif erkekleri gösterir (eğer alt test 4, düşük ise) ve çoğunluğunda kadınsı özellikler vardır.

Mf alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

51/15 Kodu (Bakınız 15/51 kodu)

52/25 Kodu (Bakınız 25/52 kodu)

53/35 Kodu (Bakınız 35/53 kodu)

54/45 Kodu (Bakınız 45/54 kodu)

56/65 Kodu

Bu kod tipindeki bireyler hakkında çok az bilgi vardır. Genel olarak duygularının incinmesi konusunda aşırı duyarlıdırlar ve başkaları ile duygusal ilişkiye girmede kendilerine güvenmezler, bundan korkarlar. Eğer başkaları ondan birşey isterse sinirlenirler. Çoğunluğunun eğitim düzeyi yüksektir ve kariyer sahibi kişilerdir.

Daha ayrıntılı bilgi, üçüncü yükselen ölçeğe bakılarak elde edilir. T puanının 70'in üzerinde olduğu başka bir test varsa 5 dışlanır ve diğer 2 test değerlendirilir (örneğin, 564/654 kodu. 46/64 değerlendirilmeli ve test 5'te yükselme olduğu söylenmelidir).

57/75 Kodu

Kararsız, endişeli, içedönük, gergin, mutsuz ve sürekli onay bekleyen erkeklerdir. Eğitim düzeyi düşük olan erkeklerde, kendi yetersizlikleri ile obsesif ruminasyonlar, anksiyete ve depresif dönemler vardır. Karşı cinsle ilişkilerinde sıklıkla kendilerini yetersiz hissederler. Kadınlarda bu çok daha azdır, 5 testinde görüldüğünden çok daha az agresif ve daha çok kendilerini analiz eden kişilerdir. Entelektüel olarak yarışmacıdırlar.

58/85 Kodu

Bu koddaki erkekler içe dönüktür ve zamanlarının çoğunu düşünme ile geçirirler. Genellikle konfüzyonda, mutsuz ve diğerlerine yabancılaşmış oldukları duygusunu yaşarlar ve ev çatışmaları vardır. Yorum yapılırken 5 dikkate alınmadan diğer yükselen 2 alt teste bakılmalıdır.

59/95 Kodu

Erkeklerde 5'in yükselmesi açık eylem evrük davranışların azaldığını gösterir, burada entellektüalizasyonun, inkârın, rasyonalizasyonun aşırı kullanımı vardır. Aslında bu koddaki erkeklerin çoğu akademik olarak başarılıdır. Duygusal bağımlılık (anne bağımlılığı) ve benlik atılganlığının olmaması sorun alanlarıdır.

Kadınlarda 5 alt testinin yükselmesi saldırganlığın açığa çıkmasını gösterir, bu saldırganlık duruma bağlı sözel ya da davranışsaldır. Bu kadınlar enerjiktir, yarışmacıdır (erkeklerle yarışır), kendilerine güvenirler, engellenmemiş ve maceracıdır, eğer onların istekleri soruşturulur ya da engellenmek istenirse sinirli ya da kendine dönük olurlar.

Her iki cinsiyet için de test 5 bırakılarak diğer yükselen 2 alt test üzerinden yorum yapılmalıdır.

50/05 Kodu

Bu koddaki erkekler içe dönüktür ve genellikle kişisel ve entelektüel izolasyon yaşar, diğerlerine ulaşmak istemezler. Diğerleri ile ilişkilerinde temkinli, engellenmiş, içe çekilmiş ve kaygılıdırlar. Aşırı kontrollüdürler ve herşeyi aşırı idealize ederler. Sosyal açıdan beceriksizdir, atılgan olma konusunda sorunları vardır, kendi yeterlilikleri konusunda hep sorgulama içindedirler. Karşı cinsle ilişkilerinde sorunlar ve rahatsızlıklar vardır.

Bu koddaki kadınlar tipik olarak daha az kendine güvenen, spontan ve güçlüdürler ve bu testin yükselmesinden beklenenden daha atılgandırlar. Sıklıkla kadınların eğitim düzeyi daha düşüktür, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelirler. Her iki cinsiyet için de daha ileri yorum 5 bırakılarak yapılmalıdır.

6.Paranoya (Pa) Alt Testi

Paranoya geç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan başkalarının davranışını kötü niyetli olarak yorumlayan sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk durumudur. Pa alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 13'de gösterilmektedir.

Tablo 13: Paranoya alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü
(Madde Sayısı: 40)

Doğru										
15	16	22	24	27	35	110	121	123	127	151
157	158	202	275	284	291	293	299	305	317	338
341	364	365								

Yanlış 93 107 109 111 117 124 268 281 294 313 316
319 327 348

319 327 347 348
Erkeklerde ortalama: 11.12, kadınlarda ortalama: 11.93
(Savaşır,1981)

Pa alt testinde yüksek puan alan bir birey:(Graham 1987)

- Pa alt testinde yüksek puan alan birey:
1. Açık psikotik bir davranış gösterir.
 2. Düşünce bozukluğu vardır.
 3. Perseküsyon ve/ya da grandioz türünde delüzyonları vardır.
 4. Referans fikirleri vardır.
 5. Kendine kötü davranıldığını ya da kendisiyle alay edildiğini düşünür.
 6. Öfkeli ve güceniktir, kıskançlık içindedir.
 7. Savunma mekanizması olarak yansıtmayı kullanır.
 8. Tanı sıklıkla şizofrenik ya da paranoid bozukluktur.
- Pa alt testinde düşük puan alan birey: (T: 65-

8. Tanı sıklıkla şizofrenik ya da paranoide bozukluk.
Pa alt testinde orta düzeyde yüksek puan alan birey: (T: 65-70)

1. Paranoid uğraşları vardır.
2. Diğerlerinin tepkilerine aşırı duyarlıdır.
3. Kendini yaşamda haksızlığa uğramış gibi hisseder.
4. Rasyonalize eder, kendi sorunları için diğerlerini suçlar.
5. Şüpheli, savunucudur.
6. Hostil, gücenik, tartışmacıdır.
7. Tutucu ve katidir.

8. Aşırı mantıklıdır.
9. Psikoterapiye yanıtı kötüdür.
10. Duygusal sorunları hakkında konuşmak istemez.
11. Terapistle ilişki kurmakta ve ona sorunlarını anlatmakta güçlüğü vardır.
12. Aile üyelerine karşı hostilite ve gücenme gösterir.

Pa alt testinde hafif düzeyde yüksek puan alan bir birey: (T: 55-64)

1. Eğer psikiyatrik hastaysa ve başka herhangi bir sorunu yoksa:
 - a. Kibar, duygusal ve naziktir.
 - b. Huzurlu ve yumuşak kalplidir.
 - c. Duyarlıdır.
 - d. Güvenilirdir.
 - e. İşbirlikçidir.
 - f. Samimidir.
 - g. İlgi alanları çoktur.
 - h. Enerjiktir.
 - i. İnsiyatif gösterir, iş ve diğer aktivitelerde ego katılımı vardır.
 - j. Zekidir, mantıklıdır, açık düşüncelidir, içgörüsü vardır.
 - k. İtaatkârdır.
 - l. Kendine güveni azalmıştır.
 - m. Beklenti düzeyi yüksektir, endişeye eğilimlidir.
2. Eğer psikiyatrik hastaysa ve başka uyumsuzlukları da varsa:
 - a. Yaşama daha paranoid bir uyumu vardır.
 - b. Çevresini kendisinden isteyen olarak görür, destekleyen olarak değil.
 - c. Diğerlerinin ne düşündüğü konusunda aşırı duyarlıdır.
 - d. Diğerlerinin motiflerinden şüphelenir.
 - e. Öfkeli ve gücendir.

Pa alt testinde düşük puan alan bir birey: (T: 35-45)

1. Psikiyatrik hasta değilse ve herhangi bir sorunu yoksa:
- a. Neşelidir.
 - b. Dengelidir.
 - c. Düzenlidir.
 - d. Ciddi, olgun ve mantıklıdır.
 - e. Akıllı ve kararlıdır.
 - f. Sosyal açıdan ilgilidir.
 - g. Sorunlarla kolay bir biçimde başeder.
 - h. Güvenilir ve sadıktır.

1. Kendini kontrol eder, temkinlidir.
2. Eğer psikiyatrik hastaysa ya da uyumsuzluğun diğer göstergeleri varsa:
 - a. İnatçı ve savunucudur.
 - b. Benmerkezcildir.
 - c. Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeylere çok az ilgi gösterir.
 - d. Kendinden hoşnut değildir.
 - e. Diğerlerinin tepkilerine aşırı duyarlıdır.
 - f. Anlayışsızdır.
 - g. Sosyal ilgileri ve yetenekleri sınırlıdır.
 - h. Vicdanı gelişmemiştir, kuralları çok dikkate almaz.
 - i. Kabadır.
 - j. Huysuz ve karşıttır.
 - k. Yeteneksizdir.
 - l. Psikotik semptomlar pek görülmez, bu nedenle psikoz tanısı konulmaz.

Pa alt testinde aşırı derecede düşük puan alan bir birey:
(T<35)

1. Açık paranoid bozukluğu olabilir.
2. Delüzyonları olabilir, şüpheler, etkilenme düşünceleri gösterebilir.
3. Semptomları Pa alt testinde yüksek puan alan bireylerden daha belirsizdir.
4. Baştan savıcı ve savunucudur.
5. Utangaçtır, sırlarla doludur ve içe çekilmiştir.

80 ve üstü T puanı: Kuşkulu, kızgın, küskün ve durumların doğrudan kendilerine yöneldiği biçiminde yorum yapan kişilerdir. Bu bireylerin çoğu paranoiddir, referans fikirleri vardır, temel savunma mekanizması yansıtmadır. Gerçeği değerlendirme bozuktur, delüzyonlar, perseküsyon veya da grandiyöz biçimindedir.

70-79 T puanı: Diğerlerini suçlama ve hostilite temel özelliklerdir. Bu bireyler katı, inatçı ve aşırı duyarlıdırlar. Kişilerarası ilişkilerde aşırı savunucu tutumları nedeniyle yanlış anlaşılabilirler. Açık paranoid özellikler vardır.

60-69 T puanı: Duyarlı bireylerdir, kendilerinin ve diğerlerinin duygularının kolaylıkla incinebileceği türünde düşünceleri vardır. Bu sıklıkla depresyonla ilgilidir, diğerlerinden gelen eleştiri ve önerileri çok ciddiye alırlar ve kendilerinin söyledikleri herşeyin eleştiri gibi alındığı fikri vardır. Kişilerarası ilişkilerinde savunucu ve diğer insanlara güvensizdirler, diğerlerinin kendilerinden yararlanacağını düşünürler.

Kırgın, küskün olmaya hazırdırlar, çünkü en ufak bir olumsuzluğu üstlerine alırlar, işte ve evde kendilerinden beklentiler konusunda kontrollüdürler.

45-59 T puanı: Bu kişiler diğerlerini değerlendirmede esnekler. Onlara karşı duyarlıdırlar ve diğerlerinin kendilerinden beklentilerini doğru anlayarak olumlu yanıt verirler. 55-59 T puanı arasında olan bireyler anlayışlı, duyarlı kişilerdir.

27-44 T puanı: İki tip insan bu puanı verebilir: Diğerlerine duyarlılığı olmayan kişiler ve çok fazla şüphesi ve endişesi olan kişiler. Bunlar paranoya maddelerini atırlar. Diğerleri ise yüksek puan alan kişilerle aynıdır. Düşük puan alan bireyler geleneksel, güvenilir, kişilerarası ilişkilerde duyarsız, ilkel ve saftırlar. Zekaları sınırlıdır ve ilgi alanları daralmıştır.

Sadece Pa alt testinin yükselmesi: Bu bireyler aşırı duyarlı, katı, gergin ve kaygılıdırlar. Yaşamlarında iş ve sosyal baskı olduğunu hissederler. Şüphelilik, güvensizlik, düşüncelere dalma vardır. Diğerlerini suçlamaya yönelik bir projeksiyon mekanizmaları vardır. Sorunlara aşırı tepki verirler.

Pa alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

61/16 Kodu (Bakınız 16/61 Kodu)
62/26 Kodu (Bakınız 26/62 Kodu)
63/36 Kodu (Bakınız 36/63 Kodu)

64/46 Kodu (Ayrıca 46/64, 462/642, 463/643 kodlarına ve 468/648 kodlarına bakınız.)

Bu koddaki bireyler immatür, narsisistik, pasif bağımlı kişilerdir. Kendileri ile sosyal ve kişisel olarak ilişki kurmak zordur. Diğerlerine öfke duyarlar ancak bunu kontrol edebilirler. Zaman zaman öfke patlamaları olur. Kızgınlıklarının suçunu başkalarına yüklerler. Diğer insanların güdülerinden kuşkuludurlar ve paranoid özellikler yaşarlar. Uzun zamandan beri sosyal uyumsuzluk gösterirler. Sonuç olarak psikolojik yardım için uygun kişiler değillerdir. 64/46 kodunun yanında 8 alt testi de yükselmisse süreç daha kötü olur. Yukarıdaki özelliklere ek olarak bu hastalar psikolojik sorunlarını kabul etme yerine kaçma yolunu seçmektedirler. Mantık ve yargılamalarda da güçlükleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar öfkeyle doludurlar ve bu da onların eleştiriye duyarlılık ve kıskançlıkları ile birleştiğinde tahmin edilemeyen ve mantıksız öfke patlamalarına yol açar. Açık olarak herşeye karşı çıkarlar

ve düşmancıldır. Davranış değişikliği için getirdikleri çözüm ise, karşısındakilerin kendi belirtilerine uygun bir şekilde davranış değiştirmesidir.

648 Kodu

Süregen sorunlarına karşı savunucudurlar ve sorunlarında kendi rollerini inkâr ederler. Huzursuz, şüpheli, narsistik, sürekli isteyen rolündedirler. Rasyonalizasyon ve yansıtma savunma mekanizmalarını kullanırlar. Klinik olarak referans fikirleri, delüzyonlar, duygusal labilite ve kaygı görülür. Impulsif, manipulatif davranışları olabilir. Otorite figürleri ile çatışma içindedirler. İntihar girişimleri, ilaç kullanımı olabilir. Profil tipi kroniktir.

65/56 Kodu (Bakınız 56/55 Kodu)

67/76 Kodu

Oldukça nadir görülür 2 ya da 8 alt testleri yükselen üçüncü koddur. Bu koddaki bireyler gergin, kaygılı, aşırı duyarlı ve sıklıkla çabuk küsen kişilerdir. Başkalarının kendilerine haksızlık ettiğini düşünerek ilişkilerini bozarlar. Aşağılık ve/ya da suçluluk duyguları vardır ve bunu diğerlerine yansıtırlar. Eğer 6 alt testi 7'den daha yüksekse ya da ikisi diğerlerine yansıtırlar. Eğer 6 alt testi 7'den daha yüksekse ya da ikisi aynı düzeydeyse, obsesif-kompulsif bozukluktan psikotik döneme bir geçiş olabileceği dikkate alınmalıdır. Her iki cinsiyette de 2 ve 8, üçüncü yüksek alt testtir.

Olası tanı: Dekompanze obsesif kompulsif bozukluk

Alt test 6, 7'den daha yüksek ya da aynı düzeyde ise obsesif kompulsif bozukluktan şizofreniye geçiş olasıdır.

★ 678/876 Kodları ✓

6 ve 8, 7'den yüksek ise bu, psikotik vadiyi oluşturur. Ciddi psikopatolojileri vardır. Şizofrenik bozukluktan paranoid tip tanısı konulabilir. Hallüsinasyonlar, delüzyonlar ve aşırı şüphelerle birlikte görülür. Affektleri donuktur. Bunlar ürkek, içedönük, sosyal ilişkilerde çekingen ama alkol aldıklarında agresif olan kişilerdir. Bellek ve konsantre olmada sorunları olabilir. Fantezi ve hayal âleminde yaşarlar. Geçmiş ya da hayali hatalar hakkında ruminatif düşünceleri vardır.

679 Kodu

Aşırı duyarlı ve katıdırlar, sosyal ve iş yaşamlarında, kendilerini bastırılmış hissederler; şüphelidirler ve güvensizlik duyarlar, çabuk gücenirler ve öfke patlamaları vardır. Impulsif dönemlerini, dönemsel suçluluk ve kendine yönelme izlemektedir.

68/86 Kodu (Ayrıca 468/648, 486/846, 489/849 kodlarına bakınız)

Bu kodu alan kişilerde yoğun aşağılık ve güvensizlik duyguları dikkati çeker. Kendilerine güvenleri ve saygıları yoktur.

Pd ve Pt alt testleri, en yüksek üçüncü testtir. Hem ergenlerde, hem de yetişkinlerde bu kod ciddi psikopatolojiyi gösterir ve F alt testi de yükselmiştir, birey kabul edilmeyen yaşantılar getirir. "Paranoid vadi" varsa bu daha çok görülen bir durumdur. Paranoid vadede 6 ve 8 alt testleri 70 T puanı civarındadır ve 7 alt testi 10 T puanı aşağıdadır. Eğer diğer alt testler 6 ve 8'den daha yüksekse paranoid vadinin olduğu durumlarda paranoid şizofreni düşünülmelidir. Bu bireyler mutsuz, sinirli, negativistik olarak tanımlanır. Düşünce sürecindeki bozukluklar aşırı genellemeler, yanlış yorumlamalar ve delüzyonlar ile kendini gösterir. Duygusal uygunsuzluk, aşırı idealleştirme, şüphe, güvensizlik, konsantre olmada güçlük, gerçek ile bağlantı kopukluğu ve bozuk kişilerarası ilişkiler vardır, bunlara depresyon ya da korkular ve fobiler eşlik eder. Bu bireylerin düşünce süreçleri garip olmamakla birlikte gerçeğe çok uygun değildir. Cinselliğe ilişkin içrel çatışmalar vardır. Tipik olarak sosyal açıdan içe çekilmiş ya da izoledir (yetişkinlerin çoğu yalnızdır) ve zamanlarının çoğunu kendi kurdukları fanteziler ile geçirirler. Eğer evli iseler, eşleri duygusal açıdan içe çekilmiş ve yabancıdır. Davranış açısından bu bireyler yordanamaz, 4'ün yükseldiği durumlarda bu daha da zor olmaktadır.

Yetişkinlerin çoğunluğu işlerini devam ettirirler, bu da oldukça şaşırtıcıdır. Yalnız herhangi bir dış etkenle bağlantılı olmadan yorgunluk, yetersizlik ve konsantre olamama ile belirgin psikotik dönemler görülür.

Ergenlerde genellikle saldırgan nöbetler (eğer K 50 T puanının altında ise), kötü arkadaş ilişkileri vardır. Zamanlarının çoğunu kavga etmekle geçirirler, derslerinde başarısızdırlar ve aile içinde ciddi cezalandırmalar ve dayak vardır.

Olası tanı: Paranoid durum

Paranoid şizofreni (6 ve 8 alt testleri 75 T puanının üstünde ise)
Şizoid kişilik

680/860 Kodları

Bu hastalarda paranoid şizofrenide görülen paranoid özellikler ve düşünce bozukluğu vardır. Sistemli hezeyanlar görülebilir. Bu hastalar gerginlik, kaygı, depresyon yakınmaları ile kişisel sıkıntılarını ifade ederler. Sosyal olarak izole ve çekiniktirler. Sosyal ilişkilerde düşmanlık ve şüphe hakimdir. Davranışlar genellikle sosyal açıdan uygun değildir ve önceden tahmin edilemez.

69/96 Kodu (Ayrıca 698/968 kodlarına bakınız.)

Bu tür hastalar gergin ve anksiyöz kişilerdir. Grandiozite ve egosantrik sezgiler içindedirler; heyecanlı ve enerjiktirler. Belirgin olan kızgınlık ve hostilitelerini, sosyal açıdan kabul edilebilir bir biçimde dışsallaştırmada güçlükleri vardır. Düşünce bozukluğunun varlığı halinde bunun manik ya da şizofrenik özellikler mi olduğu gözden geçirilmelidir.

Bu kod daha çok kadınlarda görülmektedir. 4 ve 8 alt testi, en çok yükselen üçüncü gruptur. Bu koddaki kadınlar gergin, daldan dala atlayan, küçük durumlara aşırı tepki veren kişilerdir. Durumları, kendileri için tehdit olarak alırlar. Gürültücü, ilgi çekici, sinirli ve şüpheli olma eğilimi içindedirler ve neyi, niçin yaptıklarını açıklamak isterler. Aile öykülerinde aşırı koruyucu ve sevecen bir anne vardır, ancak çocuklarına çok sert disiplin verirler. Baba genellikle karışmayan bir kişidir. Kadınlar duygusal ilişkiye girmekten korkarlar, diğerleri ile aralarına mesafe koyarlar. Eleştiriye aşırı duyarlıdır ve güvensizlikleri kroniktir. Bazen de kendilerini aşırı derecede duygusal ilişkiye gereksinimleri varmış gibi sergilerler, bu da çelişkili bir durumdur.

Olası tanı: Manik bozukluğun bazı tipleri
Akut psikotik epizod
Alt test F ve Sc yüksekte paranoid şizofreni

694/964 Kodları

Bu hastaların engellenmeye karşı öfke ve şiddetle yanıt vermeleri sıklıkla görülmektedir. Bunların sosyal, aile ve iş yaşamları hostilitelerine, yargılamalarının bozukluğuna ve duygularını kontrol edememelerine bağlı olarak bozuktur. İçgörülerі yoktur ve suç

diğerlerinin üstüne atma tipiktir. Saldırma, mücadele etme ve hatta cinayet potansiyeli değerlendirilmelidir.

698/968 Kodları

69/96 kodunda tanımlanan birey tipine ek olarak bu bireylerde ruhsal karışıklık, konfüzyon, düşünce ve dikkat toplamada güçlük vardır. Ayrıca delüzyonlar, paranoid şüphe ve hallüsinasyonlarda vardır. Eğer 8 alt testi, 6'dan 5 T puanı aşağıda ise 68/86 koduna bakın.

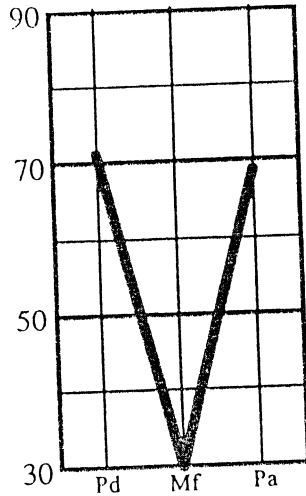
Olası tanı: Şizofreni paranoid tip

60 /06 Kodu

Erkeklerde çok az görülür, genç kadınlarda hemen hemen hiç görülmeyebilir. Kadınlarda özellikle 30 yaşından sonra rastlanır. 2, 4 ve 3 yükselen diğer alt testlerdir. 60/06 kod tipi için bilgiler çok azdır. Bunu veren bireyler utangaç, içe çekilmiş ve kişilerarası ilişkilerde huzursuzdurlar, diğerlerinin kendilerini sevmeyi ya da kabul etmediğini düşünürler. Eleştiriye aşırı duyarlıdır, kendilerini aşağılanmış hissettikleri için reddedilmeyi kolaylıkla kabul ederler. Duygularında oldukça mükemmelliyetçi ve aşırı kontrollüdür.

456 Alt Testlerinin Örüntüsü

Genellikle kadınlarda görülen bir örüntüdür. 4 ve 6 alt testleri T puanı olarak 65'in üzerinde, 5 alt testi T puanı olarak 35'tedir. 4 ve 6 alt testlerinin profilde en yüksek noktalar olması gerekli değildir.



Şekil 21: Scarlett O'Hava Vadisi

Bu örüntüye alt test 3'ün yükselmesi eşlik ediyorsa, bu tür kadınlarda, yüzeysel bir sosyallik, diğerlerine yönelik düşmanlık duygularının inkârı söz konusu olabilir, diğerlerini kontrol ve manipüle etme davranış kalıbını yansıtır. Birey psikolojik yardıma çok dirençlidir.

Bu örüntü, düşmanlık ve kızgınlık duygularını doğrudan ifade edemeyen, bağımlı, daima sevgi isteyen ve düzensiz duygulanım içindeki kadınlarda görülür. Diğerlerini öfkeliendirecek davranışları vardır. Böylece diğerlerini kendilerinden uzaklaştırır ve sonra da kendilerine ne kadar kötü davranıldığını düşünürler; aile, evlilik ve cinsel konularda sorunları vardır. Bu tür kadınlar terapötik ilişkilerde de sorunlar yaratır. Terapisti öfkeliendirirler, bu da terapötik müdahaleyi güçleştirir.

7. Psikasteni (Pt) Alt Testi

Bu alt test, psikasteni ya da obsesif kompulsif bozukluğu değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu hastalarda obsesif ruminasyonlar, kompulsif ritüeller görülmektedir. Ayrıca anormal korkular, karar vermede ve dikkat toplamada güçlük, suçluluk duyguları ve bunaltı sıklıkla rastlanan özelliklerdir. Kendi kendini eleştiride aşırı ahlaki standartlar bu tür kişilerde sıklıkla görülür. Pt alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 14'de gösterilmektedir.

Tablo 14: Psikasteni alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 48)

Doğru										
10	15	22	32	41	67	76	86	94	102	106
142	159	182	189	217	238	266	301	304	305	317
321	336	337	340	342	343	344	346	349	351	352
356	357	358	359	360	361					
Yanlış										
3	8	36	122	152	164	178	329	353		
(K eklemeli)										
Erkeklerde ortalama: 27.90, kadınlarda ortalama: 29.90										
(Savaşır, 1981)										

Pt alt testinde yüksek puan alan bir birey: (Graham 1987)

1. Telâş ve huzursuzluk yaşar.
2. Kaygılı, gergindir.
3. Endişeli ve vesveselidir.
4. Sinirli ve tedirgindir.
5. Dikkatini yoğunlaştırmada güçlüğü vardır.
6. Sıklıkla anksiyete bozukluğu tanısı konulur.
7. İçer dönük, derin düşünceleri olan biridir.
8. Düşüncelerinde obsesiftir.
9. Kompulsif davranışları vardır.
10. Güvensizdir ve aşağılık duyguları yaşar.
11. Kendinden emin değildir.
12. Kendine yönelik şüpheleri vardır, kendini eleştirir.
13. Katıdır.
14. Kendisi ve diğerleri için yüksek standartlara sahiptir.
15. Mükemmeliyetçi ve vicdan sahibidir.
16. Suçluluk duyar ve depresiftir.

17. Temiz, düzenli, tertipli ve titizdir.
18. Tutucudur.
19. Güvenilirdir.
20. Sıkıcıdır.
21. Donuktur.
22. Tereddüt eder.
23. Sorunların önemini çarpıtır, aşırı tepkiseldir.
24. Çekingendir.
25. Sosyal etkileşimde başarısızdır.
26. Anlaşılması zordur.
27. Sevilme ve kabul görme konusunda endişeleri vardır.
28. Huzurlu, yumuşak kalpli, güvenilir, duyarlıdır.
29. Bağımlıdır.
30. Bireyseldir.
31. Heyecanlıdır.
32. İmmatürdür.
33. Bedensel yakınmaları vardır:
 - a. kalp
 - b. üriner sistem
 - c. gastrointestinal sistem
 - d. yorgunluk, bitkinlik, uykusuzluk
34. Kısa psikoterapiye iyi yanıt vermez.
35. Sorunlarına ilişkin kısmi içgörüsü vardır.
36. Entellektüalize ve rasyonalize eder.
37. Psikoterapide yapılan yorumlara direnç gösterir.
38. Terapistle karşı düşmanca duygular içindedir.
39. Pek çok hastadan daha uzun süre psikoterapide kalır.
40. Psikoterapide yavaş, ancak kalıcı bir gelişme gösterir.
41. Psikoterapide otorite konumunda olan kişilerle yaşadığı güçlüklerden, işteki başarısızlığından ve çalışma alışkanlıklarından, homoseksüel dürtülerle ilişkili kuşkularından söz eder.

Pt alt testinde düşük puan alan bir birey:

1. Korkular ve kaygılardan arınmıştır.
2. Kendine güven duymaktadır.
3. Geniş ilgi alanları vardır.
4. Sorumlu, gerçekçi, etkili, uyumludur.
5. Başarı, mevki ve tanınip bilinmeye ilişkin değerleri vardır.

84 T puanı ve üstü: Bireyin ajite ruminasyonları, korku hali, obsesyonları ve kompulsyonları ya da fobileri olduğunu göstermektedir. Anksiyete ve gerginlik o kadar fazladır ki günlük yaşamlarını bile devam ettiremezler. Entellektüalizasyon, izolasyon ve rasyonalizasyon sıklıkla kullanılmaktadır.

75-84 T puanı: Temiz, titiz, düzenli kişilerdir. Önemsiz sorunlar karşısında bile gerginlik ve endişe yaşarlar. Kendilerini yetersiz, aşağılık duyguları ve suçluluğu olan kişiler olarak gösterirler. Bu kendilerine güvenmemelerine bağlıdır, herhangi bir konuda fikir üretmezler. Obsesyonlar, kompulsyonlar ve fobileri dışlayınız.

60-74 T puanı: Bu yükseltileler dürüst, mükemmeliyetçi, titiz ve kendini eleştiren bireyler olduklarına işaret etmektedir. Küçük sorunları bile kendilerine dert edinme eğilimindedirler.

45-59 T puanı: Bu bireyler yaşamlarını ve işlerini endişe ve güvensizlik duymadan yürütebilirler.

20-44 T puanı: Rahat, duygusal, gerginliği olmayan bireylerdir. Çoğu kendine güvenir ve uyumludur. Üretici ve yeterlidirler. Kaygı düzeyleri çok düşük olduğu için sanki tembel gibi görünürler. Başarıya, statüye, kabul görmeye önem veren kişilerdir.

Sadece Pt alt testinin yükselmesi: Alt test 7'de yüksek puanlar, psikiyatrik grupta, genellikle kaygılı, gergin, kararsız ve dikkatini bir noktada yoğunlaştıramayan bireyleri tanımlamaktadır. Bu kişilerde obsesif düşünceler, ruminasyonlar, kendinden şüphe ve bunlara eşlik eden depresif özellikler vardır. Fobi ve kompulsif davranış, bu alt testte yüksek puan alan kişilerde görülebilmeye karşın, bu yüksek puanın karakteristiği değildir. Gerçekte, pek çok rijid kompulsif hasta alt test 7'yi yükseltmez. Çünkü bu kişilerin entellektüel savunmaları, anksiyetelerini ve güvensizlik duygularını kontrol edecek kadar güçlüdür. Daha çok entellektüel savunmaları, rasyonalizasyonları ve izolasyonlarıyla anksiyete ve gerilimlerini uzun süre kontrol edemeyen hastalar yüksek puan alırlar. Ayrıca alt test 7'deki yüksek puanlar bedensel işlevlere karşı aşırı ilgiyi gösterir. Bu kişilerin yakınmaları daha çok kardiyovasküler sistemde yoğunlaşır. Ayrıca gastrointestinal işlevlerle ilişkili yakınmalara da rastlanır. Bu kişilerin fiziksel yakınmaları, genellikle yüksek düzeydeki anksiyeteleri ve bu anksiyetenin fiziksel fonksiyonları üzerindeki etkisini yansıtır. Terapötik yardımlardan önce anksiyetelerinin semptomatik tedavisi gerçekleştirilmelidir.

Pt alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

- 71/17 Kodu (Bakınız 17/71 Kodu)
- 72/27 Kodu (Bakınız 27/71 Kodu)
- 73/37 Kodu (Bakınız 37/73 Kodu)

74/47 Kodu (Bakınız 47/74 Kodu)

Psikiyatrik hasta grubunda pasif agresif kişilik bozukluğu tanısı konulabilir. Kararsız, güvensiz kişilerdir. Sadece sinirli olduklarını belirtirler. Saldırganlıklarını kendilerine çevirdiklerinde depresyon görülür, ancak eylemevuruk davranışları da olabilir.

75/57 Kodu (Bakınız 57/75 Kodu)

76/67 Kodu (Bakınız 67/76 Kodu)

Bu hastalar kaygılı, endişeli, kuşkucudurlar. Kendilerini ve diğerlerini sürekli düşünürler, düşmanlık duygularını dolaylı yollardan ifade ederler. Gerçek paranoid değillerdir. Kişilik yapılarını değiştirmek zordur.

78/87 Kodu

Psikolojik yardım arayan kişilerde oldukça sık görülür, 2 ve 4 diğer yükselen alt testlerdir (Eğer 2 ve 4, 8 alt testinin 5 T puanı altındaysa 278/728 ve 478/728 ve 478/748 kodlarına bakınız). 78 ve 87 kodunu veren bireyler, psikotik ve nevrotik tanısı alabilirler. Yetişkinlerde 8 alt testi 7'den yüksekse, akut psikotik durum vardır. Ergenlerde 78 kodu 87 kodu kadar ciddi değildir.

Bu koddaki olan bireyler endişeli, kaygılı, gergin ve tekrarlayıcı ruminasyonları olan kişilerdir. Düşünce ve dikkatlerini toplama konusunda sorunları vardır. Stresleri o kadar fazladır ki, uykusuzluk ve intihar düşünceleri görülebilir. İntihar potansiyeli dikkatli bir biçimde değerlendirilmelidir. 8 alt testi, 7 alt testinden daha yüksekse intihar girişimi tuhaftır ve kendine zarar vermeyi içerir. Bireylerde hallüsinasyon ve delüzyonlar, duygudurumda sıklık ve gerçekte bağlantıda güçlükler olabilir. Diğer işlevlerde yıkım vardır, ancak bunlar psikotik davranışlar şeklinde değildir. Bu durumda olan hastalar ciddi düşünce ve davranış bozukluğunun yerleşmesine karşı koyarlar yani, şu andaki düşünce ve davranışları onları rahatsız etmektedir. Yakın kişilerarası ilişkiler kurmada güçlükleri vardır. Genelde içedönük ve çekiniktirler. Bu özellikler de onların obsesif ruminasyonlarını arttırmaktadır. Düşünce bozukluğunun var olup olmadığı araştırılmalıdır. Psikofarmakolojik müdahale bunların yoğun anksiyetelerini azaltmakta faydalı olabilir. Psikolojik müdahale güçtür, çünkü bunların psikolojik çatışmaları kroniktir ve bundan dolayı kişilerarası ilişki zorlukları vardır.

Karşı cinsle ilişkilerde kendilerini yetersiz hissederek. Yoğun kaygıya bağlı olarak cinsel performansları kötü olabilir. Bu bireylerin çoğu gevşemek için aşırı alkol alabilirler.

Olası tanı: 7>8: Birey düşünce ve davranış bozukluğu geliştirmemek için hâlâ savaş vermektedir.

7<8: Her iki yükselme de 75 T puanının üstünde ve 8 alt testinde belirgin bir yükselme varsa tanı şizofrenidir. Bu profilde nevrotik üçlüde düşüş olması beklenir. İntihar girişimi varsa tuhaf, kendini kesme ve cezalandırmayı içermektedir.

782 Kodu: Olası Tanı: Depresif Bozukluk. Obsesif Kompulsif Bozukluk

872 Kodu: Olası Tanı: Şizofrenik Reaksiyon

784/874 Kodu: Olası Tanı: Şizofrenik Reaksiyon, Şizoid Kişilik Bozukluğu

789 Kodu

Hostil, gergin, şüpheli, hiperaktif, huzursuz bireylerdir. Günlerini fanteziler ve hayal kurmayla geçirirler. Yansıtma ve regresyonu kullanır, uygunsuz duygudurum gösterirler. Sınırlı sosyal yaşantıları vardır. Diğerlerinden çocuksu tarzda ilgi ve sevgi beklerler, istekleri gerçekleşmediğinde ise gücenip, düşmanca davranırlar. Yakın duygusal ilişkiye giremezler. Kendilerine ilişkin grandiyöziteleri vardır, kendileri ile övünürler. Başarıya ulaşma isteklerinin çok fazla olmasına karşın orta düzeyde performans gösterirler.

79/97 Kodu

Bu oldukça az görülen bir koddur. 8 ve 4, üçüncü yükselen alt testidir. Bu bireyler ajitasyon düzeyinde kaygı yaşarlar. Korkuları vardır, olaylara aşırı tepki verirler, korkularına ve yetersizliklerine bağlı olarak kendilerini gevşetmeleri ve bunlardan kurtulmaları mümkün değildir ve aşırı ruminasyonlar gösterirler. Eğer 2 alt testi de yükselmişse depresyon görülür, ancak klinik tabloda anksiyete ve gerginlik ön plandadır ve hastalar sıklıkla fiziksel semptomlar (örneğin sırt ağrısı, kas spazmları ve uykusuzluk) getirirler. Bazı bireylerde manik örüntü vardır ve bu farmakolojik müdahale gerektirir.

Bu kodu alan ergenlerin yoğun ilgi gereksinimleri vardır, ancak kontrolü kaybedeceklerini düşünerek böyle bir şey yapmaktan kaçınırlar. Ayrıca ergenlerde bağımlılık, bağımsızlık çatışması çok fazladır.

794 Kodu

Bu hastalar kronik olarak kaygılı ve gergindirler. Yüksek enerji düzeyleri obsesif ruminasyonlarına katkıda bulunur. Konuşmalarının genellikle izlenmesi zordur, bağlantısız fikirler görülür. Impulsif dışa vurma dönemleri, suçluluk ve kendini aşağılama dönemleri birbiri ardına sıralanır. Diğer manik özelliklerin de birlikte görülüp görülmediği araştırılmalıdır.

70/07 Kodu

Bu profili veren kişiler utangaç, içedönük, sosyal becerilerden yoksun, gergin, ve endişelidirler, uykusuzluktan yakınır. Oldukça nadir görülür. 2 ve 8 alt testleri, en sık görülen üçüncü yüksekliktir.

Bu koddaki erkekler sosyal yetenekler ve/ya da fiziksel görünüşleri konusunda endişeli ve gergindirler, kendilerini yetersiz görürler. Çoğunluğu içedönüktür bu sözelleştirmeyi de engeller. Güvensizlikleri ve karar verme güçlükleri onları konfüzyonda bırakır, aşırı kontrollüdürler ve kendilerini suçlarlar. Ruminasyonları uykusuzluk ile sonlanır. Anneleri ve kardeşleri ile yoğun çatışmaları vardır. Sosyal alandaki yetersizlikleri, karşı cinsle olan ilişkilerini de etkilemektedir.

Kadınlarda eğer 5 alt testi, 40 T puanının altında ise aynı örüntü vardır. Bunlar yoksa sorunların ciddilik oranı daha azdır, kendilerinin ne olduğunun farkındadırlar. Fiziksel görünüm olarak çekici olmadıklarını düşünürler ve sosyal açıdan güvensizlik ve karşı cinsle rahat ilişki kuramama gibi sorunları vardır.

8. Şizofreni (Sc) Alt Testi

Şizofreni, bir aylık bir dönem boyunca bu sürenin önemli bir kesiminde hezeyanlar, hallüsinasyonlar, dezorganize konuşma, ileri derecede dezorganize ya da katatonik davranış, negatif semptomlar yani affektif donukluk, konuşamazlık gibi belirtilerden ikisinin bulunmasıdır. Şizofreni alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 15'de gösterilmiştir.

Tablo 15: Şizofreni alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü (Madde Sayısı: 78)

Doğru

15	16	21	22	24	32	33	35	38	40	41	47
52	76	97	104	121	156	157	159	168	179	182	194
202	210	212	238	241	251	259	266	273	282	291	297
301	303	305	307	312	320	324	325	332	334	335	339
341	345	349	350	352	354	355	356	360	363	364	

Yanlış

8	17	20	37	65	103	119	177	178	187	192
196	220	276	281	306	309	322	330			

K Eklemeli

Erkeklerde ortalama: 29.82, kadınlarda ortalama: 31.06
(Savaşır 1981)

Sc alt testinde yüksek puan alan bir birey (T: 80-100):
(Graham 1987)

1. Açık psikotik davranış gösterebilir.
2. Konfüzyondadır, dezorganize ve dezoryantedir.
3. Garip düşünce ve tutumları, delüzyonları vardır.
4. Hallüsinasyonları vardır.
5. Yargılaması kötüdür.
6. Şizoid yaşam biçimi sergiler.
7. Kendini sosyal çevrenin dışında görür.
8. Kendini izole, yabancılaşmış, yanlış anlaşılmış hisseder.
9. Arkadaşları tarafından kabul görmediğini düşünür.
10. Yalnız ve ulaşılmazdır.
11. İnsanlarla ve yeni durumlarla karşılaşmaktan kaçınır.
12. Utangaç ve çekirgindir, katılımcı değildir.
13. Yaygın anksiyete yaşar.
14. Kendini öç alıcı, hostil, saldırgan hisseder.
15. Duygularını ifade edemez.

16. Strese, hayal ve fantezi dünyasına çekilerek tepki verir.
17. Gerçekle hayaliyi ayırmada sorunu vardır.
18. Kendi ile ilgili kuşkuları vardır.
19. Aşağılık, yetersizlik, tatminsizlik duyguları vardır.
20. Cinsellikle ilgili düşünsel uğraşları vardır, cinsel kimliğine ilişkin rol karmaşası yaşar.
21. Alışılmamış, olağandışı, garip ve tuhaftır.
22. Belirgin olmayan ve uzun süredir devam eden psikolojik sorunları vardır.
23. İnatçı, kaprisli, dik kafalıdır.
24. Cömert, sakın ve duygusaldır.
25. İmmatür ve impulsiftir.
26. Maceraperesttir.
27. Zekidir.
28. Vicdanlıdır.
29. Çok sinirlidir.
30. İlgi alanının genişliğine bağlı olarak dikkat toplaması güçtür.
31. Yaratıcıdır ve hayal gücü zengindir.
32. Soyut, belirsiz amaçları vardır.
33. Sorun çözümüne ilişkin temel bilgilerin farkında değildir.
34. Psikoterapide prognozu kötüdür.
35. Terapistle anlamlı bir ilişki kurmak konusunda gönülsüzdür.
36. Pek çok hastadan daha uzun süre psikoterapide kalır.
37. Terapistte güven duyması zor olabilir.
38. Tıbbî yardım ve ilaç tedavisinden yararlanabilir.

Sc alt testinde düşük puan alan bir birey:

1. Arkadaşça, neşeli, duyarlı, güvenilirdir.
2. Dengelidir, uyumludur.
3. Sorumluluk sahibidir, bağımlıdır.
4. İlişkilerde tutucudur, derin duygusal ilişkiler kurmaktan kaçınır.
5. İtaatkârdır, uysal, otoriteyi açıkça kabul eder.
6. Temkinli ve geleneksel tutucudur, sorunlara yaklaşımında hayal gücünden yoksundur.
7. Pratik, somut düşündür.
8. Başarı, statü ve güçle ilgilidir.
9. Rekabet gerektiren durumlara girmekte gönülsüzdür.

100 T puanı ve üstü: Akut bozukluğun eşlik ettiği uzun süreli ciddi bir stresin sonucunda ortaya çıkar. Bu kişiler tipik olarak şizofren değildir. Daha çok akut psikotik reaksiyon içine giren hastalardır. Ayrıca kimlik krizindeki ergenlerde de bu ranja rastlanır. T>95'in üzerinde olan değerler akut durumsal stres ve ciddi özdeşim krizleri gösterir.

75 T puanı ve üstü: Yabancılaşma yaşayan ve doğru düşünemeyen bireyler tarafından verilir. Düşüncede ve hareketlerde sıradan değildirler, olasılıkla sosyal açıdan çekiniktirler ve derin kişilerarası ilişki kuramazlar. Kendilerinin kim olduğu ve bu dünyadaki yerlerinin ne olduğu konusunda oldukça bozuk düşünceleri vardır ve genellikle bu dünyaya ait olmadıklarını düşünürler. İletişim kurmada sorunlar temeldir, dezorganize düşünceleri vardır ve bunların açık ve mantıklı düşünmesini engeller. Bu bireylerin gerçek ile bağlantıları var gibi görünse de bu oldukça yüzeyseldir. Alt test 8'deki yüksek puanlar, gerçek psikotik düşünce bozukluğunu yansıtabilecek soğuk, apatik, yabancılaşma, düşünme, iletişim ve anlamada bozulma olması gibi özellikleri gösterebilir. Kişilerarası ilişkiler yerine hayalleri ve fantezileri yeğlerler. Aşağılık duyguları, kendinden hoşnutsuzluk ve yalnızlık duyguları içindedirler. T puanı 80'e yaklaştığında, mantıkta ve düşünmede tuhaflık belirginleşirler. Gerçek şizoid düşünce süreci gözlenir. Bunlara depresif özellikler ve psikomotor gerileme eşlik eder. Bu davranışlar ya şizofrenik bir sürecin ya da şizoid bir uyumun ya da uzun süreli ciddi bir stresin sonucu olabilir.

60-74 T puanı: Bu yükselme değerlendirilirken profilin tümü ele alınmalıdır.

1. Bu yükselmenin alt sınırında ve nevrotik profillerde yükselme varsa bu bireyin soyut konularla ilgilendiğini göstermektedir. Eğer Si alt testi de yükselmişse diğerleri tarafından uzak ve anlaşılmasız kişiler olarak tanımlanmaktadır.
2. 65-74 T puanı aralığındaki değerlendirmede genel bir yabancılaşma ya da örtük psikoz olup olmadığı

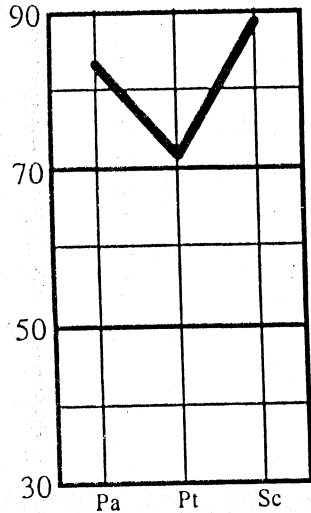
İlişkilerinde çekingen, derin duygusal ilişkilerden kaçınan, temkinli, tutucu, rekabet etmek istemeyen kişilerdir.

Sc alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

81/18 Kodu (Bakınız 18/81 Kodu)
82/28 Kodu (Bakınız 28/82 Kodu)
83/38 Kodu (Bakınız 38/83 Kodu)
84/48 Kodu (Bakınız 48/84 Kodu)
85/58 Kodu (Bakınız 58/85 Kodu)

86/68 Kodu

6 ve 8'in T puanı 80'nin üstünde, 7 de 70 T puanındadır. Bu profil psikiyatri hastalarında sıklıkla görülür. "Paranoid vadi" ya da "Psikotik V" olarak adlandırılır.



Bu örüntüyü gösteren hastalar, duygusal olarak geri çekilmişlerdir, sosyal izolasyon içindedirler, şüpheli, düşmanlık duyguları taşıyan ve davranışları hakkında içgörüsü olmayan kişilerdir. Ayrıca düşünce bozuklukları, hallüsinasyon ve delüzyonlara rastlanabilir.

Genellikle paranoid şizofreni tanısına uygundur. Bu örüntü, hepsini doğru yanıtlama şeklinde de ortaya çıkar.

Şekil 22:Paranoid Vadi

87/78 Kodu

Endişeli, kendi kendini tetkik edebilen, derin düşünceye dalan kişilerdir, kişilik güçlükleri kroniktir. Bağımsız, kendine güvenen kimseler olarak görünmezler, ancak daha çok pasif bağımlı olurlar. Cinsel sorunları vardır. Olgun ve yakın ilişkiler kuramazlar, öğrendikleri şeyleri bağdaştıramazlar.

8726/Yüksek 9 Kodu

Ajite şizofren bir hastayı göstermektedir.

89/98 Kodu

Bu kod tipi ergenlerde ve yetişkinlerde ciddi psikopatolojiyi gösterir. Benmerkezciler ve başkalarından çocuksu beklentileri vardır. Bu bireyler aşırı derecede idealize eden kişilerdir, günlerini fanteziler, hayal kurmalar ve ruminasyonlar ile geçirirler. Gerginlik, ajitasyon ve uykusuzluk vardır. Genellikle çok konuşma, davranışsal huzursuzluk, duygusal labilite ve fikir uçuşmaları görülebilir. Kişilerarası ilişki durumlarında (örneğin, terapi görüşmelerinde) konudan konuya atlarlar. Terapötik odaklaşma mümkün değildir. Kişilerarası ilişkilerinde özellikle karşı cinsle ilişkilerinde huzursuzluk, oldukça tipiktir. Bu bireyler yakın kişilerarası ilişkilerden korkarlar ve bu nedenle de bu tür ilişki kurmak istemezler. Stres altında dağılma belirtileri vardır. Kod daha da yükselirse delüzyon ve hallüsinasyonlar görülür, psikotik bir tablo ortaya çıkar. Yaşı 27'den küçük olanlarda görülür, üçüncü yükselen alt test 4, 7 ya da 6'dır.

Olası tanı: Şizofreni

Madde kullanımına bağlı psikoz

80/08 Kodu

Bu kod tipindeki 7 ve 2 alt tipleri en yüksek üçüncü koddur gerek. Genellikle uzak ve sosyal açıdan çekingen kişilerdir. Kişilerarası ilişkilerde hata yapmak istemedikleri için ilişki kurmaktan kaçınırlar. Kişisel fanteziler ile zamanlarını geçirirler. Sosyal izolasyonları o kadar fazladır ki kendi ailelerinden bile uzaklaşırlar. Bunun yanı sıra endişeli, kararsız, kaygılı, depresif ve diğerleri tarafından yanlış anlaşılan kişilerdir. Kendilerini neyin rahatsız ettiği, diğerlerinden ne istedikleri konusunda konfüzyonları vardır. Atılgan değillerdir. Danışmanlık görüşmelerinde genellikle konuşmazlar.

Olası tanı: Şizoid Kişilik

70-84 T puanı: Enerjik, konuşkan, eylemi düşünceye tercih eden kişilerdir. İlgiyi çok geniş bir alana yayılmıştır ve hemen gerçekleştirmek istedikleri çok sayıda projeleri vardır. Bu kişilerin çoğunda aktivite ve güç, abartılı düzeyde yüksektir, ancak projelerini tamamlayamazlar. Tipik olarak davranışlarını, düşmanlık duygularını ve öfkelerini kontrol edemezler. Gerçek manik özellikler gösterebilirler fikir uçuşması, duygudurumda kaymalar ve değişmeler, büyüklük sanrıları ve hiperaktivite gibi.

Ergenlerde bu yükselme, artmış hareketliliği gösterir. Impulsif ve kontrolsüzdürler. Grandiözite ve çağırışlarında artmalar vardır. İletişim güçlükleri ve suça eğilim görülebilir.

60- 75 T puanı aralığındaki puanlar enerjik, dışadönük ve aktif bireyleri gösterir. Bunlar, diğerleri tarafından hoş ve yeterli olarak görülürler. Bu düzeydeki puanlar lise ya da lise mezunu öğrencilerde çok sıktır, çünkü bu bireylerde enerji düzeyinin yüksek olması beklenen bir durumdur. Bu düzeyde puan alan kişiler onay ve statü kazanmak için çaba harcarlar ve düşünce ve davranışlarında özgür olma eğilimleri vardır.

60- 69 T puanı: Hoş, enerjik, meraklı, sosyal, kolay ilişki kuran, ilgi alanları geniş kişilerdir. Bu hallerinden kendileri de memnundur. İyimserlik, bağımsızlık ve kendine güven vardır.

45-59 T puanı: Normal aralığıdır. Puan normal aralıktan yükseldikçe mani düzeyinin arttığı düşünülür. Bu şekilde, puanlardaki artış maniye, giderek hipermaniye işaret eder. Manik hastalar davranışlarından kolaylıkla tanınabildiği için, alt test, daha çok ortalarda puan alan hastaların teşhisinde yardımcı olabilir.

21-44 T puanı: Düşük enerji düzeyi, güdü azlığı ve hatta apatiyi gösterir. Bu geçici yorgunluk ya da hastalığa işaret etmektedir. Düşük puanların çoğunluğu, kronik açıdan düşük enerji düzeyinin belirtisidir. Bireylerin kendilerine güvenleri azdır ve amaçları genellikle yoktur. Sabahları kalkmak istemezler ve herhangi bir projeye başlamakta kendilerini aşırı çaba göstermek zorunda hissederler. Özellikle 2 alt testinin yükselmediği durumlarda depresyon düşünülmelidir. Yaşlı insanlarda 9'un düşüklüğü beklenen bir durumdur, normal yaşlanma sürecini gösterir, 45 yaşın altında düşük olması beklenen bir durum değildir ve dikkat edilmesi gerekir.

Yalnızca alt test 9'u kullanarak bir yoruma gitmek güçtür. Diğer klinik alt testlerdeki yükselmelerle bu enerji artışının nedeni araştırılmalıdır. Alt test 9 la birlikte alt test 4'ü yükselen bir hastanın yorumu, alt test 8 ile 9'u birlikte yükseltmiş hastadan farklıdır. Bunlara ek olarak, beyin hasarı olan bir hasta, hiperaktivite ve tepkisel davranışlar gösterebilir. Yine bu hastalarda duygusal tepkiler depresyon şeklinde ortaya çıkabilir.

Ma alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

Yüksek 9/Yüksek K Kodu

Eğer 9 ve K alt testlerinde puanlar 70 T puanında (2 alt testi T: 50'nin altında ise) ise bu kişiler enerjik, organize, diğerlerinin kendileri üzerinde otorite kurmasını istemeyen kişilerdir. Genellikle bu kişiler çok iyi yöneticilerdir. Güç yönelimli bireylerdir, bunlar için belirsizlik, fikir üretmeme ya da çelişkili durumlar tahammül edilemez şeylerdir. Kendilerinin kontrol edemediği durumlarda ve bilgi verilmeyen, yapılanmamış durumlarda rahatsız olurlar.

Bireylerin çoğu yarışmacıdır. K alt testi 70 T puanının üzerine çıkarsa, kendi yaşamlarını ve çevrelerindeki diğer kişilerin yaşamlarını organize etme çabaları vardır. Kendilerini rahatsız ya da tehdit eden durumlarda bağımlı, itaatkâr, duygusal ve kontrolü kaybeden kişiler olabilirler. Bu bireyler diğerleri üzerinde kontrol koyarak onları kendilerine itaat ettirirler. Aslında bu bireyler temelde kendilerine güvensizdirler, rollerine, görünümüne sıkı sıkıya bağlıdırlar. Kadınlar fiziksel çekicilik konusunda teşhircidirler (eğer 5 alt testinde T:40'ın altında ise), böylece kendilerini kabul ettirir ve diğerlerini kontrol ettiklerini düşünürler.

Yüksek 9/Düşük K Kodu

Narsisistik kişilerdir. Kadınlar, eksibisyonist bir biçimde kendilerini sergileyerek dikkatleri bu şekilde üstlerine çekerler.

91/19 Kodu (Ayrıca 19/91 Koduna da Bakınız)

Ender görülmektedir. Hastalar hipomanik durumdadırlar, ancak gergindirler ve yerlerinde duramazlar. İhtiraslıdırlar. Başarısızlıkla engellenmişlerdir. Hipokondriak sorunlarıyla karşılaştıkları durumsal güçlükler arasındaki ilişkiyi ispattlamak kolaydır.

92/29 Kodu (Bakınız 29/92 Kodu)

93/39 Kodu (Bakınız 39/93 Kodu)
 94/49 Kodu (Bakınız 49/94 Kodu)
 Eyleme vuruk davranış ile ilgilidir
 95/59 Kodu (Bakınız 59/95 Kodu)
 96/69 Kodu (Bakınız 69/96 Kodu)
 97/79 Kodu (Bakınız 79/97 Kodu)
 98/89 Kodu (Bakınız 89/98 Kodu)

90/09 Kodu

Bu kod oldukça nadirdir, özellikle erkeklerde çok az görülür. Bu nedenle bilgi azdır. Bu koddaki bireyler enerjik ve olasılıkla ajitedirler. Genellikle yalnız kişilerdir. Bu kodda Si alt testinin yükselmesi bırakılarak yorum, yükselen diğer iki alt test ile yapılmalıdır. Daha sonra eğer gerekirse Si alt testi yorumlanmalıdır.

0. Sosyal İçedönüklük (Si) Alt Testi

Standart MMPI profiline sonradan eklenmiş bir alt testtir. İçedönüklük (Introversion) ve dışadönüklük (Extraversion) üzerinde çok çalışılmış bir kişilik boyutudur. Bu alt test içedönüklüğün yalnızca bir boyutunu, sosyal ilişkilerdeki içedönüklüğü ölçmeyi amaçlamaktadır. Diğer alt testlerden daha farklı olarak geliştirilmiştir. Si alt testini oluşturan maddeler ve puanlama yönü Tablo 17'de gösterilmiştir.

Tablo 17: Sosyal içedönüklük alt testi: Madde numaraları ve puanlama yönü

(Madde Sayısı: 70)

Doğru

32	67	82	111	117	124	138	147	171	172	180
201	236	267	278	292	304	316	321	332	336	342
357	377	383	398	411	427	436	455	473	487	549

564

Yanlış

25	33	57	91	99	119	126	143	193	208	229
231	254	262	281	296	309	353	359	371	391	400
415	440	446	449	450	451	462	469	479	481	482
505	521	547								

Erkeklerde ortalama: 26.86, kadınlarda ortalama: 29.88

(Savaşır 1981)

Si alt testinde yüksek puan alan bir birey : (Graham 1987)

1. Sosyal açıdan içe çekilmiştir.
2. Yalnızdır ya da çok az arkadaşla rahattır.
3. Ürkek, çekingen, temkinli, utangaçtır.
4. Karşı cinsten kişilerin olduğu ortamlarda rahat değildir.
5. Kendini küçük görür.
6. Anlaşılmaz zor biridir.
7. Diğerlerinin düşüncelerine duyarlıdır.
8. Diğer insanlarla ilişkiye giremediği için üzülür.
9. Aşırı kontrollüdür, duygularını açıkca dile getirmekten hoşlanmaz.
10. İtaatkar, uysal ve boyun eğicidir.
11. Otoriteyi kabul etmede aşırıdır.
12. Ciddidir, kişisel temposu yavaştır.
13. Güvenli, bağımlıdır.
14. Temkinlidir, sorunlara yaklaşımı sıradandır.

15. Tutumlarında ve düşüncelerinde katı ve tutucudur.
16. Küçük fikirler üretmede bile güçlüğü vardır.
17. Çalışmayı sever.
18. Endişeye eğilimlidir, sinirli ve kaygılıdır.
19. Karamsardır.
20. Suçluluk duyguları, depresyon dönemleri yaşar.

Si alt testinde düşük puan alan bir birey:

1. Sosyaldır, dışadönüktür.
2. Açık yürekli, arkadaşça, konuşkandır.
3. Diğer insanlarla birlikte olmak için güçlü bir isteği vardır.
4. Kolay kaynaşır.
5. Zekidir, kendini ifade edebilir.
6. Aktif, enerjik ve gayretlidir.
7. Güç, mevki ve tanınmak ister.
8. Mücadele edecek ortamlar arar.
9. Impuls kontrolüyle ilgili sorunları vardır.
10. Eylemlerinin sonuçlarını düşünmeden davranır.
11. İmmatürdür, kendini düşünür.
12. Yüzeysel ve insanlarla ilişkileri yapmacıktır.
13. İnsanları kullanır ve fırsatçıdır.
14. Diğerlerinde hostilité ve öfke uyandırır.

Psikiyatrik ve normal popülasyon için alt test Si'de alınan yüksek puanlar benzer şekilde tanımlanır. Sosyal olarak içedönük utangaç ve geriçekilmiş kişiler olarak değerlendirilir.

Alt test Si'deki puanlar yaşla birlikte artar. Ergenler ve yüksekokul öğrencileri, genellikle 40 ile 50 T puanlık bir aralıkta yer alırken yaşlı kişiler 50 ile 60 T puanı arasında yer alırlar. Alt test Si, evlilik ilişkileri üzerinde tahminler yapmaya yararlıdır. Alt test Si'de 20 puanlık bir farklılık olan çiftlerin, sosyal ilişkiler açısından evlilik çatışmalarına düşmeleri olasıdır. Alt test Si'deki yükselmeye, alt test 4 ve 9'daki yükselmeler de eşlik ediyorsa, eyleme vurukluğun bastırıldığı düşünülmelidir. Alt test 2 ya da 7 özellikle alt test 8'in eşlik ettiği durumlarda, ruminatik davranışların kuvvetlendiği görülür.

70 T puanı ve üstü: Sosyal açıdan beceriksiz olan kişilerdir. Sosyal ilişkilerde anksiyete yaşar ve ilişki kurmaktan kaçınırlar. Nevrotik üçlüde yükselme görülebilir. (Ayrıca bakınız, 2, 7 ve 8 alt testlerinin yükselmesi.)

60-69 T puanı: Bu kendini ortaya koymak istemeyen, yakın aile çevresinde rahat olan bireylerin profilidir. Çekingen, utangaç kişilerdir.

45-59 T puanı: Sosyal ilişki kurmada başarılı olan bireylere işaret etmektedir.

25-44 T puanı: İyimser, manipülatif, yüzeysel ve hatta biraz uçuk bireylerdir. Dürtü kontrol sorunları vardır. Diğerleri ile olmak isteyen, yalnız kalamayan bireyleri gösterir. Çoğu kolay ilişki kurar, arkadaş canlısı ve meraklıdır, sosyal açıdan kabul görme, onaylanma konusunda gereksinimleri çok fazla olan bireylerdir..

Si alt testinin diğer alt testlerle ilişkisi:

- 01/10 Kodu (Bakınız 10/01 Kodu)
- 02/20 Kodu (Bakınız 20/02 Kodu)
- 03/30 Kodu (Bakınız 30/03 Kodu)
- 04/40 Kodu (Bakınız 40/04 Kodu)
- 05/50 Kodu (Bakınız 50/05 Kodu)
- 06/60 Kodu (Bakınız 60/06 Kodu)
- 07/70 Kodu (Bakınız 70/07 Kodu)
- 08/80 Kodu (Bakınız 80/08 Kodu)
- 09/90 Kodu (Bakınız 90/09 Kodu)

049 Kodu

Psikiyatrik olgularda eyleme vurukluğun bastırılması

027(8) Kodu

Ruminatik davranışların kuvvetlenmesi.

6. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterini Yorumlama Yaklaşımı

MMPI profilini yorumlamadan önce testi veren kişi, değerlendirme için gönderilen bireyin bazı özelliklerini dikkate almalıdır. Hiçbir zaman körlemesine bir değerlendirme yapılmamalıdır. İlk aşamada testi alan kişinin demografik özellikleri belirlenmelidir: Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, meslek, gibi.

Genel olarak MMPI yorumları, zekâ düzeyleri 80'in üzerinde olan yetişkinlere yöneliktir. Eğitim düzeyi olarak ortaokul kabul edilmektedir. Bu değişkenlerin bazıları belli kodları yorumlamada önemli olmaktadır. MMPI alt testlerinin bazıları yaştan etkilenmektedir. Örneğin, Hs ve D alt testlerde yaşın ilerlemesi ile yükselme olduğu saptanmıştır.

Ayrıca bireyin başvuru nedenleri ve geçmiş öyküsü de MMPI'yi değerlendirmede yararlı olabilir. Bazen birey "anlaşılması zor" olarak değerlendirme amacıyla gönderilmektedir, eğer değerlendirme yapan kişi MMPI geçerlik testlerinden K alt testini bu bireyin profilinde yüksek bulursa "anlaşılması zor"un ne anlama geldiğini açıklayabilir. Bu bireyin aşırı kontrolünü kaldıracak olası terapötik yöntemler için yol gösterici olabilir.

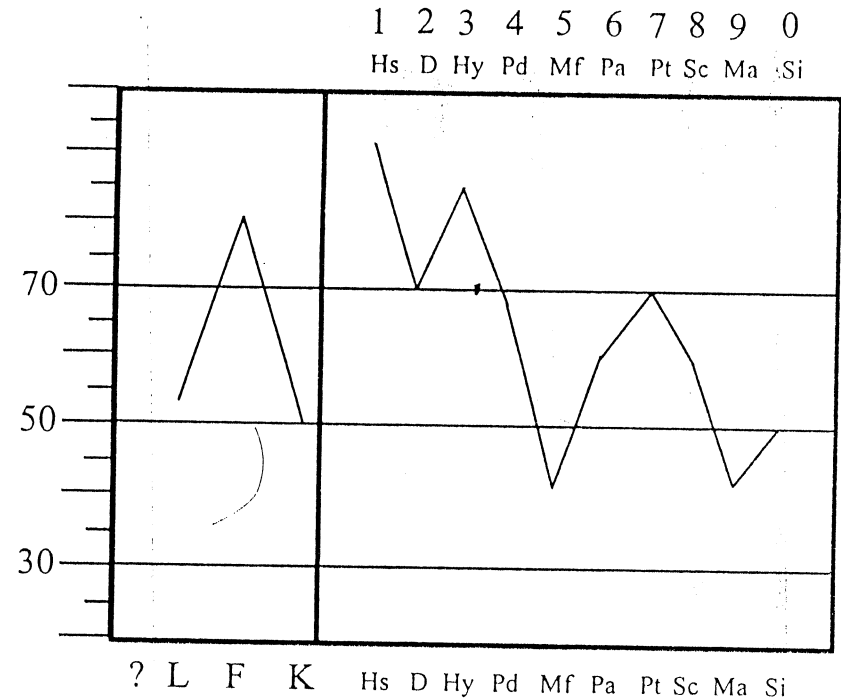
Hasta psikiyatri kliniğinde yatıyor ya da ayaktan izleniyorsa hastanın psikopatolojisinin ne olduğunun bilinmesi önemlidir.

Kod tipini belirleme

MMPI profilini değerlendirmede bu alanda eğitim almamış bir kişinin kod tipini belirlemesi oldukça zordur. Ancak klinik testlerde belirgin yükselmenin olduğu durumlarda bu kolaylıkla görülebilir. Yükselmenin hepsi 70 T puanına yakın ya da bunun üstündedir. Bunun yanı sıra ikili ve üçlü kodları belirlemede, hastadan alınan bilgi ve testi veren kişinin deneyimi önemlidir.

MMPI'da bazı profil örüntüleri ise kesin olarak saptanmıştır. Sıklıkla ortaya çıkan bu profiller aşağıda verilmiştir:

1. Konversiyon V: Bu profil örüntüsü ayrıntılı olarak nevrotik üçlü konfigürasyonlarında anlatılmıştır. Burada sadece hatırlatma yapılacaktır. Test Hs ve Hy, D alt testinden 10 ya da daha fazla T puanı yüksektir ve Hs ve Hy en az 70 T puanındadır. Bu klasik konversiyon V'de diğer alt testler de yükselir, ancak bu Hs ve Hy kadar değildir.

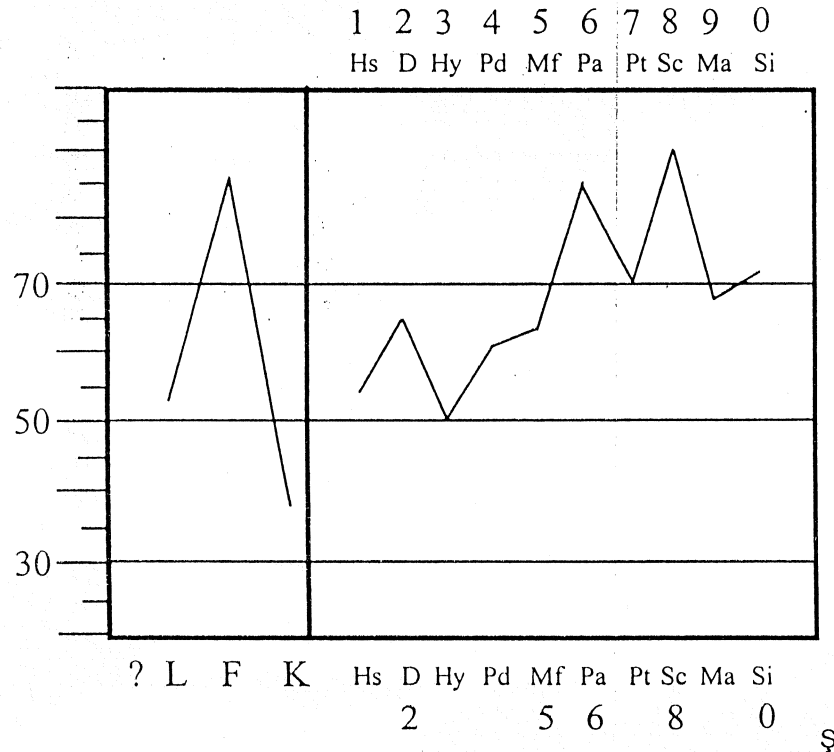


Şekil 23: Konversiyon V ya da Psikosomatik V

Olgu: Hasta 38 yaşında doktor yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji saptanmamasından sonra "yolun sonu" denilerek psikiyatriye gönderilmiş. Hasta yoğun mide yakınmaları getiriyor. Kendisinde kalın barsakta karsinom olduğunu düşünüyor ve haftada bir kez kan tetkiki yapmakta ve 2-3 günde bir yatarak 15- 20 dakika karın bölgesini muayene etmekteymiş. Tıp fakültesinde okurken kendisini bulduğu semptomları arkadaşları ile paylaşmış ve çok rahatlamış çünkü onlarında

patolojide öğrendikleri hastalıkların kendilerinde olabileceği konusunda endişeleri varmış. Tıp fakültesini bitirdikten sonra yineleyici biçimde aynı endişeleri yaşıyormuş. Bu doktorun semptomlarının herhangi bir genel tıbbi bozukluğun nedeni olmadığı açıktır. Hastada varolan somatik yakınmalar herhangi bir tıbbi durumla açıklanamamaktadır. Hastanın MMPI profilinde de Hs alt testinin bu düzeyde yükselmesi bedensel yakınmalar ile çok fazla uğraşan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak iş yapma istekleri azalmıştır, yakınmalarının bedensel kaynağını sürekli bir biçimde araştırır. Sıklıkla benmerkezcil ve narsisistiktir, sürekli şikayet eder ve sızlanırlar. Yakınmalarını diğerlerine kabul ettirme eğilimleri çok fazladır, bu nedenle aşırı talep edici bir tutum içindedirler.

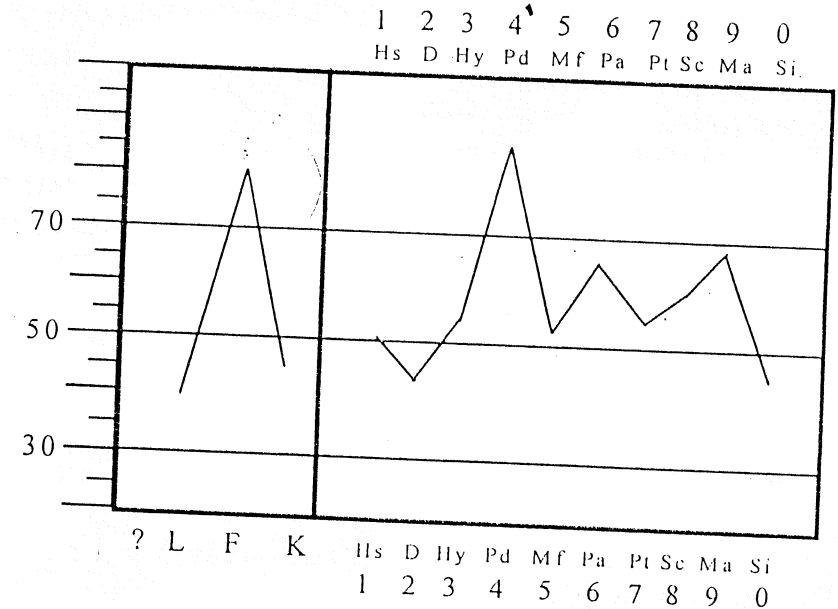
2. Paranoid V: Pa ve Sc alt testleri 80 T puanında, Pt alt ölçeği ise 70 T puanındadır. Bu profil örneğine ilişkin ayrıntılı bilgi Sc alt testinin yorumlanmasında verilmiştir.



Şekil 24: Paranoid V, Psikotik V

Olgu: 42 yaşında erkek hasta "yaşamımı kontrol ediliyor" şeklinde ısrarı nedeniyle psikiyatriye getirilmiş. Postacı olarak çalışan hastanın amiri iki ay önce bir paketin değiştirilmesinden dolayı onu suçlamış daha sonra etrafındaki söylentilerden kendisinin temize çıktığını anlamış. Yaklaşık iki hafta sonra iş arkadaşlarının kendisinden kaçtıklarına dikkat etmiş. "Onlara doğru yürüdüğümde arkalarını dönüyorlardı sanki beni görmek istemiyorlardı" diyor. Bir süre sonra da iş yerinde kendisi hakkında konuşulduğunu hissetmeye başlamış. Ne söylediklerini anlamıyormuş ancak müdürü onun yaşamını kontrol ediyormuş. Hastanın böyle bir inanç geliştirmesinde hiç bir neden bulunmamaktadır. MMPI profiline göre bu hastalar duygusal olarak geri çekilmişlerdir, sosyal izolasyon içindedirler, şüpheli, düşmanlık duyguları taşıyan ve davranışları hakkında içgörüsü olmayan kişilerdir. Ayrıca düşünce bozuklukları, hallüsinasyon ve delüzyonlara rastlanabilir. Yetişkinlerin çoğunluğu işlerini devam ettirirler, bu da oldukça şaşırtıcıdır. Yalnız herhangi bir dış etkenle bağlantılı olmadan yorgunluk, yetersizlik ve konsantre olamama ile belirgin psikotik dönemler görülür.

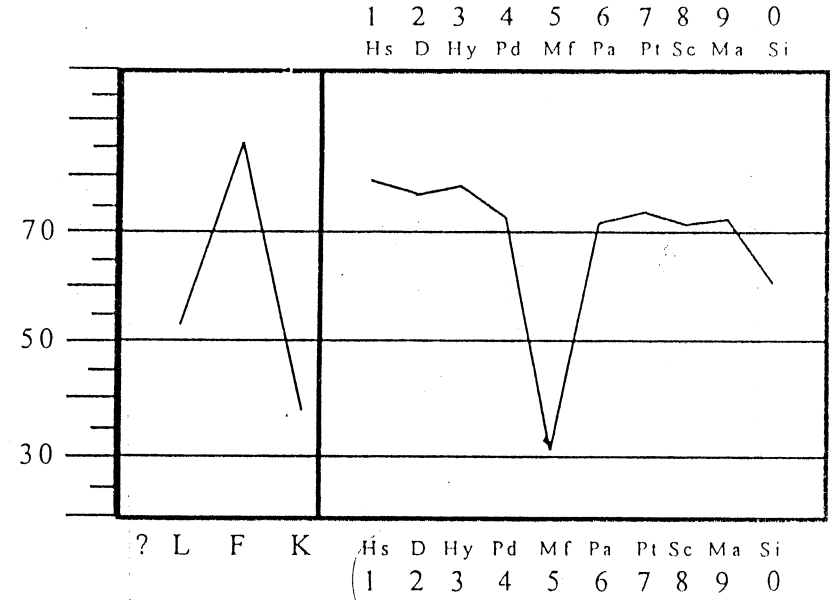
3. Pd alt testinin yükselmesi: Pd alt testi 70 T puanının üstündedir ve bütün alt testlerden en az 10 T puanı yüksektir.



Şekil 25: "Pd Yüksekliği" Profili

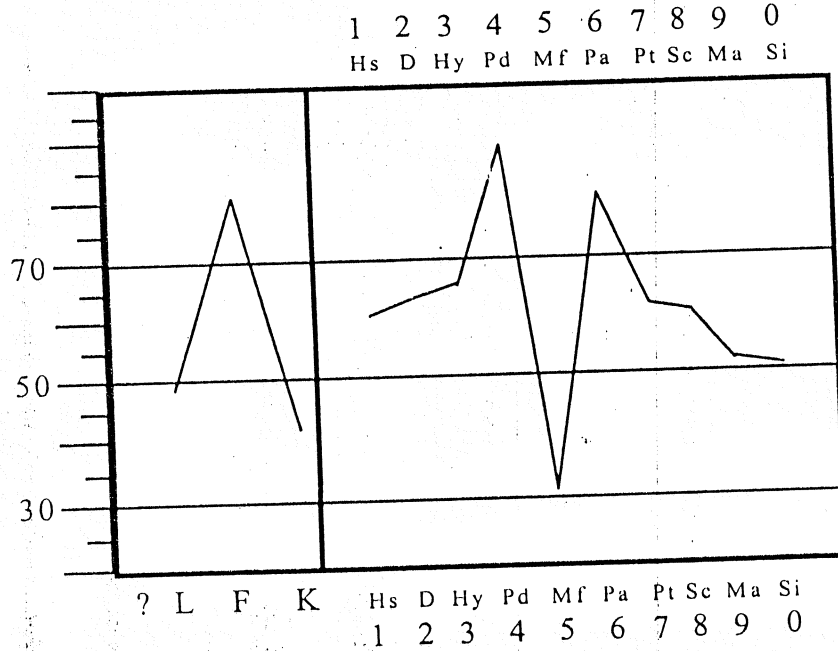
Olgu: Hasta 21 yaşında. Fizik olarak sağlıklı ve canlı. Nazik bir tavırla konuşuyor. İşlediği suç nedeniyle akıl sağlığının değerlendirilmesi için gönderilmişti. Kendisinde bir tür [akıl] hastalığı bulunduğu kanıtlanırsa ceza almayacaktı. Çocukluk döneminde okulda uyumsuz bir çocuk olan hasta 14-15 yaşlarında hırsızlık yapmaya başlamış, yakalandığında yaşı küçük olduğundan ıslahevine gönderilmiş. Cezası bittiğinde kendisine bir iş bulmuş. Amirleri onu başlangıçta canlı, parlak ve iş yapma konusunda çok hevesli biri olarak görmüşler. Kısa sürede nedenini açıklamadan günlerce ortadan kaybolmaya başlamış ve işe döndükten sonra oldukça inandırıcı özürler getiriyormuş. Bir süre sonra hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmaya başlamış. Döndükten sonra o süre içinde çalışmaya istekli olmadığını söylemek dışında herhangi bir açıklama yapmıyormuş. Zaman zaman toplu yerlerde kavga çıkarmak, karışıklık yaratmak ya da toplumun huzurunu bozacak davranışlar yapmaktan tutuklanmış. MMPI değerlendirildiğinde bu tür profil veren kişilerin impulsif, küskün, isyankâr ve genelde kurallar, düzenlemeler ve otoriteyi kabullenmekte güçlükleri olan bireyler olduğu görülmektedir. Sıklıkla yasal sorunları olabilir. Bunlar sokulgan (insan canlısı) olabilirler ancak diğerleriyle ilişkileri, yüzeysel yapay ve kısadır. Uzun süren, yakın ilişkiler kuramazlar, çünkü bunlar birliktelikle ilgili empati, sorumluluklar ve talepler konusunda güçlükleri olan bireylerdir. Uzun süreli hedeflere doğru organize davranışları sürdüremezler ve bunun yerine doyum veren kısa süreli istekler üzerinde odaklaşma eğiliminde olurlar.

4. "Kuş Kanadı" Profili: Bu nevrotik testlerle birlikte Pd alt testinin de yükseldiği profildir. Hs, D, Hy ve Pd testleri 70 T puanına yükselmiş ve kadınlarda Mf alt testi 50 T puanındadır. Psikotik testlerde de yükselme vardır. Bu yükselme kuş kanadına benzediği için profil bu adı almaktadır.



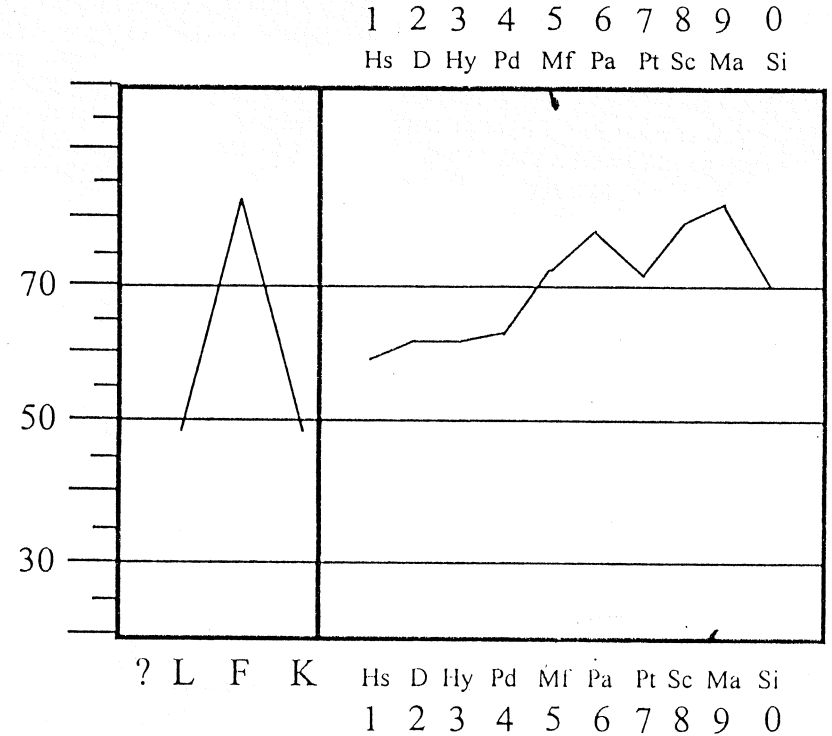
Şekil 26: "Kuş Kanadı" Profili

5. Pasif-Agresif V (Kadınlarda) 4 ve 6 70 T puanında ya da üstünde, Mf alt testi 50 T puanının altındadır. Diğer alt testler 70 T puanında olsa bile bu pasif-agresif kişilik bozukluğudur.



Şekil 27: Pasif-Agresif V (Kadınlarda)

6. Psikotik Yükselme: Mf alt testinden çizilen dikey bir çizgi MMPI'ı nevrotik (profilin sol tarafı) ve psikotik (profilin sağ tarafı) olarak ikiye böler. Pozitif eğim, psikotik testlerin 70 T puanının üstünde olması, nevrotik testlerin 70 T puanının altında kalmasıdır.

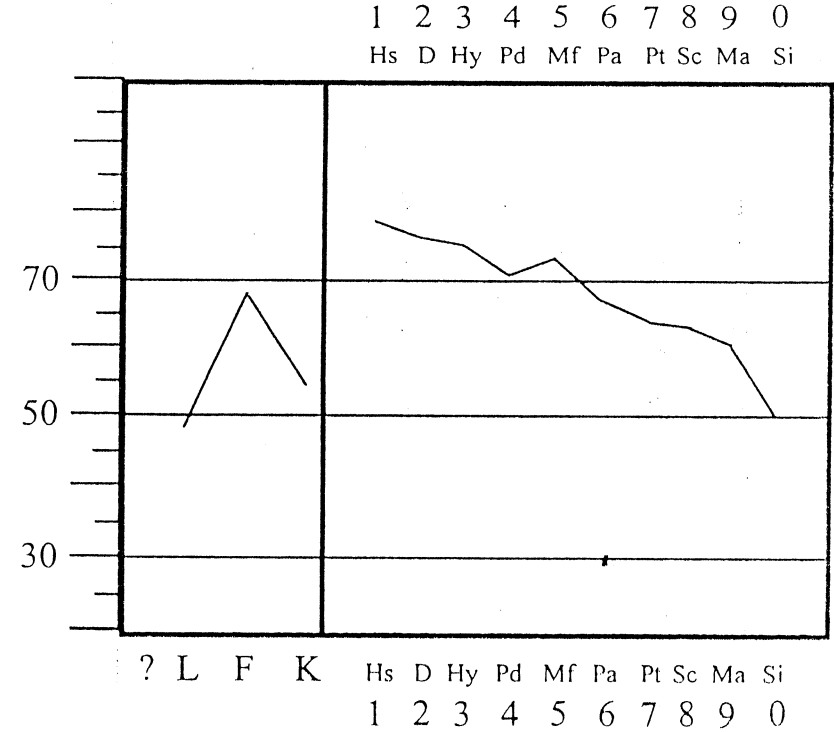


Şekil 28: "Psikotik" ya da pozitif eğim

Olgu: Erkek hasta 40 yaşında. Hastaneye kendisinden korkan annesi tarafından getirilmiş. Bu hastaneye 6. yatışıymış. Duygulanımda annesine yönelik öfke belirgin. Görüşme sırasında kıkır kıkır gülüyor, konuşması ve tavırları çocuksu, kırıtarak yürüyor ve abartılı kalça

hareketleri var. Annesi ilacını bir aydır almadığını, sesler duyduğunu, bakışlarının ve hareketlerinin garipleştiğini söylüyor. Ne yaptığı sorulduğunda "gözlerimi kırıyorum ve ışıkları yakıyorum" diyor. 16 yaşında okumak istemediğini belirterek okulu bıraktıktan sonra hastaneye yatırılmış ve bundan sonra okumamış ve çalışmamış. Hastanede ilaçla tedavi edilmiş ancak hastaneden çıktıktan sonra ilaçlarını kesmiş ve kısa sürede dezorganize olmuş. Bu tür MMPI profili veren bireylerde hallüsinasyon ve delüzyonlar, duygudurumda sıklık ve gerçekte bağlantıda güçlükler olabilir. Diğer işlevlerde yıkım vardır, ancak bunlar psikotik davranışlar şeklinde değildir. Düşünce bozukluğunun var olup olmadığı araştırılmalıdır. Psikofarmakolojik müdahale bunların yoğun anksiyetelerini azaltmakta faydalı olabilir. Psikolojik müdahale güçtür, çünkü bunların psikolojik çatışmaları kroniktir ve bundan dolayı kişilerarası ilişki zorlukları vardır.

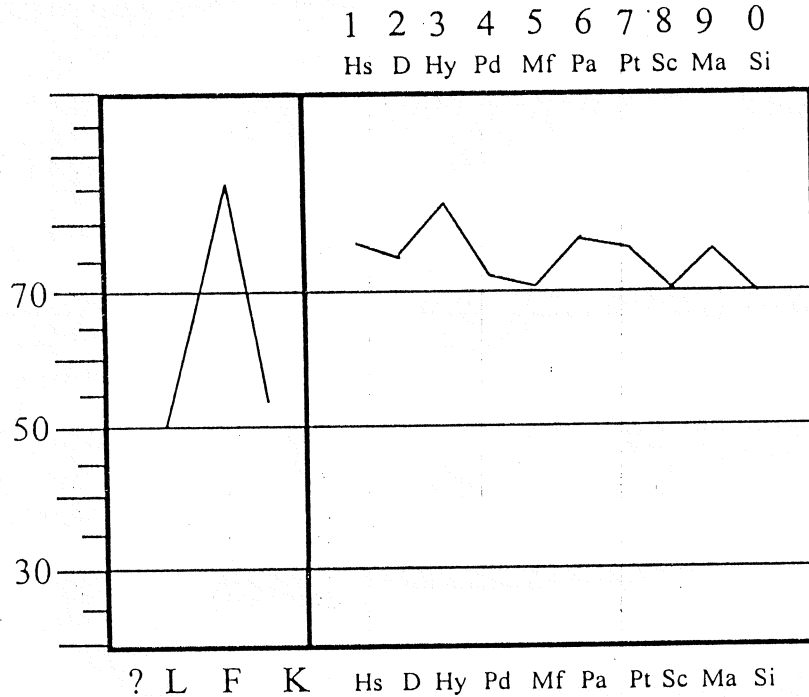
7. Nevrotik Yükselme: Negatif eğim, ise profilin sol ya da nevroitik bölümünün yükselmesi ve psikotik testlerde belirgin düşüklük olmasıdır. Bu nevroitik bir uyumu göstermektedir.



Şekil 29: "Nevrotik" ya da negatif eğim

Sadece bu tür yükselmelerle testi alan kişiye nevroitik ya da psikotik tanısının konulması doğru değildir. Bu nedenle profile ilk bakıldığında psikotik ya da nevroitik profil olduğuna karar verildikten sonra ayrıntılı değerlendirme yapılmalıdır.

8. "Yüzen" Profil: Bu profilde Hs'den, Ma'ya kadar olan bütün değerler 70 T puanının üstündedir ve buna F alt testindeki yükselme eşlik eder. Bu profil borderline kişilik bozukluğu olan kişilere özgüdür.



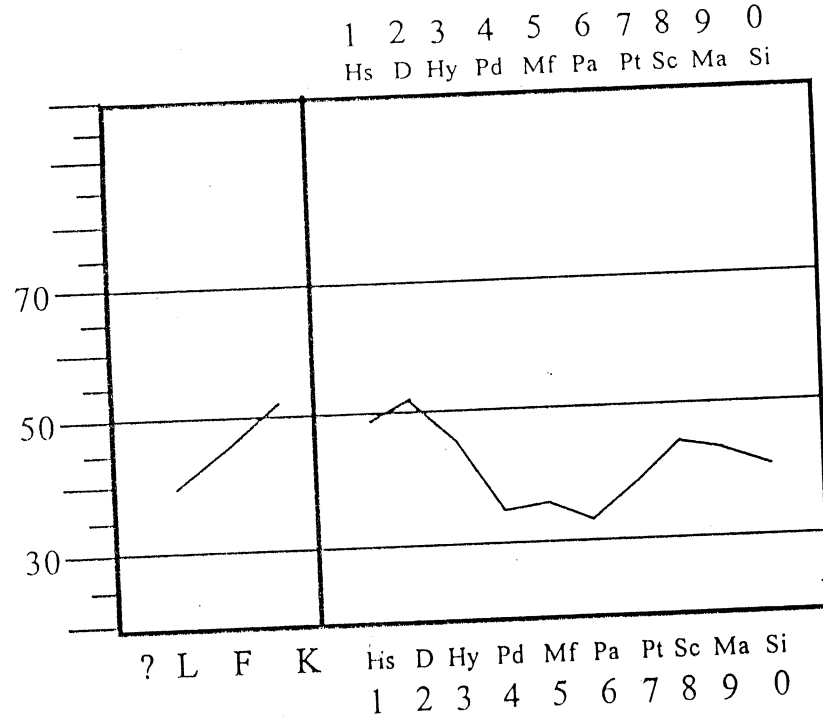
Şekil 30: "Yüzen" Profil

Bu profil tipiyle bağlantılı bir kod tipi verilemez. Borderline kişilik bozukluğu olan hastalar bu tür bir profil verebilirler.

Olgu: Bayan hasta 23 yaşında ilk kez hastaneye yatırılıyor. Görünüşte geceleri iyi uyuyabilmek amacıyla ağır bir şekilde içmeye başlamış. İçtiği sırada bir seri "bir gecelik ilişki" yaşamış. Başvurmadan iki hafta önce bedeninin ayrıldığını hissetmiş ve büyük bir panik yaşamış. Bu durumda iken bir ses "kendini köprüden at" diyormuş. Hemen sonra yardım istemiş. Durumunun kötü olduğunu ve kolunda bir kesi izi olduğunu gören doktor kendisini psikiyatriye göndermiş. Ergenlik döneminden beri yalnızlık, yetersizlik ve kısa depresyon ile anksiyete duyguları yaşadığı dönemler geçirdiğini anlatıyor. Son zamanlarda kendisini ve küçük bir bebeği bıçakladığı şeklinde fantazileri varmış, "Herkes için geçirgenliği olan boş bir kabuk" olmaktan yakınıyordu. MMPI profiline göre bu kod tipindeki bireyler sinirlilik, hostilité, şüphelenme ve olasılıkla referans fikirlerinin yanı sıra yoğun sıkıntı yaşamaktadırlar. Hem yetişkinler, hem de ergenler için bu kod tipi, marjinal sosyal uyumu olan ve kendini diğer insanlardan farklı hisseden bireylerde görülür. Aşırı alkol alma, ilâç kötüye kullanımı görülmesine karşın bunları kullanma bağımlılık düzeyinde değildir. Duygusal olarak diğer insanlar tarafından öngörülemez olarak değerlendirilirler. Sosyal yargılamanın kötü olması, uyumsuzluk ve impulsivite, dışa vurma olasılığının artmasına neden olur. Kadınların sıklıkla yaşadığı hamilelikleri ve her alanda başarısız olan erkeklerle ilişki kurma öyküleri vardır ve sıklıkla yeterlilikleri sınırlıdır. Bu kadınların benlik değerleri düşüktür ve daha az yeterli görünen kimselerle daha rahat ederler. Genellikle başkalarına cinsel olarak yaklaşmayı tercih ederler ve duygusal yakınlıktan kaçınır gibidirler.

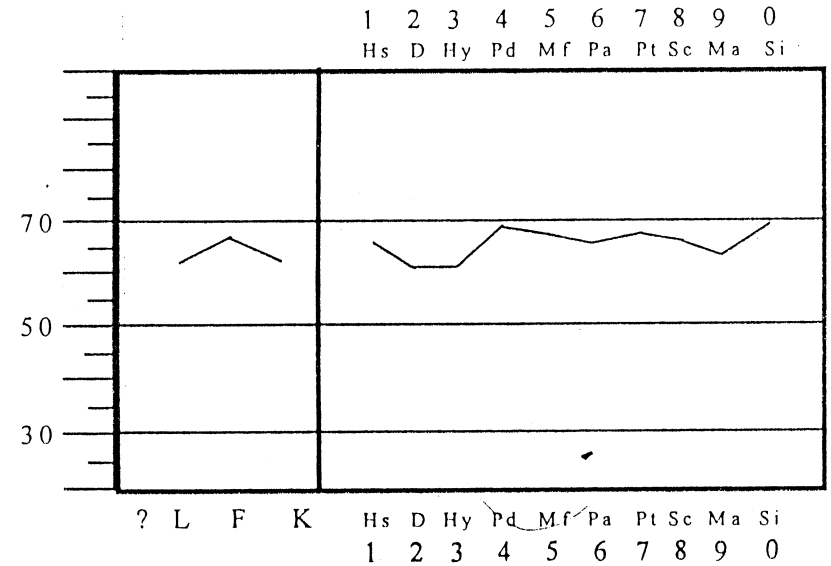
MMPI'ı değerlendirirken testlerin T puanlarına göre de değerlendirme yapılabilmektedir. Buna ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

9. Batık Profil: Profilin 45-54 T puanı arasında yer alması: Yorum yapmak zordur. Tek başına bu tür bir yükselmenin anlamı yoktur. T puanlarının en düşük olduğu alt testlere bakmak gerekmektedir.



Şekil 31: Batık Profil

10. Sınır profili: T puanı 60-70 arasındadır. Geçerlik testlerinde bir yükselme vardır, ancak bu tam bir yükselme değildir. Klinik alt testlerdeki T puanları 54 T puanının üstündedir. Bu aradaki yükselmeler semptom belirtmez, daha çok kişilik özelliklerini gösterir. Alt testlere özgü semptomlar aynı olmasına karşın bireyin 60-70 T puanı aralığındaki profili bu özelliklerin onun kişilik yapısının bir parçası olduğuna işaret etmektedir. Eğer klinik testler 60-64 T puanı arasında ise MMPI'dan geliştirilen diğer testler bireyi değerlendirmede daha yararlı olabilir (Butcher 1984).



Şekil 32: Sınır Profili